



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN JUNI
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan
Telp. 0343 - 6745000
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Bab I Pendahuluan..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 1

Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo 2

2.1 Visi 2

2.2 Misi..... 2

2.3 Motto 2

2.4 7 Nilai Budi Utama 2

2.5 Struktur Organisasi..... 3

Bab III Laporan Kinerja Pelayanan 5

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)..... 5

3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 5

3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO..... 5

3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut 5

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada 5

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan 5

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik 5

3.3.2 Rawat Inap..... 5

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)..... 5

3.3.4 Maternitas 5

3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD)..... 5

3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO) 5

3.4 Kinerja Bidang Penunjang 7

3.4.1 Instalasi Farmasi..... 7

3.4.2 Laboratorium..... 7

3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran 7

3.4.4 Radiologi 7

3.4.5 Gizi..... 7

3.4.6 CSSD - Laundry 7

3.5 Kinerja Umum dan Keuangan..... 8

3.5.1 MFK dan K3RS 7

3.5.2 Security 7

3.5.3 Parkir 7

3.5.4 Humas Marketing 7

3.5.5 Penjaminan 7

3.5.6 PIPP – MOD - MPP 7

3.5.7 *Cleaning Service* 7

3.6 Komite dan Tim 7

3.6.1 Komite Mutu 7

3.6.2 Komite PPI 7

3.6.3 Tim PKRS..... 7

3.6.5 Tim Prognas 7

3.7 Klaim Pending 10

3.7.1 Analisis 10

3.7.2 Tindak Lanjut.....	10
3.8 Permasalahan Rumah Sakit.....	44
3.9 Profil SDM	48
3.9.1 Komposisi dan Distribusi SDM.....	48
3.9.2 Update STR/SIP	51
3.10 Kemajuan Piutang	52
3.10.1 Data Piutang yang Belum Terbayar	52
3.10.2 Analisa Progres Penyelesaian Piutang	53
3.10.3 Update IKS	54
Bab V Kesimpulan dan Saran	104
Bab VI Penutup	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Juni Tahun 2025 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

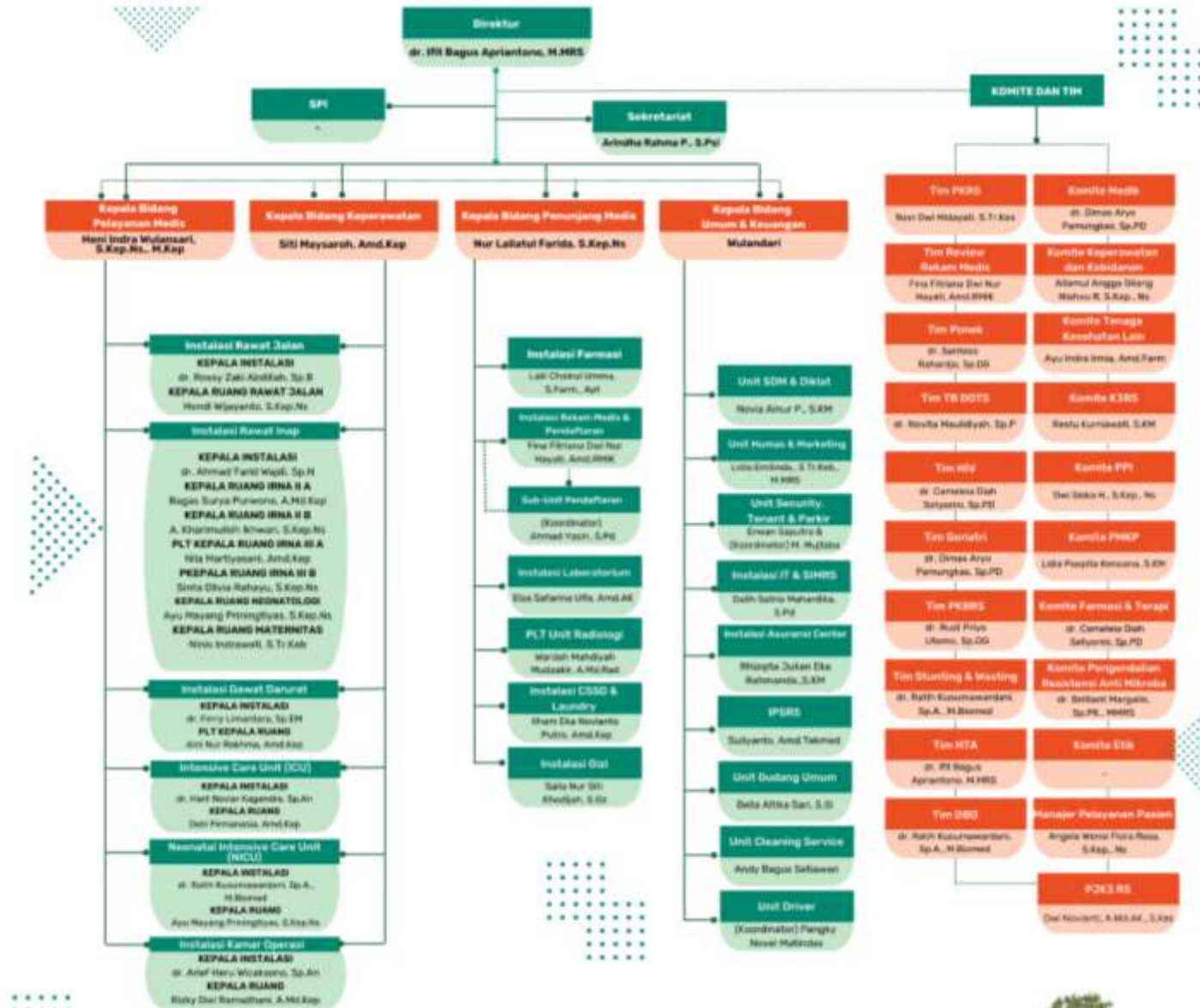
Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur
2. Dipercaya
3. Tanggung Jawab
4. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

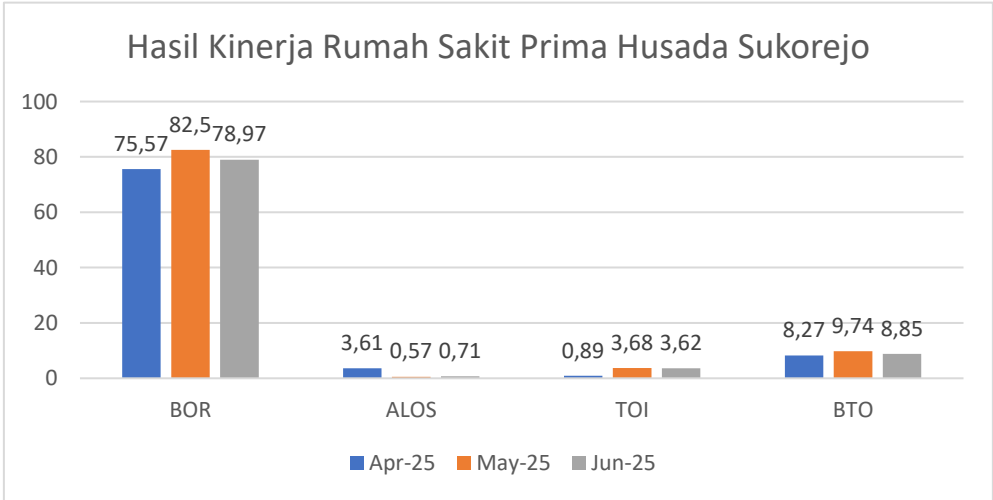
Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sebagai berikut :



BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT,BOR,ALOS,BTO,TOI)

3.1.1 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO



3.1.2 Analisa dan Tindak Lanjut

Berikut adalah analisis kinerja indikator pelayanan rawat inap Rumah Sakit RSPHS untuk bulan April Mei Juni 2025, berdasarkan empat indikator utama: BOR, LOS, TOI, dan BTO.

Indikator	April 2025	Mei 2025	Juni 2025	Standar Ideal	Evaluasi Umum
BOR (Bed Occupancy Rate)	76%	83%	79%	60–85%	Semua dalam standar, turun di Bulan Juni
LOS (Length of Stay)	4 hari	4 hari	4 hari	BPJS: 3 Umum: 6–12	Stabil, tidak sesuai untuk BPJS
TOI (Turn Over Interval)	1 hari	1 hari	1 hari	1–3 hari	Stabil
BTO (Bed Turn Over)	8 kali	10 kali	9 kali	4–5 kali	Konsisten tinggi mengalami penurunan di Bulan Juni, di atas standar

a. Analisis Tren Per Bulan

1) BOR (Bed Occupancy Rate)

- April: 76% → terjadi kenaikan
- Mei : 83% → terjadi kenaikan signifikan dari April.
- Juni : 79% → terjadi penurunan

Tren: Adanya penurunan dan kenaikan sejak bulan April, Beberapa faktor terjadinya Penurunan nilai BOR di Bulan Juni

- Jumlah penurunan jumlah pasien yang masuk di Bulan Juni, rata-rata pasien masuk di Bulan Mei 59 pasien per hari, sedangkan pasien masuk di Juni 43 pasien per hari
- Faktor internal
 - Fasilitas dan sarana prasarana yang baik menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar
 - Sikap tenaga medis dan staf yang membuat nyaman konsumen dengan adanya pembenahan jika ada kendala yang terjadi
- Faktor eksternal
 - Adanya kepercayaan dan citra yang baik di lingkungan masyarakat terkait RS Prima Husada Sukorejo
 - Adanya perubahan kebijakan terkait lama dirawat pasien BPJS kesehatan yang harus dirawat minimal 3 hari,

2) LOS (Length of Stay)

- Stabil di angka 4 hari untuk tiga bulan berturut-turut.
- Tidak sesuai SE PT.DPM untuk pasien BPJS, tetapi terlalu rendah untuk pasien umum (standar: 6–12 hari).
- Sedangkan pada Bulan April dan Mei Pasien BPJS yang dirawat selama 1-3 hari sebesar 55% , >4 hari sebesar 45%
- Adanya pasien yang dirawat melebihi SE dari PT DPM, perlu dikaji terkait indikasi dirawat pasien
- Adanya perubahan kebijakan terkait lama dirawat pasien BPJS kesehatan yang harus dirawat minimal 3 hari

Tren: Konsisten, tetapi perlu audit LOS pasien.

3) TOI (Turn Over Interval)

- Stabil di angka 1 hari untuk tiga bulan berturut-turut.

Tren: Konsisten, tetapi perlu adanya penggantian fasilitas kamar dan menjaga kebersihan ketika akan pergantian pasien sehingga infeksi nosocomial dapat diminimalisir

4) BTO (Bed Turn Over)

- April: 8 kali
- Mei : 10 kali
- Juni : 9 kali

Tren: Terlalu tinggi dari standar ideal (4–5 kali), yang bisa menandakan rotasi pasien sangat cepat → perlu dievaluasi dari aspek beban kerja, mutu layanan, dan risiko infeksi nosocomial.

b. Permasalahan yang Muncul

Isu	Penjelasan
Fluktuasi BOR	Bisa mencerminkan ketidakteraturan alur pasien atau perbedaan kebijakan antar bulan.
LOS terlalu singkat untuk pasien umum LOS terlalu lama untuk pasien BPJS	- Risiko pemulangan dini, kemungkinan readmisi meningkat. - Risiko meningkatkan penggunaan BMHP dan penggunaan kamar yang lebih lama
BTO tinggi secara konsisten	Potensi beban kerja berat bagi tenaga medis, penurunan mutu perawatan, dan tekanan administratif.
TOI rendah	Efisien, tetapi dalam konteks BTO tinggi → bisa berarti pasien terlalu cepat digantikan.

c. Rekomendasi Tindak Lanjut

- 1) Evaluasi Manajemen Pelayanan Rawat Inap
 - Tinjau alur pasien dan penyebab fluktuasi BOR.
 - Koordinasi antar unit untuk menjaga kestabilan utilisasi tempat tidur.
 - Rotasi pasien masuk dan keluar yang sangat cepat, kebutuhan kamar sangat tinggi.
- 2) Audit LOS Berdasarkan Jenis Pasien
 - Pisahkan analisa LOS pasien BPJS dan umum.
 - Cek outcome klinis untuk mendeteksi risiko pemulangan terlalu dini.
 - Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya untuk memonitor pasien BPJS yang sudah melebihi lama rawat 3 hari, perlu dikaji kembali terkait kondisi dan indikasi medis pasien.
- 3) Kaji Kembali Beban Kerja SDM
 - Lakukan survei kepuasan dan kelelahan staf medis akibat BTO tinggi.
 - Pertimbangkan redistribusi staf atau perekrutan tambahan jika diperlukan.
- 4) Implementasi Sistem Bed Management
 - Gunakan sistem digital untuk manajemen tempat tidur real-time dan efisiensi ruang rawat inap.
- 5) Monitoring Mutu Layanan

- Pantau indikator mutu lain seperti readmisi, komplain pasien, dan kepuasan pasien pasca rawat inap.

d. Kesimpulan Akhir

RSPHS menunjukkan kinerja indikator rawat inap secara umum dalam standar, tetapi:

- Ada fluktuasi BOR yang perlu distabilkan.
- BTO terlalu tinggi secara konsisten, bisa berdampak pada mutu dan beban kerja.
- LOS tetap 4 hari, tidak ideal bagi pasien BPJS maupun umum dan asuransi

3.1.3 Antrian Online BPJS Kesehatan

A. Profil Pelayanan Antrian Online

Menampilkan Dashboard Layanan Antrian Online Bulan Juni 2025



B. Kendala

Belum ada kendala dalam pelaksanaan

C. Rencana Tindak Lanjut

1. Monev pelaksanaan alur antrian online oleh karu dan kapid

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

No	Recana Pengembangan	Keterangan		Konfirmasi
		Tercapai	Belum Tercapai	
1	Penambahan unit dialisis		√	Visitasi tanggal 17 Juni 2025
2	Penambahan depo farmasi di IGD	√		Berjalan mulai Bulan Januari dengan 1 staf per sift
3	Penambahan microfon pengeras suara untuk pemanggilan keluarga pasien di IGD	√		
4	Penambahan ruang isolasi ICU	√		
5	Pelayanan doa bersama seminggu 2x	√		Pembimbing doa dari staf internal dan dari pengajian sirotul jannah
6	Penambahan fasilitas pada ruang anggrek (handuk, sabun, cantolan baju)	√		Pasien VIP sudah diberi fasilitas sandal, sabun dan sikat gigi
7	Penambahan mainan edukasi untuk pasien anak		√	
8	Penambahan hiasan pada dinding disetiap ruang anak dan nurse station		√	
9	Nursecall intercom untuk komunikasi dengan pasien isolasi		√	

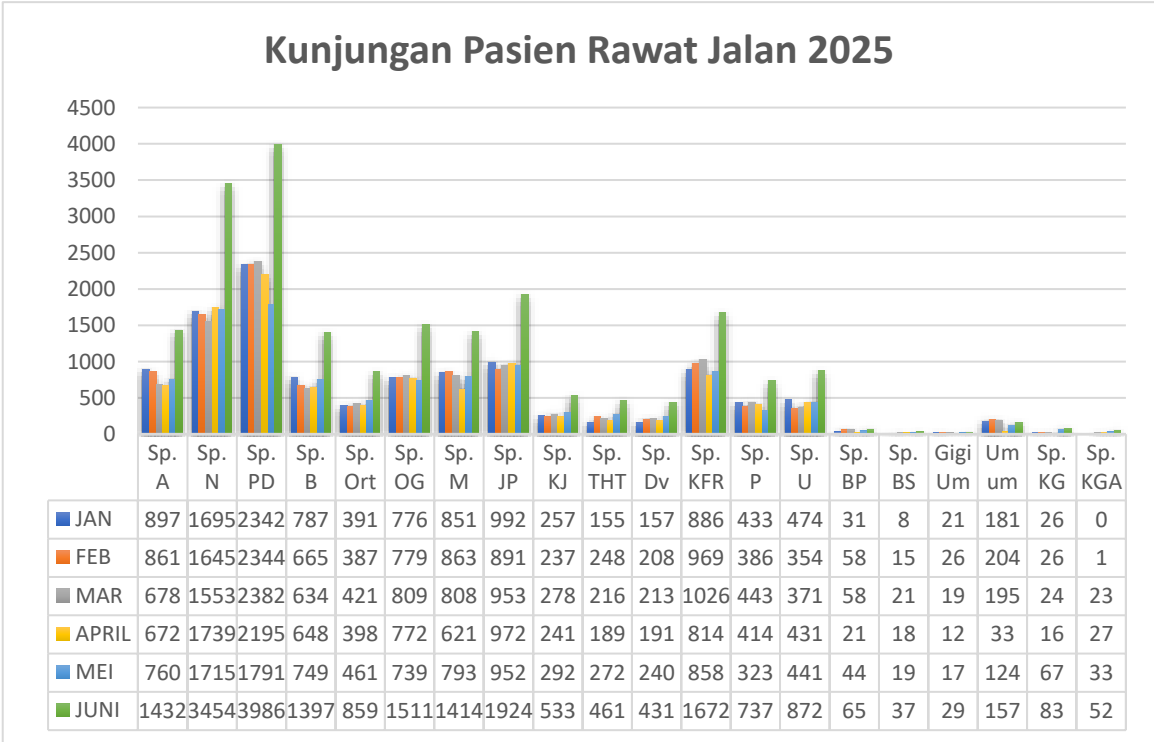
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

A. Tabel Kunjungan Pasien Rawat Jalan 2025

Nama POLIKLINIK	MAR 2025	APR 2025	MEI 2025	JUNI	%
Anak	678	672	760	800	↑0,5%
Bedah Umum	634	648	749	668	↓0,12%
Bedah Plastik	58	21	44	753	↑0,9%
Bedah Syaraf	21	18	19	37	↑0,48%
Gigi Umum	19	12	17	81	↑0,79%
Konservasi Gigi	24	16	67	47	↓0,42%
Gigi Anak	23	27	33	52	↑0,36%
Jantung	953	972	952	783	↓0,21%
Jiwa	263	241	292	267	↑0,09%
Kandungan	809	772	739	797	↑0,07%
Klinik Kulit dan Kelamin	213	191	240	244	↑0,01%
Mata	808	621	793	775	↓0,02%
Orthopedi	421	398	461	458	↓0,06%
Paru	443	414	323	415	↑0,22%
Penyakit Dalam	2382	2195	1791	1782	↓0,05%
Klinik Rehab Medik	1026	814	858	940	↑0,08%
Syaraf	1553	1739	1715	1684	↓0,01%
THT	160	189	272	267	↓0,01%
Klinik Umum/MCU	195	33	124	72	↓0,7%
Urologi	371	431	441	426	↓0,03%
Klinik Komplementer	0	0	0	0	0
TOTAL	11125	10511	10690	10717	

B. Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan 2025

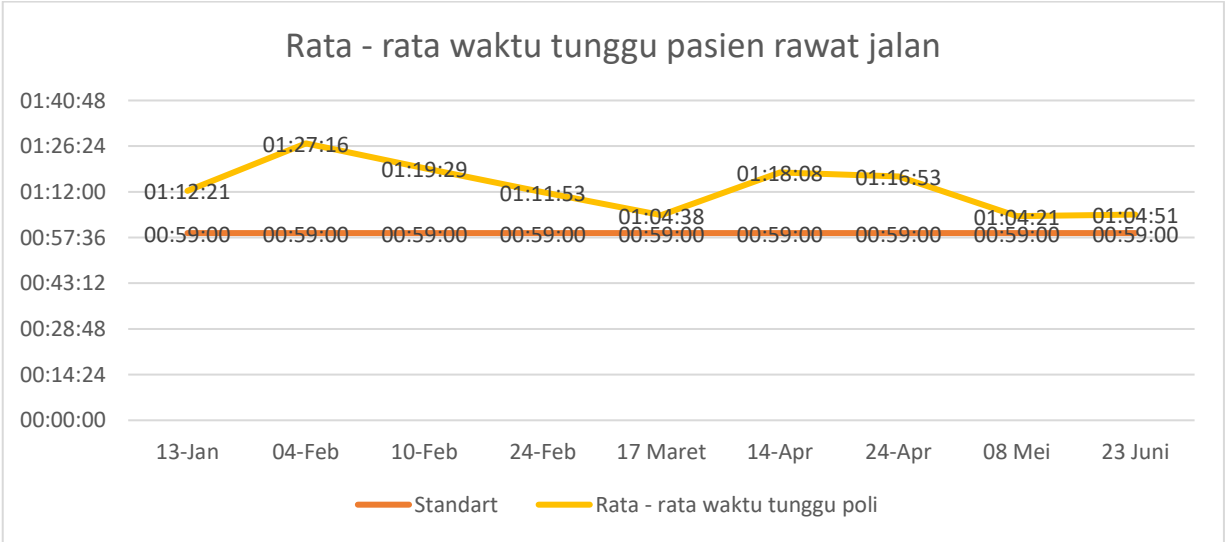


C. Analisa dan Rencana Tindak Lanjut

Analisa : Berdasarkan Grafik 3.2 diatas menunjukkan terdapat peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan pada bulan Juni, yang tercermin dari jumlah poliklinik yang mengalami peningkatan (15 poli) dibandingkan yang mengalami penurunan (5 poli). Ini mengindikasikan adanya tren positif dalam pemanfaatan layanan rawat jalan di fasilitas kesehatan tersebut.

Waktu Tunggu Pasien Rawat Jalan

NO	Bulan	Rata-rata Waktu Tunggu Poli
	13 Januari	01:12:31
1	4 Februari	01:27:16
2	10 Februari	01:19:29
3	24 Februari	01:11:53
4	17 Maret	01:04:38
5	14 April	01:18:08
6	24 April	01:16:53
7	08 Mei	01:04:21
8	23 juni	01:04:51



Analisa

Berdasarkan Grafik 3.4 diatas menunjukkan adanya waktu tunggu poli lebih dari 60 menit sehingga tidak sesuai dengan standart waktu tunggu sesuai BPJS. Lamanya waktu tunggu poli disebabkan karena adanya kedatangan dokter spesialis yang tidak sesuai jadwal, terjadinya gangguan Vclaim BPJS 2 kali dalam Bulan Juni.

Masalah

Problem	Tingginya waktu tunggu pasien rawat jalan > 60 menit yaitu 01:04:21
Step	Menurunkan waktu tunggu pasien rawat jalan menjadi < 60 menit
Plan	1. Rencana: Menurunkan waktu tunggu pasien rawat jalan menjadi < 60 menit dalam waktu 1 bulan 2. Harapan Waktu tunggu pasien rawat jalan < 60 menit.dan kepuasan pasien meningkat 3. Tindakan a. Lakukan time tracking di setiap titik layanan, tunggu dokter dan pemeriksaan. b. Identifikasi titik bottle neck. c. Koordinasi dengan BPJS saat terjadi gangguan Vclaim
Do	1. Tetapkan dokter hadir 15 menit sebelum jadwal praktik 2. Koordinasi dengan IT PT untuk penyediaan APM (anjungan pasien mandiri) 3. Memberikan teguran kepada dokter yang terlambat datang dengan prosentasi > 50 %
Study	1. Bandingkan waktu tunggu rata- rata sebelum dan sesudah intervensi 2. Kumpulkan data umpan balik pasien melalui survey singkat 3. Apakah perubahan menunjukkan penurunan waktu tunggu
Action	1. Ubah jadwal praktek dokter 2. Jadwalkan evaluasi bulanan waktu tunggu 3. Koordinasi dengan IT PT untuk pembuatan APM 4. Koordinasi dengan BPJS setiap ada gangguan Vclaim

Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
1	Tingginya waktu tunggu pasien rawat jalan > 60 menit yaitu 01:04:21	Waktu tunggu poli < 60 menit	Seluruh Poliklinik dan dokter spesialis	1. Ubah jadwal praktek dokter 2. Jadwalkan evaluasi bulanan waktu tunggu 3. Koordinasi dengan IT PT untuk pembuatan APM 4. Koordinasi dengan BPJS setiap ada gangguan Vclaim	1. Dokter spesialis 2. IT PT 3. Sekre komdik	1 Bulan

Rekapan Data Keterlambatan DPJP

No	Nama DPJP	Jumlah kehadiran	Terlambat	Tidak Terlambat	% Terlambat
1	dr. Cameleia Diah Setyorini, Sp.PD	14	9	5	64,29%
2	dr. Nurhadhi Sutanto, Sp.M	20	8	12	40,00%
3	dr. Latifah, Sp.M	19	7	12	36,84%
4	dr. Rossy Zaki Abdillah, Sp.B	17	5	12	29,41%
5	dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U	17	5	12	29,41%

6	dr. Riski Bagus Suhendra Sp.DVE	18	5	13	27,78%
7	dr. Fendi Fatkhurrohman Gozi, Sp.BS	4	1	3	25,00%
8	dr. Fiski Purantoro, Sp.OT	8	2	6	25,00%
9	dr. Fuad Fauzi, Sp.T.H.T.K.L.	12	3	9	25,00%
10	dr. Badariyatud Dini, Sp.BP-RE(K)	4	1	3	25,00%
11	dr. Dio Mafazi Fabrianta, Sp.U	9	2	8	22,22%
12	dr. Djanuar Fitriadi Sp.B	16	3	13	18,75%
13	dr. Esti Purwaningrum, Sp.A	14	2	12	14,29%
14	dr. Ardityo Rahmat Ardhany Sp.PD-KGH	9	1	8	11,11%
15	dr. Akhmad Zainul Arifin Sp.N, M.Kes	18	2	16	11,11%
16	dr. N. Indra Bayu, Sp.M	10	1	9	10,00%
17	dr. Andika Widiанти, Sp.KJ	10	1	9	10,00%
18	dr. Agung Wijaya Kusuma Sp.OG	20	2	18	10,00%
19	dr. Zaki Yamani, Sp.B	11	1	10	9,09%
20	dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A, M.Biomed	22	2	20	9,09%
21	dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp.PD	22	2	20	9,09%
22	dr. Rudi Priyo Utomo, Sp.OG	12	1	11	8,33%
23	dr. Santoso Rahardjo, Sp.OG	19	1	18	5,26%
24	dr. Aditya Purwaka, Sp.PD	23	1	22	4,35%
25	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp.N	27	1	26	3,70%
26	dr. Arianto Prabowo, Sp.OT	4	0	4	0,00%
27	dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp.OT	8	0	8	0,00%
28	dr. Aan Dwi Prasetyo Sp.N	17	0	17	0,00%
29	dr. Novita Maulidiyah, Sp.P	8	0	8	0,00%
30	dr. Muhammad Irawan, Sp.A	12	0	12	0,00%
31	dr. Heriyatmo, Sp.PD	1	0	0	0,00%
32	drg. Normayanti, Sp.KG	5	0	5	0,00%
33	drg. Syafrini Farrahdebi	8	0	8	0,00%
34	dr. Fitri Indahyanti, Sp.P., MMRS	5	0	5	0,00%
35	dr. Citra Dwi Harningtyas, Sp.DV., M.Ked.Klin	9	0	9	0,00%
36	dr. Yekti Mumpuni, Sp.KJ	4	0	4	0,00%

Analisa

Berdasarkan Tabel 3.6 diatas menunjukkan adanya dokter spesialis yang terlambat dengan prosentasi > 50% yaitu dr. Cameleia Diah Setyorini, Sp.PD. dengan prosentase 64,29%

Masalah

Problem	Angka keterlambat dokter spesialis > 50%
Step	Menurunkan angka keterlambatan dokter spesialis < 50 %
Plan	1. Rencana: Menurunkan keterlambatan dokter spesialis di rawat jalan 2. Harapan Tidak ada dokter spesialis yang terlambat 3. Tindakan a. Monitoring keterlambatan dokter spseialis di rawat jalan b. Ganti Hfis dokter sesuai jam kedatangan c. Membuat sistem pengingat ke DPJP setiap 15 menit sebelum praktek setiap

	dokter belum datang.
Do	1. Ingatkan dokter 15 menit sebelum jadwal praktik 2. Sosialisasi Kembali kebijakan disiplin waktu praktek dokter spesialis 3. Mmeberi teguran kepada dokter spesialis yang terlambat > 50 %
Study	1. Terdapat 1 dokter spesialis dengan angka keterlambatan > 50% yaitu dr Cameleia Diah Setyorini, Sp.PD 2. Keterlambatan dr Cameleia Diah Setyorini, Sp.PD 64,29%
Action	1. Ganti jadwal Hfis dokter spesialis yang sering terlambat sesuai jam kedatangan 2. Lakukan reward dan punishment bagi dokter terkait ketepatan waktu 3. Lakukan monitoring Bersama Komite Mutu dan Komite medik

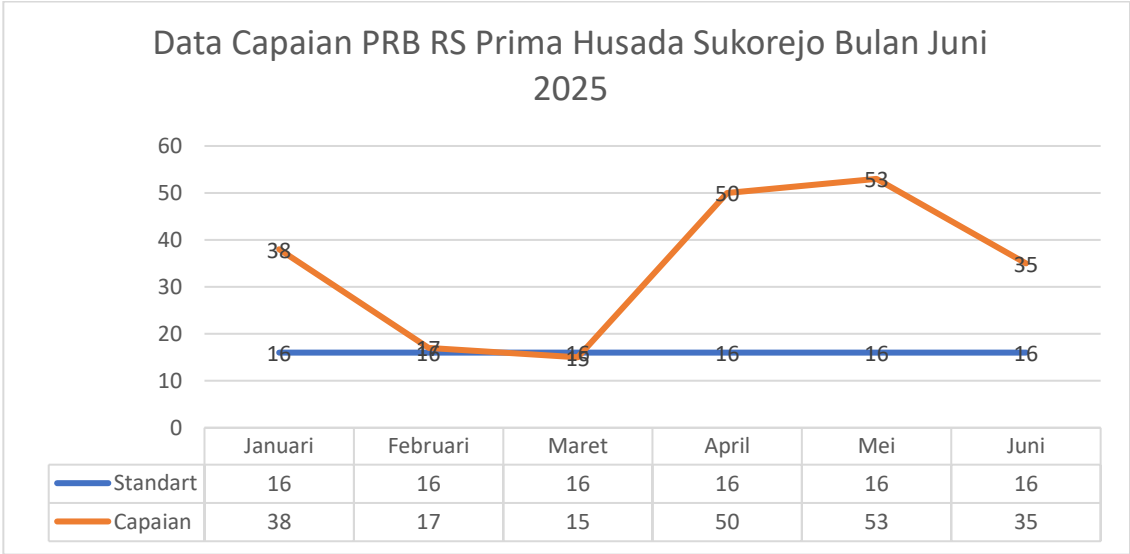
Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
1	Menurunkan angka keterlambatan dokter spesialis di rawat jalan	Meningkatkan kepuasan pasien dan mutu pelayanan	Seluruh dokter spesialis	1. Ganti jadwal Hfis dokter spesialis yang sering terlambat sesuai jam kedatangan 2. Lakukan reward dan punishment bagi dokter terkait ketepatan waktu 3. Lakukan monitoring Bersama Komite Mutu dan Komite medik	1. Dokter spesialis 2. Komite komdik 3. Komite Mutu	1 Bulan

Tabel PRB RS Prima Husada Sukorejo

No	Bulan	Jumlah PRB
1	Januari	38
2	Februari	17
3	Maret	15
4	April	50
5	Mei	53
6	Juni	35

Grafik PRB RS Prima Husada Sukorejo



Analisa

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian PRB sudah melebihi dari standart yang di tetapkan oleh BPJS yaitu 16 pasien, dan mengalami penurunan dibanding bulan Mei. Capaian pada Bulan Mei sebanyak 53 pasien dan Bulan Juni 35 Pasien. Penurunan ini disebabkan karena adanya banyak tanggal merah dan adanya 2 DPJP yang ijin ibadah Haji

Pengisian Dokumen Rekam Medis Elektronik oleh DPJP Rawat Jalan

NO	NAMA DOKTER	Σ DRM ALL	PAM			CPPT			KELENGKAPAN			
			Σ DRM	L	TL	Σ DRM	L	TL	PAM		CPPT	
									%L	%TL	%L	%TL
1	dr. Muhammad Irawan Sp.A.	471	166	165	1	305	305	0	99%	1%	100%	0%
2	dr. Esti Purwaningrum Sp.A.	201	84	84	0	117	116	1	100%	0%	99%	1%
3	dr. Rifta Yustiardi Sudjoko Sp.B.	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
4	dr. Rossy Zaki Abdillah Sp.B	82	29	28	1	53	53	0	97%	3%	100%	0%
5	dr Badariyatud Dini Sp.BP-RE	404	140	140	0	264	263	1	100%	0%	100%	0%
6	dr Fendi Fatkhurrohman Gozi Sp, BS	21	10	7	3	11	11	0	70%	30%	100%	0%
7	dr Maria Valentina Evelyn Sp. JP	18	16	16	0	2	2	0	100%	0%	100%	0%
8	dr. Adhika Prastya Wikananda Sp.JP	621	49	48	1	572	572	0	98%	2%	100%	0%
9	dr Yekti Mumpuni Sp.KJ.	336	29	28	1	307	307	0	97%	3%	100%	0%
10	dr. Andika Widiанти Sp.K.J	79	10	10	0	69	69	0	100%	0%	100%	0%
11	dr. Rudi Priyo Utomo Sp.OG	162	20	20	0	142	141	1	100%	0%	99%	1%
12	dr. Santoso Rahardjo Sp.OG.	467	134	133	1	333	332	1	99%	1%	100%	0%
13	dr. Citra Dwi Harningtyas Sp.DV., M.Ked.Klin	305	104	97	7	201	201	0	93%	7%	100%	0%
14	dr. Nyoman Indra Bayu Sp.M	162	31	30	1	131	131	0	97%	3%	100%	0%
15	dr Nurhadhi Sutanto Sp. M	569	194	194	0	375	374	1	100%	0%	100%	0%
16	dr Arianto Prabowo Sp. OT	191	87	87	0	104	104	0	100%	0%	100%	0%
17	dr. I Gede Made Oka Rahaditya Sp. OT	15	8	8	0	7	7	0	100%	0%	100%	0%
18	dr. Fiski Purantoro Sp.OT	457	119	118	1	338	336	2	99%	1%	99%	1%
19	dr. Fitri Indahyanti Sp.P., MMRS	44	21	21	0	23	23	0	100%	0%	100%	0%
20	dr. Novita Maulidiyah Sp.P	19	14	14	0	5	4	1	100%	0%	80%	20%
21	dr Cameleia Diah Setyorini Sp.PD	641	36	36	0	605	605	0	100%	0%	100%	0%
22	dr. Heriyatmo Sp. PD	82	16	16	0	66	66	0	100%	0%	100%	0%

NO	NAMA DOKTER	Σ DRM ALL	PAM			CPPT			KELENGKAPAN			
			Σ DRM	L	TL	Σ DRM	L	TL	PAM		CPPT	
									%L	%TL	%L	%TL
23	dr. Dimas Aryo Pamungkas Sp.PD	87	8	8	0	79	79	0	100%	0%	100%	0%
24	dr. Aan Dwi Prasetyo Sp.N	205	24	24	0	181	181	0	100%	0%	100%	0%
25	dr. Ahmad Farid Wajdi Sp.N.	385	112	112	0	273	273	0	100%	0%	100%	0%
26	dr. Fuad Fauzi Sp.T.H.T.K.L.	353	123	120	3	230	228	2	98%	2%	99%	1%
27	dr Ferdyan Rachmat Efendi Sp.U	170	40	33	7	130	130	0	83%	18%	100%	0%
28	dr. Zaki Yamani, Sp. B	172	29	27	2	143	143	0	93%	7%	100%	0%
29	dr. Dio Mafazi Fabrianta Sp.U	484	63	59	4	421	421	0	94%	6%	100%	0%
30	dr. Aditya Purwaka Sp.PD	94	27	27	0	67	67	0	100%	0%	100%	0%
31	dr. Erinda Rahma Mulia Sp. FKR	143	29	28	1	114	114	0	97%	3%	100%	0%
32	dr. Eko Nugroho Sp. FKR	224	62	62	0	162	162	0	100%	0%	100%	0%
33	dr. Akhmad Zainul Arifin Sp.N, M.Kes	116	34	34	0	82	82	0	100%	0%	100%	0%
34	dr. Ardityo Rahmat Ardhan Sp.PD-KGH	207	39	39	0	168	168	0	100%	0%	100%	0%
35	dr. Latifah Sp.M	393	54	54	0	339	339	0	100%	0%	100%	0%
36	dr. Rachmawati Wardani Sp. N.	93	19	19	0	74	74	0	100%	0%	100%	0%
37	dr. Djanuar Fitriadi Sp.B	841	178	176	2	663	662	1	99%	1%	100%	0%
38	dr. Agung Wijaya Kusuma, Sp.OG	296	42	42	0	254	254	0	100%	0%	100%	0%
39	dr. Adhya Aji Pratama, Sp.PD	930	110	110	0	820	818	2	100%	0%	100%	0%
40	dr. Julian Hartawan Wijaya Sp. T.H.T.B.K.L	69	32	32	0	37	37	0	100%	0%	100%	0%
41	dr. Dion Setiawan, Sp.JP	376	73	73	0	303	302	1	100%	0%	100%	0%
42	dr. Riski Bagus Suhendra, Sp.DVE	224	68	68	0	156	156	0	100%	0%	100%	0%
TOTAL		10449	2286	2260	26	8163	8152	11	98.86%	K	99.87%	K
				2286			8163					

Analisa

Berdasarkan Tabel 3.9 diatas menunjukkan adanya pengisian ERM yang belum lengkap di pengkajian medis DPJP bagian tanda tangan pasien, . Tanda tangan pasien yang tidak patuh ada pada pasien dr. Dr Fendi Fatkhurrohman Gozi, Sp.Bs, pada bagian CPPT yang tidak lengkap ada pasien dr. Novita Sp.P

Masalah

Problem	Ketidaklengkapan pengisian ERM rawat jalan . Tanda tangan pasien yang tidak patuh ada pada pasien dr. Dr Fendi Fatkhurrohman Gozi, Sp.Bs, pada bagian CPPT yang tidak lengkap ada pasien dr. Novita Sp.P
Step	Perbaikan kualitas pengisian rekam medis elektronik (ERM)

Plan	1. Rencana: Perbaiki kualitas pengisian rekam medis elektronik 2. Harapan Kelengkapan pengisian ERM 100 % 3. Tindakan a. Lakukan audit harian ERM acak untuk DPJP b. Sosialisasi kembali standart pengisian ERM c. Koordinasi dengan IT PT agar pengisian yang tidak lengkap tidak dapat menuju pengisian step berikutnya
Do	1. Kirim daftar temuan tidak lengkap kepada DPJP setiap minggu 2. Koordinasi dengan perawat untuk bantu memastikan tanda tangan pasien terisi sebelum pasien meninggalkan ruang rawat
Study	1. Bandingkan data kelengkapan ERM minggu ke 0 dan minggu ke 2 2. Evaluasi feed back dari dokter terkait kendala sistem atau teknis
Action	1. Terapkan reminder dan pelaporan rutin ke semua dokter 2. Adakan pelatihan ulang pengiisan ERM 3. Masukkan ke dalam evaluasi kinerja terkait ketidak lengkapan ERM irja

Tindak Lnjut

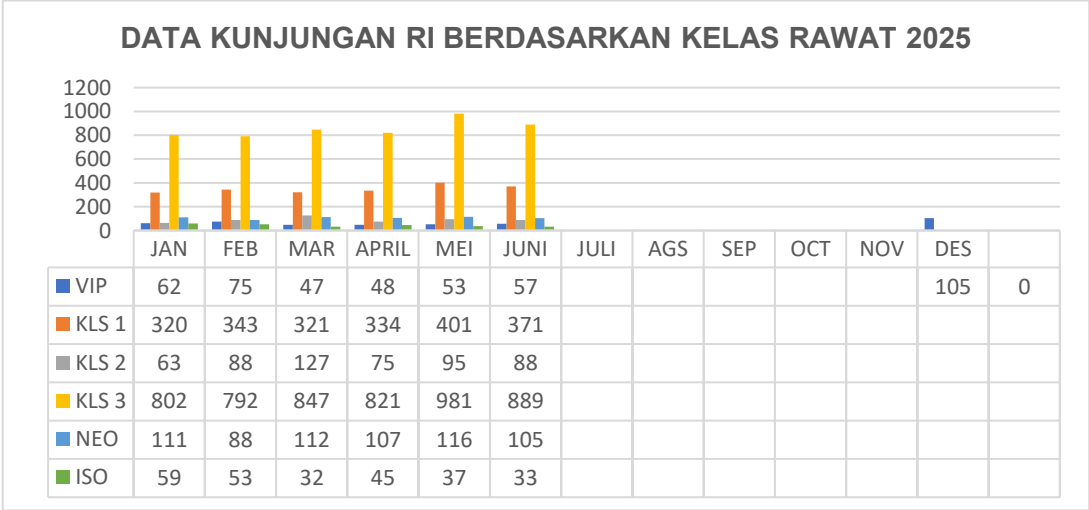
No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
1	Meningkatkan kelengkapan ERM dr. Fendi Fatkhurrohman Gozi, Sp.Bs dan dr Novita, Sp.P	Meningkatkan kelengkapan pengisian ERM menjadi ≥90% dalam waktu 1 bulan	Seluruh dokter spesialis	1.Terapkan reminder dan pelaporan rutin ke semua dokter 2.Adakan pelatihan ulang pengiisan ERM 3.Masukkan ke dalam evaluasi kinerja terkait ketidak lengkapan ERM irja	1. Dokter spesialis 2. RM	1 Bulan

3.3.2 Rawat Inap

A. Tabel Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Cara Bayar 2025

No	Kelas Perawatan	Jumlah Pasien								
		Umum	BPJS Kes	BPJS TK	Asuransi Swasta	JR	PT	BPJS Ikut Ibu	Total	%
1	VIP	6	18	0	15	0	18	0	57	3,05%
2	Kelas 1	7	357	0	5	2	0	0	371	19,83%
3	Kelas 2	14	47	21	2	4	0	0	88	4,70%
4	Kelas 3	19	854	0	1	15	0	0	889	47,51%
5	ICU	0	20	0	0	1	0	0	21	1,12%
6	Maternitas	3	143	0	1	0	0	0	147	7,86%
7	Neonatologi	1	5	0	1	0	0	98	105	5,61%
8	Isolasi	1	32	0	0	0	0	0	33	0,00%
TOTAL		51	1476	21	25	22	18	98	1711	91,45%

B. Grafik Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Kelas Rawat 2025



Analisa

Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan adanya penurunan jumlah pasien di bulan Juni. Penurunan terjadi pada pasien Kelas 3, Kelas 2, Kelas 1 dan Neonatologi. Peningkatan pasien hanya terjadi pada pasien VIP

Problem	Penurunan jumlah pasien ruang isolasi
Step	Meningkatkan jumlah pasien ruang isolasi
Plan	1. Rencana: Meningkatkan jumlah pasien isolasi 2. Harapan Meningkatkan jumlah pasien isolasi > 20 % dalam 1 – 2 bulan kedepan 3. Tindakan a. Perbaiki fasilitas dasar isolasi keramik lantai yang rusak b. Buat materi promosi layanan isolasi dan kirim ke mitra faskes c. Tingkatkan kecepatan layanan admisi dan respon dokter jaga
Do	1. Luncurkan promosi layanan isolasi melalui media social atau WA 2. Kunjungan marketing tiap minggu atau kontak faskes
Study	1. Bandingkan data sebelum bulan Mei dan bulan April, cek kunjungan yang masuk dari mitra 2. Evaluasi kunjungan pasien isolasi
Action	1. Evaluasi berkala kepuasan pasien isolasi 2. Buat program kunjungan mitra dan promosi layanan 3. Evaluasi layanan dokter dan kecepatan respon

Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
1	Penurunan pasien isolasi	Meningkatkan jumlah pasien isolasi > 20 % dalam 1 – 2 bulan	Humas dan marketing Dokter spesialis Perawat Mitra rumah sakit	1. Evaluasi berkala kepuasan pasien isolasi 2. Buat program kunjungan mitra dan promosi layanan 3. Evaluasi layanan dokter dan kecepatan respon	1. Humas dan marketing 2. Dokter spesialis 3. Perawat	1 – 2 Bulan

Laporan Pasien APS

No	UNIT	BULAN JANUARI-DESEMBER											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	IGD	3	4	5	6	6	16						
2	IRNA 2A	5	5	3	7	4	5						
3	IRNA 2B	7	0	2	2	2	0						
4	IRNA 3A	1	2	2	2	2	0						
5	IRNA 3B	1	0	1	3	1	3						
6	ICU	0	0	0	0	0	0						
7	NICU	-	0	0	0	0	0						
8	MATERNITAS	-	0	0	0	0	0						

Laporan Pasien Rujuk

No	Indikator RS	Bulan JANUARI-DESEMBER											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	IGD	29	16	34	29	29	15						
2	IRNA 2A	12	6	5	6	9	19						
3	IRNA 2B	20	10	19	7	5	7						
4	IRNA 3A	3	4	2	2	3	2						
5	IRNA 3B	6	10	5	7	4	10						
6	ICU	5	6	3	5	7	6						
7	NICU	2	3	4	0	7	1						
8	MATERNITAS	1	1	1	0	0	1						

Laporan Pasien Meninggal

No	Indikator RS	Bulan JANUARI-DESEMBER											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	IGD	13	17	16	20	20	24						
2	IRNA 2A	16	6	9	16	9	7						
3	IRNA 2B	10	6	14	20	12	8						
4	IRNA 3A	1	0	2	1	0	2						
5	IRNA 3B	1	0	9	4	7	8						
6	ICU	20	11	13	11	23	15						
7	NICU	2	0	0	0	0	0						
8	MATERNITAS	1	0	0	0	0	0						

Jumlah Kunjungan Rawat Inap Tahun 2025

Nama Unit	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	%
Anak	436	390	484	416	-3,97%
Bedah Umum	172	175	240	228	-0,70%
Bedah Plastik	26	11	21	13	-0,47%
Bedah Syaraf	25	20	24	25	0,06%
Jantung	45	50	64	38	-1,52%
Jiwa	3	1	0	0	0,00%
Kandungan	162	151	156	147	-0,53%
Kulit Dan Kelamin	2	2	3	1	-0,12%
Mata	16	6	25	19	-0,35%
Orthopedi	84	67	72	67	-0,29%
Paru	112	111	79	98	1,11%

Penyakit Dalam	373	385	451	422	-1,69%
Syaraf	144	141	152	146	-0,35%
Urologi	60	71	17	75	3,39%
THT	13	16	83	16	-3,92%
TOTAL	1673	1597	1871	1711	-9,35%

Analisis :

- a. Kunjungan IRNA terbanyak di Bulan Juni 2025 adalah penyakit dalam sejumlah 422 pasien diikuti dengan anak sejumlah 416 pasien.
- b. Kunjungan IRNA secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 9,35%
- c. Kunjungan IRNA dengan kenaikan tertinggi adalah spesialis urologi sebesar 3,39%

Jumlah Kunjungan Rawat Inap berdasarkan Kelas Perawatan 2025

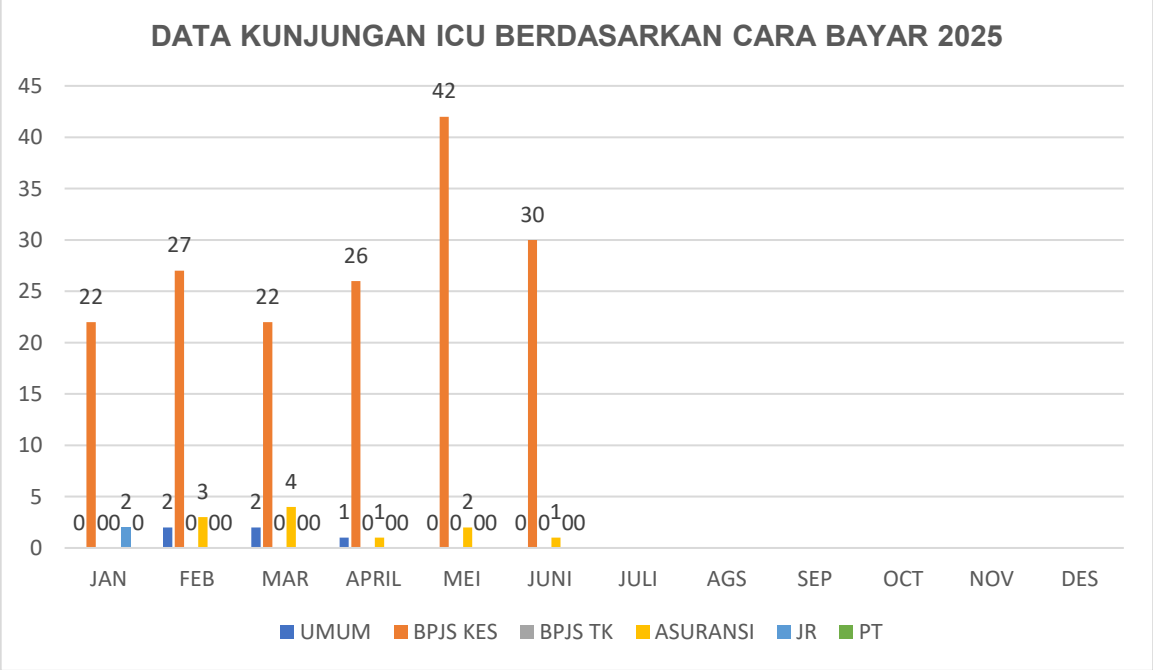
		JUNI								
No	Kelas Perawatan	Jumlah Pasien								
		Umum	BPJS Kes	BPJS TK	Asuransi Swasta	Jasa Raharja	Perusahaan	BPJS Iktu Ibu	Total	%
1	VVIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	VIP	6	18	0	15	0	18	0	57	3,05%
3	Kelas I	7	357	0	5	2	0	0	371	19,83%
4	Kelas 2	14	47	21	2	4	0	0	88	4,70%
5	Kelas 3	19	854	0	1	15	0	0	889	47,51%
6	ICU	0	20	0	0	1	0	0	21	1,12%
7	Maternitas	3	143	0	1	0	0	0	147	7,86%
8	Perinatologi	1	5	0	1	0	0	98	105	5,61%
9	NICU	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10	Isolasi	1	32	0	0	0	0	0	33	1,76%
11	ICU COVID	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	TOTAL	51	1476	21	25	22	18	98	1711	91,45%

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)

A. Tabel Kunjungan Pasien ICU Berdasarkan Cara Bayar 2025

No	Cara Bayar	Target	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Oct	Nov	Des	Jumlah	Prosent
1	Umum	4	0	2	2	1	0	0								↑0,25%
2	BPJS Kes	20	22	27	22	26	42	30								↓28,5%
3	BPJS TK	1	0	0	0	0	0	0								0%
4	Asuransi Swasta	1	0	3	4	1	2	1								↓50%
5	JR	1	2	0	0	0	0	0								0%
6	Perusahaan	1	0	0	0	0	0	0								0%
	TOTAL	28	24	32	28	28	45	31								↓31,1%

B. Grafik Kunjungan Pasien ICU Berdasarkan Cara Bayar 2025



C. Analisa dan Rencana Tindak Lanjut

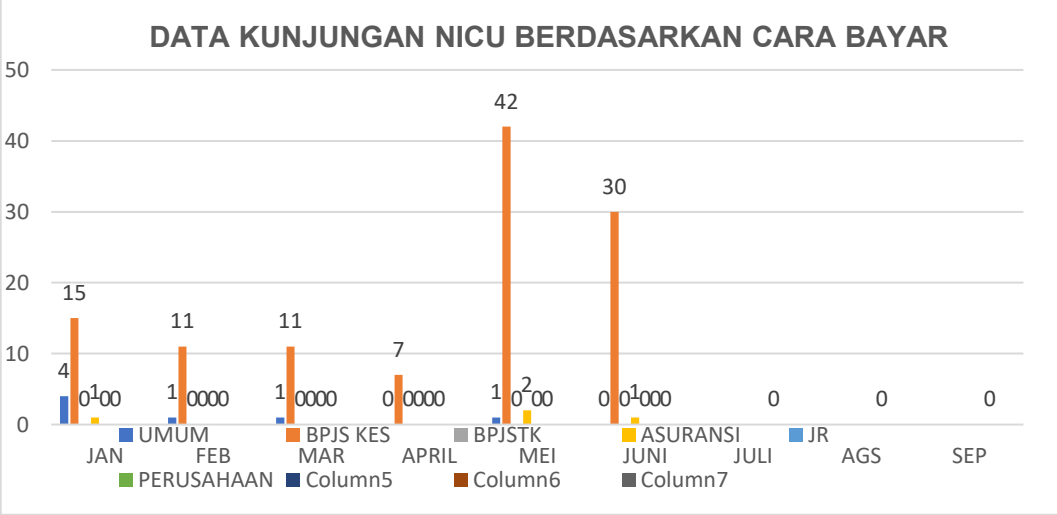
Analisa :
Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien pada bulan Juni sebanyak 31,1%. Jumlah pasien ICU pada bulan Mei sebanyak 45 pasien dan pada bulan Junii 31 pasien. Penurunan jumlah pasien ICU disebabkan adanya libur idul adha yang menyebabkan jumlah kunjungan pasien menurun

3.3.4 NICU

A. Tabel Kunjungan Pasien NICU Berdasarkan Cara Bayar 2025

N o	Cara Bayar	Tar get	Ja n	Fe b	M ar	Ap ril	M ei	Ju n	J ul	A gs	Se p	O ct	N ov	D es	Juml ah	Prosen tase
1	Umum	1	0	1	1	0	1	0								↓0,01%
2	BPJS Kes	5	15	11	11	7	16	5								↓0,11%
3	BPJS TK	1	0	0	0	0	0	0								0
4	Asuran si Swasta	1	0	0	0	0	0	0								0
5	JR	1	0	0	0	0	0	0								0
6	Perusa haan	1	0	0	0	0	0	0								0
TOTAL		10	15	13	12	7	17	5								↓0,12%

B. Grafik Kunjungan Pasien NICU Berdasarkan Cara Bayar 2025



C. Analisa dan Rencana Tindak Lanjut

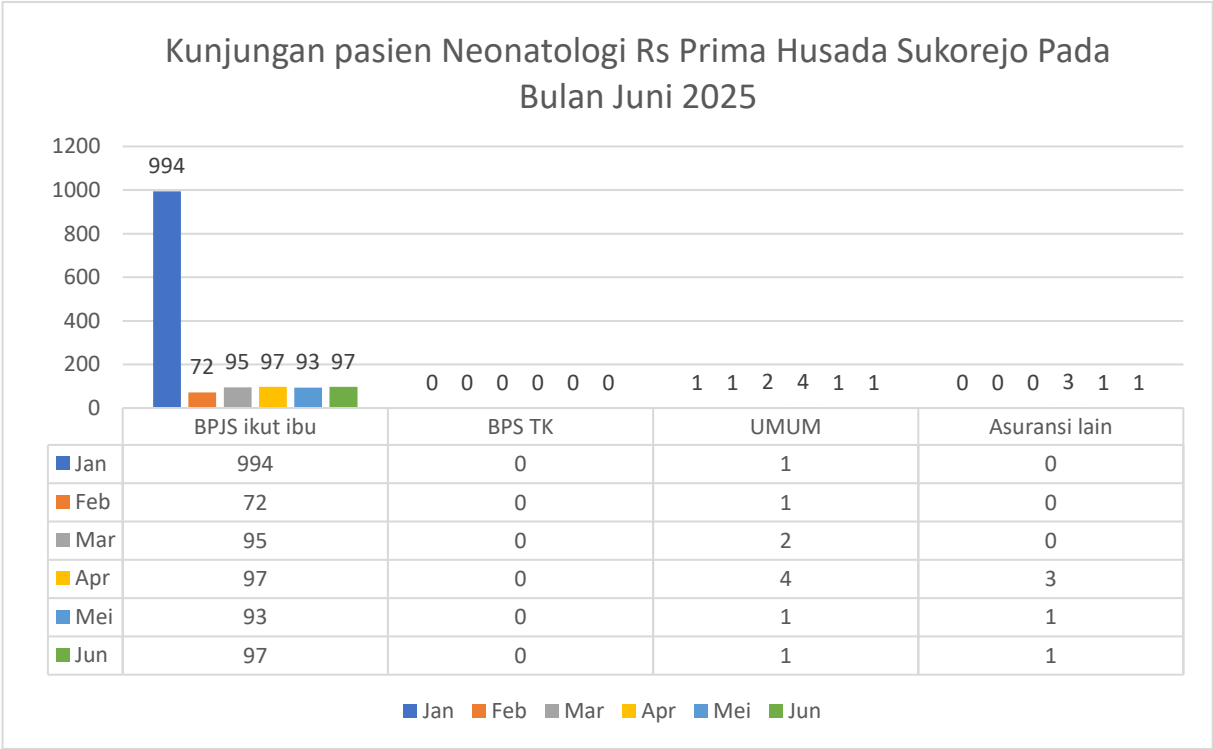
Analisa :
Berdasarkan hasil rekap kunjungan NICU dibulan Juni terjadi penurunan kunjungan sebanyak 0,12 % .Jumlah kunjungan pada Bulan Mei sebanyak 17 pasien dan Bulan Juni sebanyak 5 pasien. Hal ini disebabkan meningkatnya bayi lahir sehat sebanyak 0,04%.

3.3.5 Neonatologi

Tabel 3.13 Kunjungan Pasien Neoatologi Berdasarkan Cara Bayar 2025

Cara BAYAR	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Prese
BPJS ikut Ibu	80	94	72	95	97	93	97							↑0,04%
JKK	0	0	0	0	0	0	0							0
Umum	10	1	1	2	4	1	1							0
Asuransi Lain	10	0	0	0	3	1	1							0
Total	100	95	73	97	104	464	99							↑0,04

Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar di Unit Neonatologi 2025



Analisa dan Rencana Tindak Lanjut :

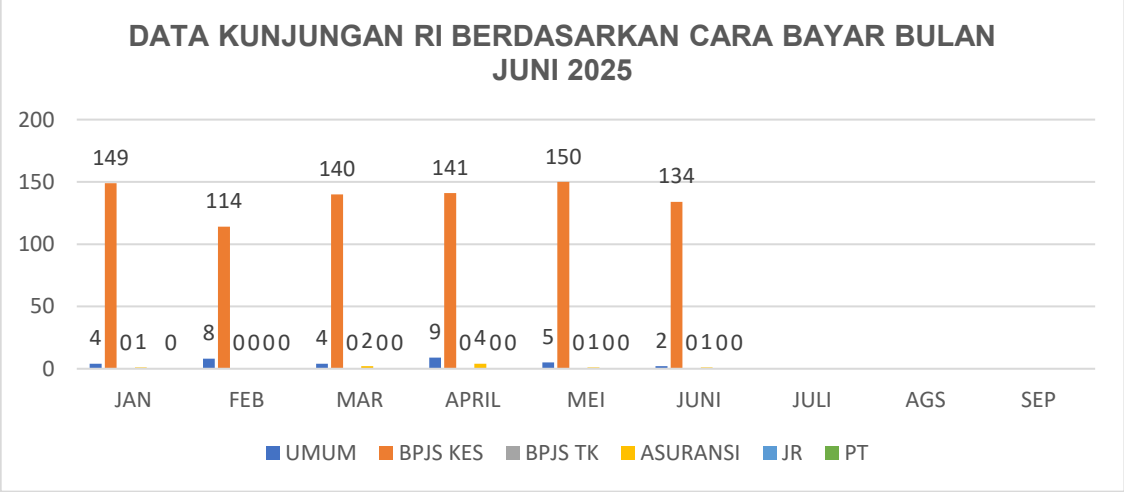
Berdasarkan grafik 3.6 diatas menunjukkan bahwa rerkap kunjungan neonatologi dibulan Juni Terjadi peningkatan sebanyak 99 pasien , Naik 0,04 % dibandingh bulan sebelumnya Peningkatan ini terjadi karena banyaknya bayi lahir sehat yang terjadi dibulan Juni

3.3.6 Maternitas

A. Tabel Kunjungan Pasien Maternitas Berdasarkan Cara Bayar 2025

No	Cara Bayar	Target	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Prosentase
1	Umum	4	4	8	4	9	3	2							↓50
2	BPJS Kes	150	149	112	140	141	150	134							↓26
3	BPJS TK	0	0	0	0	0	0	0							0
4	Asuransi Swasta	5	1	0	2	4	1	1							0
5	JR	1	0	0	0	0	0	0							0
6	Perusahaan	5	0	0	0	0	0	0							0
TOTAL		167	154	122	145	156	156	137							↓19,6

B. Grafik Kunjungan Pasien Maternitas Berdasarkan Cara Bayar 2025



C. Analisa dan Rencana Tindak Lanjut

Analisa :
Berdasarkan grafik 3.7 menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah pasien maternitas. Penurunan terjadi sebanyak 19,6 % dibanding dengan bulan Mei 2025. Penurunan terjadi karena adanya dpjp obgin yang melakukan ibadah haji pada bulan Mei dan adanya banyak tanggal merah di bulan tersebut.

3.3.7 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Tabel jumlah kunjungan IGD Tahun 2025

Nama Unit	April 25	Mei 25	Juni 25	%
IGD	1945	1921	1817	↓5,4%

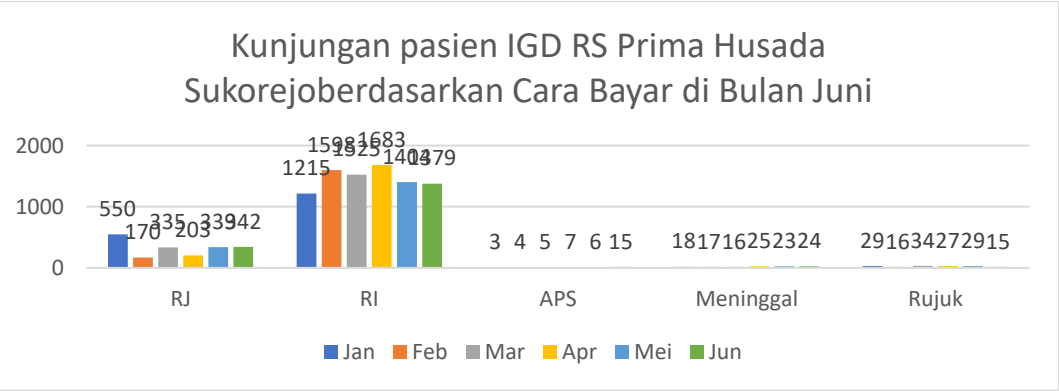
A. Tabel Kunjungan Pasien IGD 2025

Nama Dokter	April	Mei	Juni	%
Dr. Mohammad Helmi Wibisono	309	341	306	↓10,2
Dr. Doddy Adi Nugroho	149	95	106	↑11,5
Dr. Achmad Fauzan Aliani	181	128	140	↑40
Dr. Tania Calista	223	220	184	↓84
Dr. Fina Jazilah Rizkiyah	249	251	217	↓13,5
Dr. Nejoa Ermaq Fatreciano	235	228	197	↓13,5
Dr. Wahyu Firmansyah	290	309	281	↓9,06
Dr. Mohammad Ilyas Febri	309	349	196	↓43,8
Dr. Moch. Dicky Wahyu Irawan	-	-	190	
Dr. Naufal Najmudin	-	-	-	
Total	1945	1.921	1.817	↓5,4

Jumlah Kunjungan IGD Bulan Juni
Kunjungan Pasien IGD berdaasarkan Cara Rawat Bulan Juni 2025

No	Bulan	Target	Jumlah	Keterangan					Prosentase
				RJ	RI	APS	Meninggal	Rujuk	
1	Jan	1200	1785	550	1215	3	18	29	↑ 1,41%
2	Feb	1200	1768	170	1598	4	17	16	↓1,4
3	Mar	1200	1860	335	1525	5	16	34	↑0,05%

4	April	1200	1945	203	1683	7	25	27	↑0,04%
5	Mei	1200	1921	339	1404	6	23	29	↓7%
6	Juni	1200	1817	342	1379	15	24	15	↓5,4%
7	Juli	1200							
8	Agustus	1200							
9	September	1200							
10	October	1200							
11	November	1200							
12	Desember	1200							

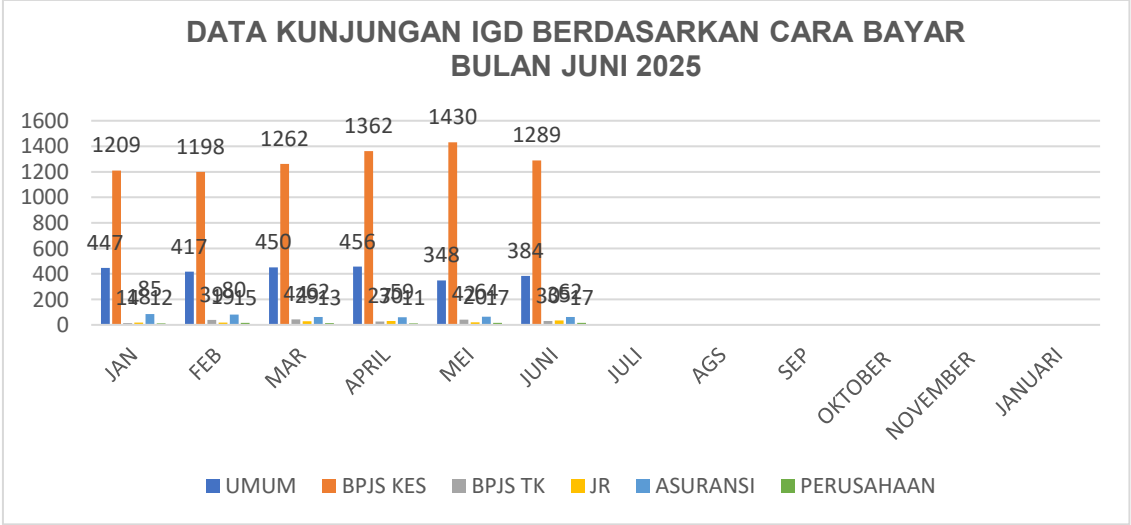


Analisa :
 Berdasarkan grafik3.8 diatas menunjukkan penurunan pasien IGD sebanyak 0,05 % dibanding Bulan Mei. Jumlah kunjungan pada Bulan Juni sebanyak 1817 sedangkan pada bulan Juni sebanyak 1921. Penurunan terjadi karena adanya hari besar keagamaan pada Bulan Mei yang menyebabkan masyarakat pasuruan menjalankan prosesi mudik ke daerah asal

B. Tabel Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan cara bayar 2025

Cara Bayar	April	Mei	Juni
UMUM	456	348	384
BPJS KESEHATAN	1362	1430	1289
BPJS KETENAGAKERJAAN	27	42	30
JASA RAHARJA	30	20	35
ASURANSI	59	64	62
PERUSAHAAN	11	17	17
Total	1945	1.921	1817
Target	1.200	1.200	1.200

Grafik Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan cara bayar 2025



Analisa

Berdasarkan grafik 3.7 diatas menunjukkan pada bulan Juni mengalami penurunan. Jumlah kunjungan pada bulan Juni sebanyak 1817 sedangkan pada bulan Mei sebanyak 1921. Penurunan ini terjadi karena adanya hari besar keagamaan pada Bulan Juni 2025

3.3.8 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

A. Kunjungan Pasien IKO Berdasarkan Cara Bayar 2025

No	Bulan	Target	Jumlah	Keterangan					Prosentase
				BPJS Kes	BPJS TK	Umum	JR	Asuransi Lain	
1	Jan	400	477	435	10	9	15	8	0,62%
2	Feb	400	456	404	18	7	16	11	0,14%
3	Mar	400	480	419	29	5	23	4	1,2%
4	April	400	487	436	17	6	20	8	14%
5	Mei	400	558	508	24	6	12	10	1,6
6	Juni	400	537	481	20	6	23	7	↓3,7
7	Juli	400							
8	Agustus	400							
9	September	400							
10	October	400							
11	November	400							

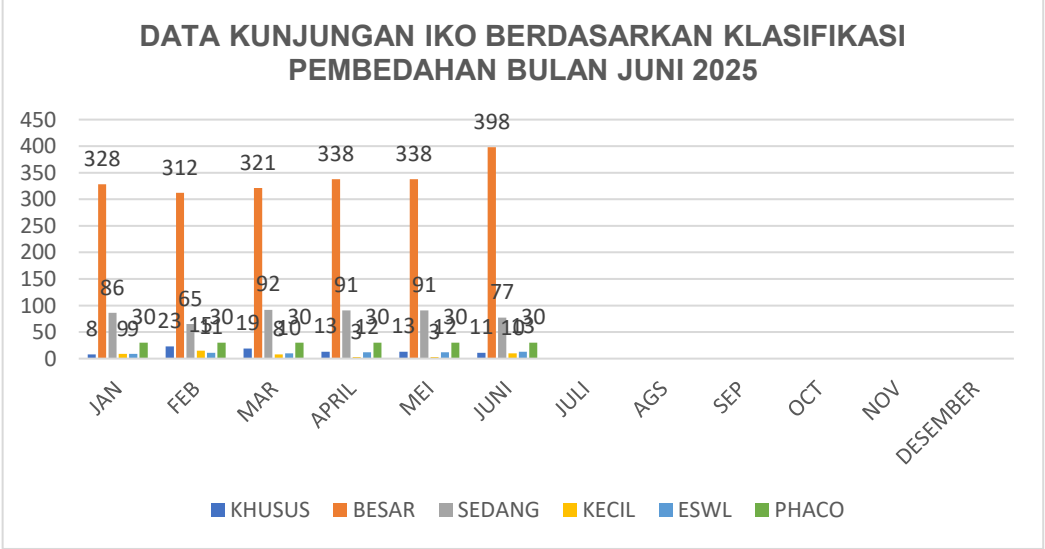
Grafik Kunjungan Pasien IKO Berdasarkan Cara Bayar Bulan Juni 2025



B. Tabel Kunjungan Pasien IKO Berdasarkan Klasifikasi Pembedahan 2025

No	Bulan	Target	Jumlah	Keterangan						Prosentase
				Khusus	Besar	Sedang	Kecil	ESWL	Phaco	
1	Jan	400	477	8	328	86	9	9	30	↓0,06 %
2	Feb	400	456	23	312	65	15	11	30	↓0,21%
3	Mar	400	480	19	321	92	8	10	30	↑1,2 %
4	April	400	487	13	338	91	3	12	30	↑1,2 %
5	Mei	400	558	14	397	91	11	15	30	
6	Juni	400	539	11	398	77	10	13	30	↓3,7%
7	Juli	400								
8	Agustus	400								
9	September	400								
10	October	400								
11	November	400								
12	Desember	400								

C. Grafik Kunjungan Pasien IKO Berdasarkan Klasifikasi Pembedahan



D. Analisa dan Rencana Tindak Lanjut

Analisa :
Berdasarkan grafik dan tabel didapatkan penurunan jumlah pasien operasi pada Bulan Juni jika dibandingkan dengan bulan Mei. Jumlah pasien operasi pada Bulan Mei sejumlah 558 pasien dan Bulan Juni sejumlah 539 pasien. Penurunan jumlah operasi terjadi 3,7%. Penurunan ini dikarenakan adanya dokter operator yang ijin ibadah haji

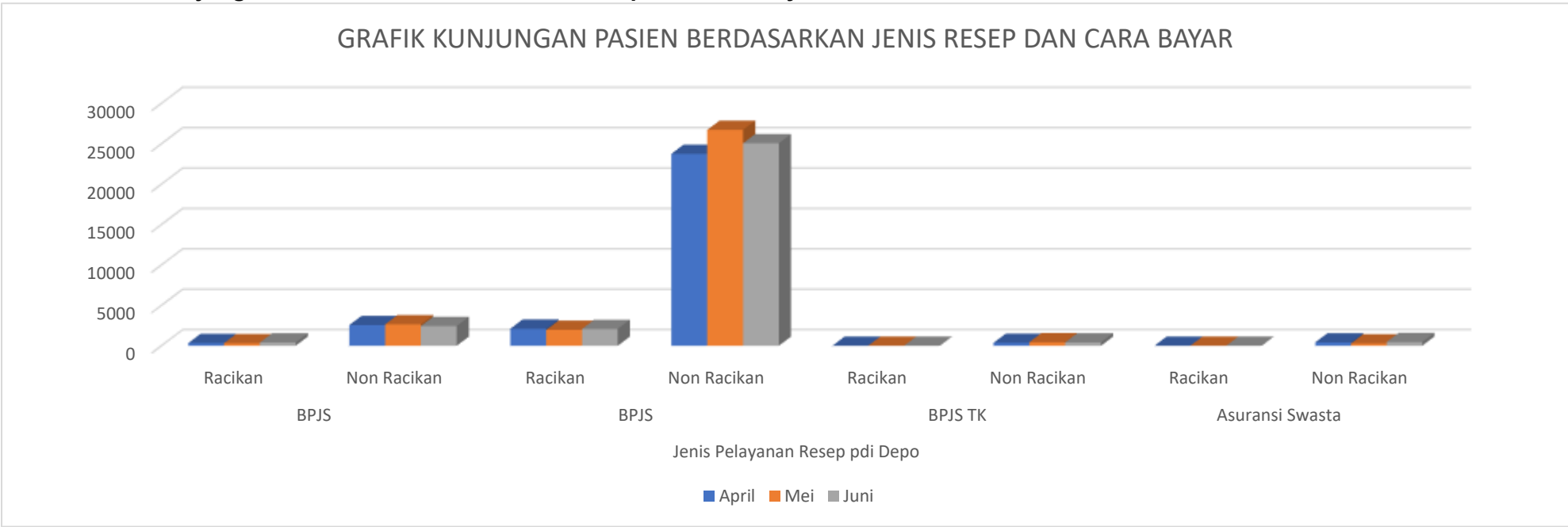
3.4 Kinerja Bidang Penunjang

3.4.1 Instalasi Farmasi

Rekap Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar & Jenis Resep 2025

No	Bulan	Jenis Pelayanan Resep pdi Depo												Total Resep
		Umum			BPJS			BPJS TK			Asuransi Swasta			
		Racikan	Non Racikan	Jumlah	Racikan	Non Racikan	Jumlah	Racikan	Non Racikan	Jumlah	Racikan	Non Racikan	Jumlah	
1	April	334	2560	2894	2106	23756	25862	0	370	370	3	410	413	29539
2	Mei	324	2646	2970	1974	26712	28687	0	442	442	0	278	278	32377
3	Juni	402	2445	2847	2075	25054	27129	0	413	413	1	458	459	30848

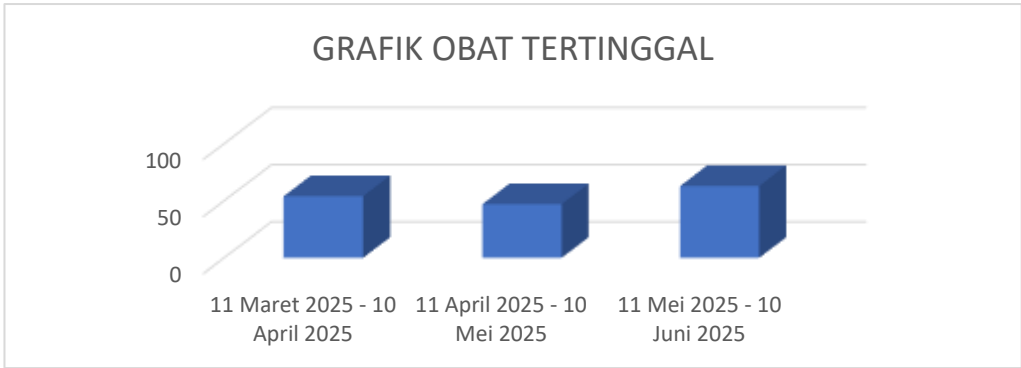
Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Jenis Resep dan Cara Bayar



3.4.2. Rekap Obat tertinggal

No	Periode	Jumlah Resep
1	11 Maret 2025 – 10 April 2025	54
2	11 April 2025 – 10 Mei 2025	47
3	11 Mei 2025 – 10 Juni 2025	63

Grafik Obat Tertinggal



3.4.3. Obat Near ED

Data Obat Near ED dari Depo Farmasi

DEPO FARMASI												
NO.	KODE	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA BELI	TGL. EXPIRE	NO. BATCH	JML. FISIK BAIK	JML. FISIK RUSAK	TOTAL JUMLAH	TOTAL HARGA	PENJUALAN 2024	KETERANGAN
1.	F04727	DOBUTAMINE INJ 250 MG / 5 ML - OGB DEXA	AMP	0	30/06/2025	4620992B	2	0	2	0	291	Obat near ED dari Box Emergency dilakukan peresepan di Depo Central terlebih dahulu
2.	F00665	RECOLFAR TAB 05 MG - FAHRENHEIT	TAB	6,0 00	7/1/2025	1HG150	1	0	1	6,000	65	Dilakukan substitusi peresepan colchicine generik

3.	F00507	MORINAGA CHIL KID 3 SOYA (1-3 THN) - KALBE	BOX	0	28/08/2025		4	0	4	0	3	Bisa tukar ED jauh dengan pricipal (susu hibah)
4.	F04486	MORINAGA CHIL-KID 3 P-HP (1-3 THN) - KALBE	BOX	0	8/1/2025	24V0601AK	36	0	36	0	2	Bisa tukar ED jauh dengan pricipal (susu hibah)
5.	F04728	LIDODEX INJ 5% - BERNOFARM	AMP	0	8/1/2025	PIJ74550	1	0	1	0	0	Obat dari RSDH Probolinggo, substitusi peresepan lidocain inj
6.	F00271	EFAVIRENZ TAB 600 MG - KIMIA FARMA	TAB	0	10/1/2025	J32200J	3 00	0	3 00	0	0	Disesuaikan kebutuhan Pasien, Obat dari Dinkes Ed dekat
7.	F00849	ZIDOVUDINE CAPS - KIMIA FARMA	CAPS	0	01/10/2025	J21426J	335	0	335	0	16	Disesuaikan kebutuhan Pasien, Obat dari Dinkes Ed dekat
8.	F00542	NTG INJ 1 MG/ML - FERRON	VIAL	58,500	01/11/2025	5232161A	11	0	11	643,500	175	Dilakukan retur ke distributor dan evaluasi pembelian obat masuk dalam kategori slow moving
9.	F01390	FOLEY CATH NO 20 - RUSCH	PCS	20,5 70	11/1/2025		13	0	13	267,4 10	27	Dilakukan retur ke distributor dan evaluasi pembelian alkes masuk dalam kategori slow moving
10.	F01695	OXYGEN MASK ANAK - ONEMED	PCS	36,6 30	11/1/2025	OMC21149AX	5	0	5	183,150	33	Dilakukan retur ke distributor dan evaluasi pembelian alkes masuk dalam kategori slow moving
11.	F00669	REXIDRON TAB 200 MG - NOVELL	TAB	4,0 00	11/1/2025	25L379	493	0	493	1,972,000	255	Dilakukan retur ke distributor dan evaluasi pembelian obat masuk dalam kategori slow moving
12.	F00188	CEPEZET TAB 100 MG - MERSI	TAB	520	01/12/2025	A31852	101	0	101	52,520	3521	Dilakukan retur ke distributor dan evaluasi pembelian obat masuk dalam kategori slow moving
13.	F04695	PRENAGEN LACTAMOM 180 G - KALBE	BOX	0	01/12/2025	24T2801QAV	2	0	2	0	3	Bisa tukar ED jauh dengan pricipal (susu hibah)
14.	F04623	TOBRAMYCIN EYE DROP 5 ML - FERRON	BTL	16,000	01/12/2025	4140054	21	0	21	336,000	40	Koordinasi dengan pengadaan PT, history barang slow

												moving maka ketentuan ed barang > 2 tahun
SUB TOTAL Depo Farmasi :										3,460,580		

Data Obat Near ED Dari Depo IGD/IKO

DEPO IGD/IKO											
NO.	KODE	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA BELI	TGL. EXPIRE	NO. BATCH	JML. FISIK BAIK	TOTAL JUMLAH	TOTAL HARGA	PENJUALAN 2024	KETERANGAN
1.	F01682	NELATON CATH NO. 8 - RUSCH	PCS	11,500	01/08/2025	20J0161	2	2	23,000	2	Dilakukan retur ke distributor dan evaluasi pembelian alkes masuk dalam kategori slow moving
2.	F01391	FOLEY CATH NO 24 - RUSCH	PCS	24,2 00	9/1/2025	180630	7	7	169,4 00	13	Dilakukan retur ke distributor dan evaluasi pembelian alkes masuk dalam kategori slow moving
3.	F01679	NELATON CATH NO 10 - RUSCH	PCS	11,5 00	9/1/2025	KMA20K1129	2	2	23,0 00	13	Dilakukan retur ke distributor dan evaluasi pembelian alkes masuk dalam kategori slow moving
4.	F01680	NELATON CATH NO 12 - RUSCH	PCS	16,5 00	9/1/2025	KMA20KO441	2	2	33,0 00	4	Dilakukan retur ke distributor dan evaluasi pembelian alkes masuk dalam kategori slow moving
5.	F00924	BENANG PROLENE 2-0 W8026T - ETHICON	PCS	254,3 33	10/1/2025	QMBCCS	4	4	1,017,332	30	Telah dibuatkan surat edaran obat dan alkes near ED 070/RSPHS/I-PB/DIR/2024
6.	F00603	PEROSSAL 2X6 - DIPA PHARMALAB	PCS	231,0 00	10/1/2025	22KA14790	6	6	1,386,002	78	Koordinasi dengan pengadaan PT, history barang slow moving maka ketentuan ed barang > 2 tahun
7.	F01681	NELATON CATH NO 14 - RUSCH	PCS	16,5 00	11/1/2025	KMA20M0801	2	2	33,000	5	Dilakukan retur ke distributor dan evaluasi pembelian alkes masuk dalam kategori slow moving

8.	F01390	FOLEY CATH NO 20 - RUSCH	PCS	20,5 70	11/1/2025	p20I12	7	7	143,9 90	27	Dilakukan retur ke distributor dan evaluasi pembelian alkes masuk dalam kategori slow moving
9.	F00975	BENANG VICRYL 3-0 VCP311H - ETHICON	PCS	120,384	30/11/2025	SPBDCHWO	19	19	2,287,296	20	Telah dibuatkan surat edaran obat dan alkes near ED 070/RSPHS/I-PB/DIR/2024
SUB TOTAL Depo IGD/IKO :									5,116,020		

Data Obat Near ED dari Gudang Farmasi

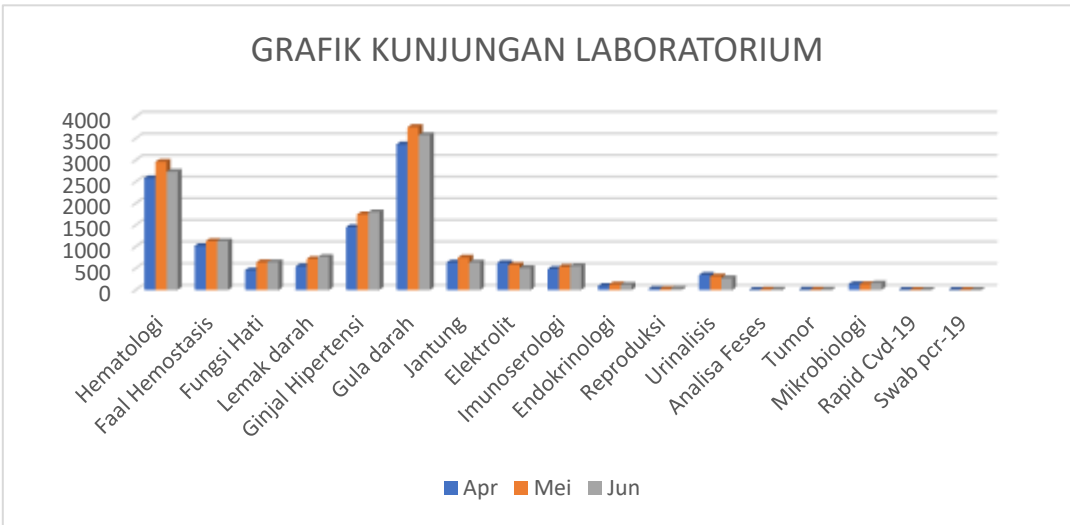
GUDANG FARMASI											
NO.	KODE	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA BELI	TGL. EXPIRE	NO. BATCH	JML. FISIK BAIK	TOTAL JUMLAH	TOTAL HARGA	PENJUALAN 2024	KETERANGAN
1.	F00292	ETHAMBUTOL TAB 400 MG (HIBAH)	TAB	0	6/1/2025	GFTB-SL512	1 96	1 96	0	215	Disesuaikan kebutuhan Pasien, Obat dari Dinkes Ed dekat
2.	F00274	EMTRIVIR TAB - SAMPHARINDO	TAB	0	9/1/2025	BEE52313A	3 00	3 00	0	585	Disesuaikan kebutuhan Pasien, Obat dari Dinkes Ed dekat
3.	F01356	ETT NON KING NO 35 - WORK	PCS	288,0 00	10/1/2025		3	3	864,0 00	5	Dilakukan retur ke distributor dan evaluasi pembelian alkes masuk dalam kategori slow moving
4.	F00669	REXIDRON TAB 200 MG - NOVELL	TAB	4,0 00	11/1/2025	256379	3 00	3 00	1,200,0 00	255	Dilakukan retur ke distributor dan evaluasi pembelian obat masuk dalam kategori slow moving
5.	F01196	CLIPPER BLADE - ONEMED	PCS	92,000	30/11/2025		19	19	1,748,000	BMHP	Disesuaikan kebutuhan BMHP IKO, Penggunaan Reuse
6.	F01364	ETT NON KING NO 7.5 - WORK	PCS	288,000	01/12/2025	21072010005	25	25	7,200,000	4	Dilakukan retur ke distributor dan evaluasi pembelian alkes masuk dalam kategori slow moving
7.	F04623	TOBRAMYCIN EYE DROP 5 ML - FERRON	BTL	16,000	01/12/2025	4140054	20	20	320,000	40	Koordinasi dengan pengadaan PT, history barang slow moving maka ketentuan ed barang > 2 tahun
SUB TOTAL Gudang Farmasi :									11,332,000		

1.4.2. LABORATORIUM

Tabel Kunjungan Pasien Laboratorium 2025

No	Jenis Pelayanan	Apr	Mei	Jun	Selisih	Prosentase Terhadap Bulan Sebelumnya
1	Hematologi	2579	2959	2729	-230	↓7.7%
2	Faal Hemostasis	1014	1126	1123	-3	↓0.26%
3	Fungsi Hati	450	637	639	2	↑0.31%
4	Lemak darah	544	715	759	44	↑6.15%
5	Ginjal Hipertensi	1445	1745	1794	49	↑2.08%
6	Gula darah	3361	3763	3574	-189	↓5.12%
7	Jantung	630	747	634	-113	↓15.12%
8	Elektrolit	622	577	506	-71	↓12.30%
9	Imunoserologi	481	528	552	24	↑4.54
10	Endokrinologi	90	125	117	-8	↓6.4%
11	Reproduksi	20	20	25	5	↑25
12	Urinalisis	344	311	270	-41	↓13.18%
13	Analisa Feses	3	7	7	0	0.00%
14	Tumor	4	4	5	1	↑25
15	Mikrobiologi	130	133	151	18	↑13.53
16	Rapid Cvd-19	2	1	0	-1	↓50%
17	Swab pcr-19	0	0	0	0	0.00%
18	Jumlah	11719	13398	12885	-513	↓3.82%

Grafik Kunjungan Pasien Laboratorium 2025



Tabel Analisa dan Rencana Tindak Lanjut

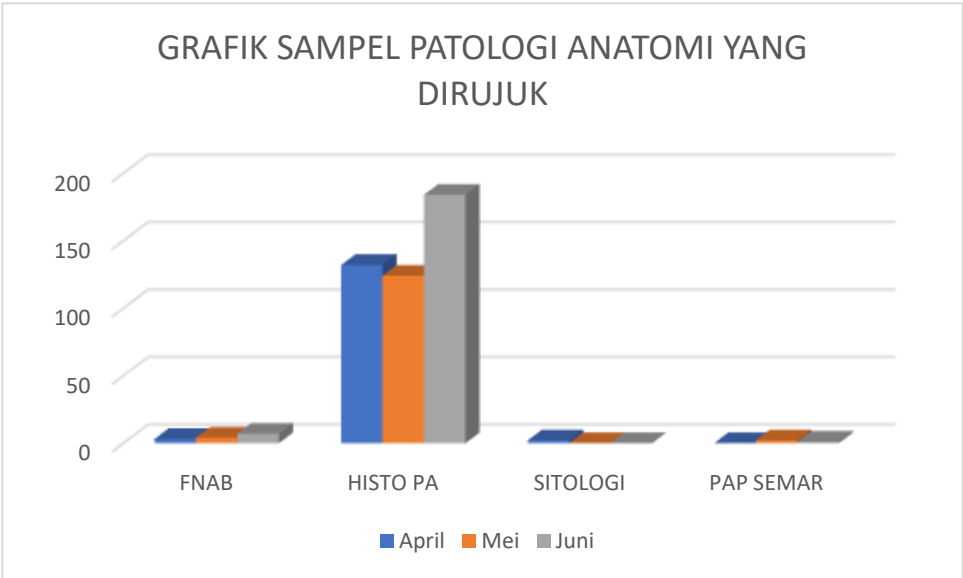
Analisa	Review Hasil Berdasarkan PDSA
1. Jumlah kunjungan laboratorium bervariasi antar jenis pelayanan 2. Beberapa pelayanan menunjukkan penurunan	Plan : - Melakukan koordinasi dengan bagian promosi rumah sakit untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pemeriksaan laboratorium. - Fokus pada edukasi dan promosi melalui media social dan kampanye internal di rumah sakit Do ; - Melakukan monitoring operasional alat bagian Hematologi, Elektrolit dan Jantung - Meninjau data pasien rawat jalan dan inap bulan Juni

	Study : • Pemeriksaan rutin (hematologi, elektrolit, gula darah) turun karena penurunan jumlah pasien. • Pemeriksaan khusus (urinalisis, mikrobiologi) meningkat karena peningkatan kasus infeksi atau pemeriksaan diagnosis tertentu. • Pemeriksaan feses dan swab stagnan karena tidak dilakukan secara rutin. Action : 24 Koordinasi lebih intensif antara tim laboratorium dan dokter penanggung jawab 25 Update berkala tentang capaian dan tren kunjungan 26 Edukasi dengan dokter terkait tentang pemeriksaan penunjang lanjutan
--	--

3.1.1. Tabel Data Sampel Patologi Anatomi

No	Jenis Pemeriksaan	April	Mei	Juni
1	FNAB	3	4	7
2	HISTO PA	132	124	184
3	SITOLOGI	2	0	0
4	PAP SMEAR	0	2	1
	TOTAL	137	130	192

Grafik Rujukan Patologi Anatomi



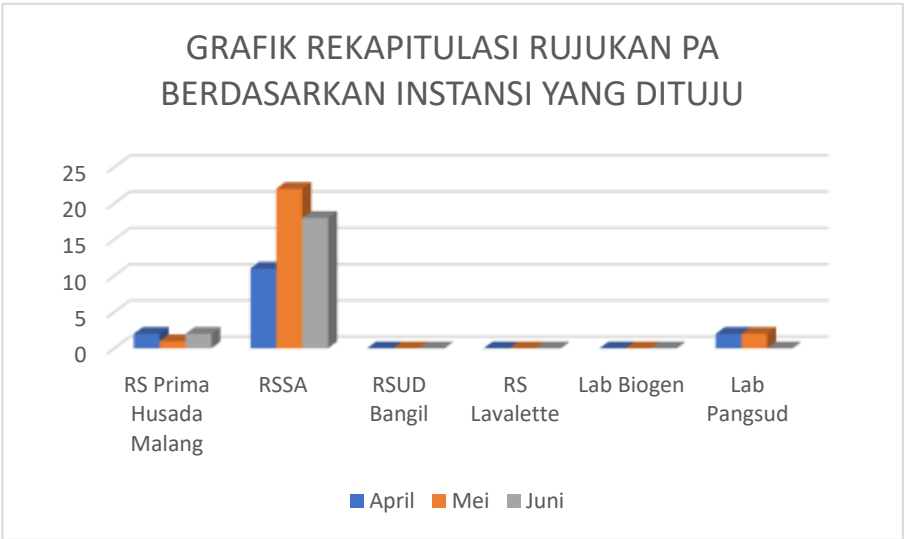
Analisa	Review Hasil Berdasarkan PDSA
1. Total pemeriksaan Patologi Anatomi meningkat dari bulan sebelumnya. 2. Pemeriksaan HISTO PA mendominasi data dengan proporsi yang sangat besar setiap bulannya. 3. Pap Smear tetap rendah dan fluktuatif karena digunakan pada kasus tertentu	Plan : • Merancang strategi untuk menjaga dan meningkatkan jumlah kunjungan pemeriksaan laboratorium secara menyeluruh Do : • Koordinasi dengan Instalasi Rawat Jalan (poli kandungan, bedah dan penyakit dalam) untuk meningkatkan rujukan pemeriksaan ini Study • Pemeriksaan Histo PA mengalami peningkatan tajam dikarenakan peningkatan tindakan bedah yang membutuhkan konfirmasi jaringan.

	• FNAB meningkat bertahap karena peningkatan tindakan bedah - Action • Mengembangkan program skrinning aktif untuk PAP SMEAR dan Sitologi di pelayanan primer • Memperkuat komunikasi dengan lab rujukan eksternal untuk mempercepat turnaround time dan laporan hasil • Monitoring bulanan terkait rujukan PA
--	--

1. Rekapitulasi sampel patologi klinis dirujuk berdasar Lab rujukan

No	Nama Rumah Sakit	April	Mei	Juni
1	RS Prima Husada Malang	2	1	2
2	RSSA	11	22	18
3	RSUD Bangil	0	0	0
4	RS Lavalette	0	0	0
5	Lab Biogen	0	0	0
6	Lab Pangsud	2	2	0
JUMLAH		JUMLAH	15	25

Grafik pemeriksaan patologi klinis yang dirujuk



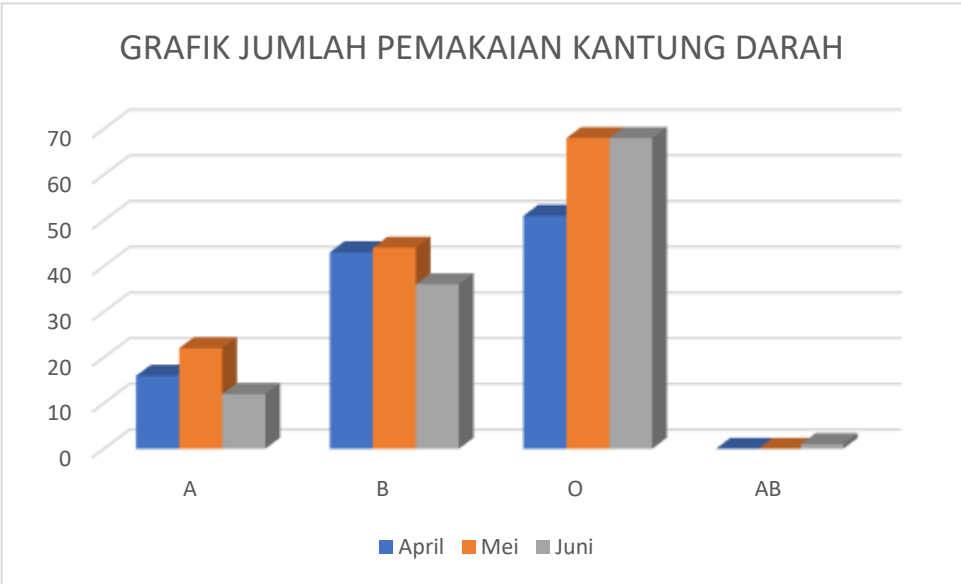
Analisa	Review Hasil Berdasarkan PDSA
1. RSSA merupakan Instansi dengan rujukan yang paling tinggi karena RSSA merupakan rumah sakit dengan tipe tertinggi di Malang	Plan : • Target selanjutnya melakukan peningkatan pemanfaatan fasilitas dengan mitra lain. • Melakukan review perjanjian Kerjasama dan kendala operasional. Do : • Koordinasi dengan rumah sakit dan Laboratorium alternatif • Sosialisasi ulang instansi rujukan PA yang tersedia kepada dokter pengirim. Study : • RSSA menjadi sasaran rujukan terbesar • RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan signifikan karena factor kecepatan pelayanan dan satu holding.

	- Total rujukan menurun di bulan Juni, meskipun distribusi ke beberapa instansi mulai lebih merata Action : - Meningkatkan Kerjasama dengan RS/lab yang masih belum dimanfaatkan.
--	---

2. Tabel jumlah pemakaian kantong darah

JENIS GOLDA	April	Mei	Juni	Jumlah
A	26	16	22	64
B	39	43	44	126
O	46	51	68	165
AB	0	0	1	0
Jumlah	111	110	134	355

Grafik pemakaian kantong darah



Analisa	Reviw Hasil Berdasarkan PDSA
1. Pemakaian darah dengan golongan darah O tertinggi dibandingkan golongan darah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap darah golongan O sangat tinggi, karena golongan ini bersifat donor universal. 2. Pemakaian darah dengan golongan darah B cenderung stabil dan cukup tinggi. Bisa jadi jumlah pasien dengan golongan darah B cukup konsisten di periode ini. 3. Pemakaian darah dengan golongan darah A mengalami peningkatan yang di bulan Mei dibandingkan bulan Sebelumnya. Perlu dievaluasi lebih lanjut. 4. Pemakaian darah dengan golongan darah AB sangat minim, tidak ada pemakaian pada bulan Mei. Ini mungkin disebabkan karena populasi	Plan : - Menjamin ketersediaan darah sesuai tren kebutuhan berdasarkan golongan darah - Koordinasi dengan PMI, pemetaan stok per golongan darah dan edukasi donor sukarela. Do : - Melakukan pemantauan stok darah dan penggunaan setiap hari. - Melakukan analisis kebutuhan tranfusi berdasarkan jenis layanan (opertif, emergensi, dll) Study : - Golongan O dominan dipakai disebabkan karena sifat universal donor terutama situasi darurat Action :

pasien dengan golongan darah AB memang sedikit atau keterbatasan penggunaan karena AB sebagai penerima universal	• Mengintegrasikan data historis untuk perencanaan kebutuhan stok berikutnya • Meningkatkan koordinasi dengan unit transfusi dan pemantauan pemakaian per unit
---	---

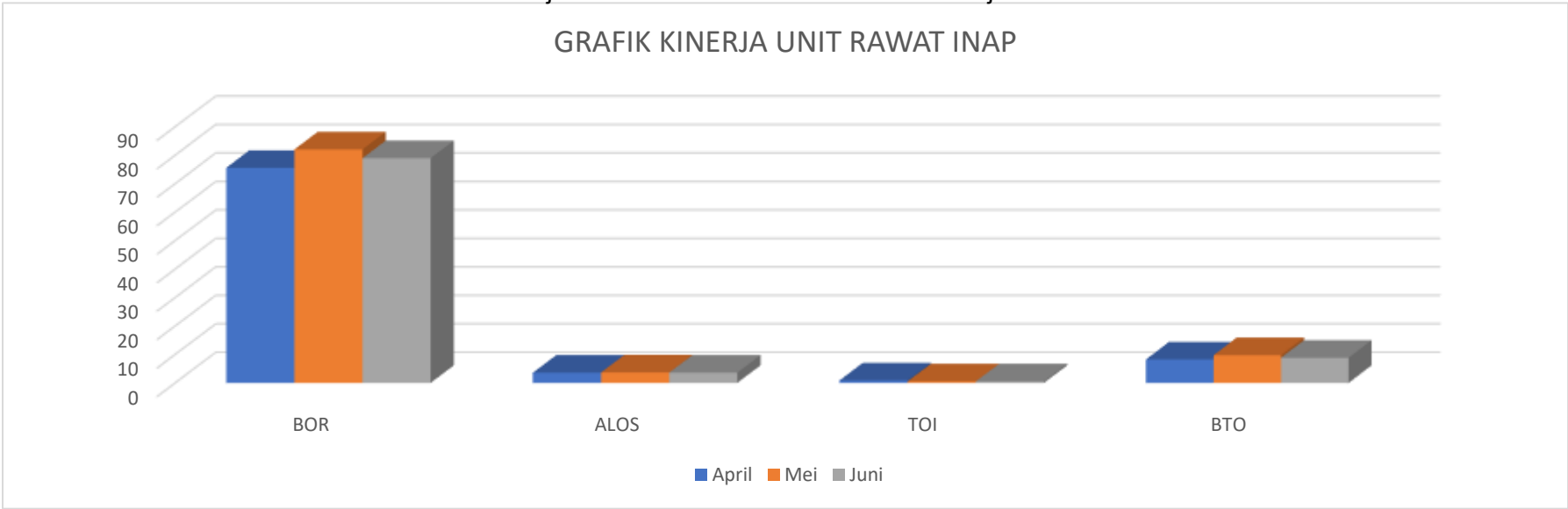
1.4.3. RM – PENDAFTARAN

Tabel Kinerja Unit Rawat Inap Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025

Indikator	Keterangan	Rumus	Data	Standar Depkes	Laporan	Ruang					Total	Ruang	Total Keseluruhan
						IRNA	MATER	ISOLASI	ICU	NICU		NEONATOLOGI	
BOR (Bed Occupancy Rate)	Prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu	$(\sum HP / (\sum TT \times \text{jumlah hari dalam satu periode})) \times 100$	Jumlah hari perawatan, jumlah TT, jumlah hari dalam satu periode	60% - 85%	April	98	79	21	18	0	79.5	36	75.57
					Mei	106	84	24	27	0	86.9	34	82.05
					Juni	104	84	20	4	0	84	30	78.97
ALOS (Average Length of Stay)	Rata-rata lama rawat seorang pasien	$LD / \sum px \text{ keluar } (H+M)$	jumlah lama dirawat, jumlah pasien keluar	6 - 9 hari	April	4	3	4	4	0	4	3	3.61
					Mei	4	3	4	4	2	4	3	3.68
					Juni	4	3	4	4	6	4	3	3.62
TOI (Turn Over Interval)	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati	$((\sum TT \times \sum \text{hari}) - HP) / \sum \text{pasien keluar } (H+M)$	Jumlah tempat tidur, hari perawatan, pasien keluar	1 - 3 hari	April	0	0	18	10	0	1	3	0.89
					Mei	0	0	11	5	248	0	3	0.57
					Juni	0	0	14	9	122	1	4	0.71
BTO (Bed Turn Over)	Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode	$\sum Px \text{ keluar } (H+M) / \sum TT$	Jumlah pasien. Jumlah TT	40 - 50 kali	April	10	13	1	3	0	8	6	8.27
					Mei	12	14	2	4	0	10	7	9.74

					Juni	11	13	2	3	0	9	6	8.85
NDR (Net Death Rate)	Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	$(\sum Px \text{ Mati} > 48 \text{ jm}) / \sum Px \text{ keluar (H+M)} \times 1000\%$	Jumlah pasien meninggal >48jm, jumlah pasien keluar	<25‰	April	5	0	80	71	0	14	0	13.44
					Mei	3	0	0	130	0	11	0	10.37
					Juni	3	0	31	172	0	12	0	11.41
GDR (Gross Death Rate)	Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	$(\sum Px \text{ mati} / \sum Px \text{ keluar (H+M)}) \times 1000\%$	Jumlah pasien keluar mati, jumlah pasien keluar	<45‰	April	29	0	160	393	0	35	0	32.99
					Mei	17	0	50	522	0	29	0	29.96
					Juni	16	0	63	517	0	12	0	22.82

Grafik Hasil Kinerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Tahun 2025

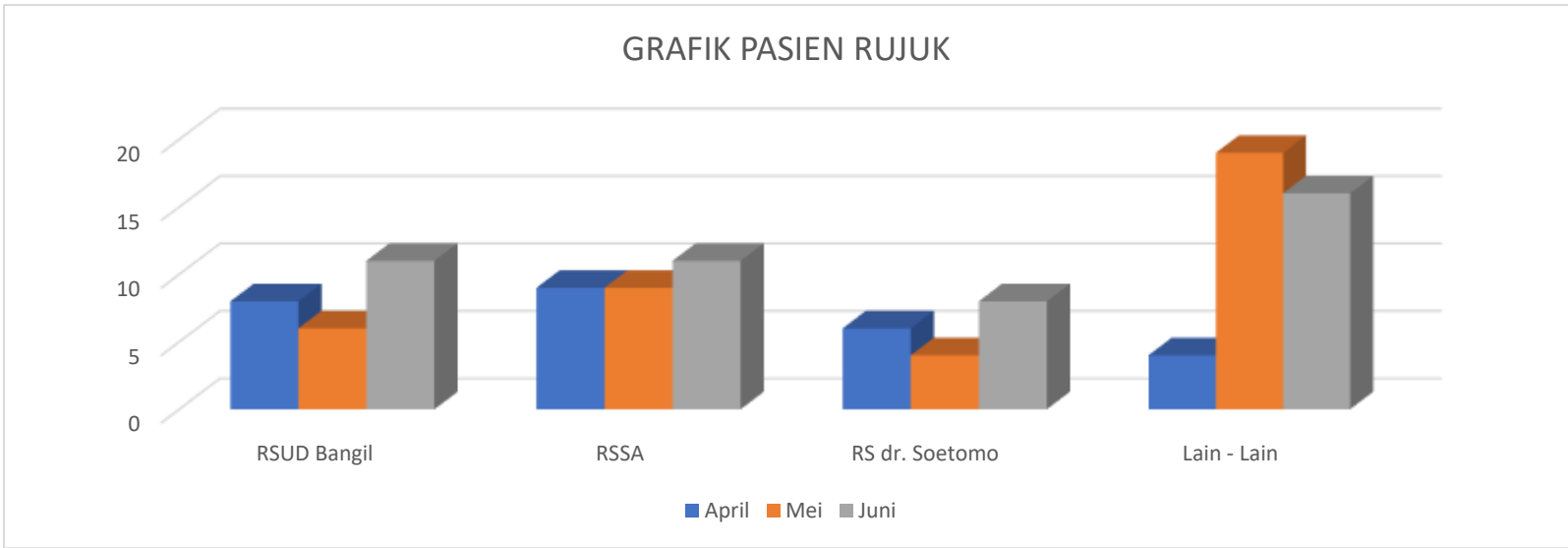


Analisis	Review Hasil
1. BOR : Tingkat hunian tempat tidur cukup optimal, masih dalam batas standar. 2. ALOS : Alos lebih rendah dari standar, menunjukkan efisiensi layanan tapi juga mencerminkan pemulangan pasien terlalu cepat. 3. TOI :hasil rendah menandakan efisiensi dalam penggunaan tempat tidur, karena tidak banyak waktu kosong antar pasien. 4. BTO (Bed Turn Over) : hasil jauh diatas standar, menunjukkan rotasi pasien yang tinggi.	Plan : - Meningkatkan pemanfaatan tempat tidur secara optimal. - Meningkatkan rotasi penggunaan tempat tidur Do : - Mengatur jadwal kerja tenaga medis untuk mencegah burnout akibat BTO tinggi Study : - BOR meningkat tiap bulan, pemanfaatan tempat tidur mengalami perbaikan - TOI membaik signifikan, mengindikasikan waktu kosong sebelum tempat tidur terisi menurun - ALOS stabil tetapi masih dibawah standar - BTO jauh dibawah standar, karena Tingkat hunian belum seimbang antar ruangan, ruangan seperti IKO, NICU masih belum terisi optimal Action : - Meningkatkan promosi pelayanan dan edukasi dokter - Meninjau distribusi tempat tidur dan pemanfaatan tiap ruang - Mengoptimalkan manajemen pasien masuk dan keluar

Tabel Data Pasien Rawat Inap Dirujuk Tahun 2025

Bulan	JML P-Rujuk	RS Penerima Rujukan				Alasan Rujuk				Dx		
	Eksternal	RSUD	RSSA	RS dr Soetomo	lain2	HD	Picu	Cat Lab	lain2	Anemia	Pneumoni	Lain2
April	28	8	9	6	5	4	2	1	21	2	0	26
	1.75%	28.57%	32.14%	21.43%	17.86%	14.29%	7.14%	3.57%	75.00%	7.14%	0.00%	92.86%
Mei	38	6	9	4	19	7	0	3	28	0	0	38
	2.03%	15.79%	23.68%	10.53%	50.00%	18.42%	0.00%	7.90%	73.68%	0.00%	0.00%	100.00%
Juni	46	11	11	8	16	11	1	1	33	0	1	45
	2.69%	23.91%	23.91%	17.39%	34.79	23.91%	2.17%	2.17%	71.74%	%	2.17%	97.83%

Grafik Pasien Rujukan



Analisis	Review Hasil
1. Terjadi fluktuasi dan peningkatan jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain. 2. RSUD Bangil dan RSSA merupakan RS penerima rujukan paling banyak	Plan : • Menurunkan jumlah pasien rujukan keluar (eksternal) dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas penanganan di fasilitas sendiri. Do : • Meningkatkan kualitas perawatan, meskipun data belum menyebutkan tindakan spesifik Study : • Rujukan meningkat di Bulan Juni • RS Besar seperti RSUD Bangil dan RSSA menunjukkan tren yang relative stabil Action : • Fokus peningkatan kapabilitas RS terhadap penanganan kasus yang masih sering dirujuk. • Meningkatkan akurasi pencatatan diagnose agar bisa menganalisis penyebab lebih rinci.

Tabel Data LOS pasien BPJS Kesehatan berdasarkan DPJP Tahun 2025
Data Lama Rawat Pasien BPJS Kesehatan Berdasarkan DPJP Bulan Juni Tahun 2025

Nama DPJP	Lama Dirawat (Hari)											Grand Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	
dr. Aan Dwi Prasetyo Sp.N	0	0	8	10	6	0	0	0	0	0	0	24
dr. Adhya Aji Pratama Sp.PD	0	0	35	12	9	6	3	3	1	0	0	69
dr. Aditya Purwaka Sp.PD	0	2	34	35	21	17	1	2	0	0	0	112
dr. Agung Wijaya Kusuma Sp.OG	0	7	21	0	1	0	0	0	0	0	0	29
dr. Ahmad Farid Wajdi Sp.N.	1	4	13	14	11	20	7	1	1	0	0	72
dr. Akhmad Zainul Arifin Sp.N, M.Kes	1	0	2	5	9	3	1	1	0	0	0	22
dr. Ardityo Rahmat Ardhany Sp.PD-KGH	1	3	6	13	8	0	0	0	0	0	0	31
dr. Arianto Prabowo Sp. OT	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0	9
dr. Badariyatud Dini Sp.BP-RE	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	9
dr. Cameleia Diah Setyorini Sp.PD	0	0	19	24	23	10	4	0	0	0	0	80
dr. Dimas Aryo Pamungkas Sp.PD	0	2	22	47	15	14	1	0	1	0	0	102
dr. Dio Mafazi Fabrianta Sp.U	0	1	5	2	1	0	0	0	0	0	0	9
dr. Dion Setiawan Sp.JP	0	2	12	5	1	0	0	0	0	0	0	20
dr. Djanuar Fitriadi Sp.B	0	1	36	11	2	1	0	0	0	0	0	51
dr. Esti Purwaningrum Sp.A.	0	8	33	19	14	2	0	1	0	0	0	77
dr. Fendi Fatkhurrohman Gozi Sp, BS	0	0	3	4	2	0	1	0	0	0	1	11
dr. Ferdyan Rachmat Efendi Sp.U	0	1	45	13	3	1	0	0	0	0	0	63
dr. Fiski Purantoro Sp.OT	0	0	12	2	1	0	0	0	0	0	0	15
dr. Fitri Indahyanti Sp.P., MMRS	0	2	5	11	10	2	1	1	0	0	0	32
dr. Fuad Fauzi Sp.T.H.T.K.L.	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	5
dr. I Gede Made Oka Rahaditya Sp. OT	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0	11
dr. Julian Hartawan Wijaya Sp.T.H.T.B.K.L	1	0	6	3	1	0	0	0	0	0	0	11
dr. Latifah Sp.M	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	8
dr. Maria Valentina Evelyn Sp. JP	0	2	7	4	3	1	0	0	0	1	0	18
dr. Muhammad Irawan Sp.A.	2	20	60	38	17	4	1	0	0	0	0	142
dr. Novita Maulidiyah Sp.P	0	4	12	35	7	0	0	0	0	0	0	58

dr. Nurhadhi Sutanto Sp. M	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
dr. Nyoman Indra Bayu Sp.M	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
dr. Qashastia Sukma Paripurna Sp.A	0	5	10	5	4	0	0	0	0	0	0	24
dr. Rachmawati Wardani Sp.N	0	0	5	7	3	2	0	1	0	0	0	18
dr. Ratih Kusumawardani Sp.A, M.Biomed	0	35	85	22	4	0	1	0	0	0	0	147
dr. Riski Bagus Suhendra Sp.DVE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
dr. Rossy Zaki Abdillah Sp.B	0	3	76	23	6	5	1	1	0	0	0	115
dr. Rudi Priyo Utomo Sp.OG	0	9	35	1	0	0	0	0	0	0	0	45
dr. Santoso Rahardjo Sp.OG.	1	14	48	5	0	1	0	0	0	0	0	69
dr. Zaki Yamani Sp.B	0	1	41	8	2	2	1	0	0	0	0	55
Grand Total	7	127	737	387	186	91	23	11	3	1	1	1574

C. Kelengkapan Pengisia E-RM

NO	NAMA DOKTER	Σ DRM ALL	PAM			CPPT			KELENGKAPAN			
			Σ DRM	L	TL	Σ DRM	L	TL	PAM		CPPT	
									%L	%TL	%L	%TL
1	dr. Muhammad Irawan Sp.A.	366	111	110	1	255	255	0	99.10%	0.90%	100.00%	0.00%
2	dr. Esti Purwaningrum Sp.A.	142	73	73	0	69	69	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
3	dr. Ratih Kusumawardani Sp.A, M.Biomed	269	113	110	3	156	155	1	97.30%	2.70%	99.40%	0.60%
4	dr. Rossy Zaki Abdillah Sp.B	418	111	111	0	307	307	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
5	dr Badariyatud Dini Sp.BP-RE	37	14	13	1	23	23	0	92.90%	7.10%	100.00%	0.00%
6	dr Fendi Fatkhurrohman Gozi Sp, BS	37	25	25	0	12	12	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
7	dr Maria Valentina Evelyn Sp. JP	591	41	41	0	550	550	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
8	dr Yekti Mumpuni Sp.KJ.	81	11	11	0	70	70	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
9	dr. Andika Widiarti Sp.K.J	186	22	22	0	164	163	1	100.00%	0.00%	99.40%	0.60%
10	dr. Rudi Priyo Utomo Sp.OG	250	75	75	0	175	174	1	100.00%	0.00%	99.40%	0.60%
11	dr. Santoso Rahardjo Sp.OG.	434	142	138	4	292	292	0	97.20%	2.80%	100.00%	0.00%
12	dr. Citra Dwi Harningtyas Sp.DV., M.Ked.Klin	121	32	31	1	89	89	0	96.90%	3.10%	100.00%	0.00%
13	dr. Nyoman Indra Bayu Sp.M	161	22	22	0	139	139	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
14	dr Nurhadhi Sutanto Sp. M	407	37	36	1	370	370	0	97.30%	2.70%	100.00%	0.00%
15	dr Arianto Prabowo Sp. OT	81	17	17	0	64	64	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
16	dr. I Gede Made Oka Rahaditya Sp. OT	225	53	53	0	172	172	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

17	dr. Fiski Purantoro Sp.OT	152	26	25	1	126	126	0	96.20%	3.80%	100.00%	0.00%
18	dr. Fitri Indahyanti Sp.P., MMRS	156	33	33	0	123	123	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
19	dr. Novita Maulidiyah Sp.P	259	53	51	2	206	206	0	96.20%	3.80%	100.00%	0.00%
20	dr Cameleia Diah Setyorini Sp.PD	448	74	71	3	374	374	0	95.90%	4.10%	100.00%	0.00%
21	dr. Dimas Aryo Pamungkas Sp.PD	865	176	176	0	689	689	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
22	dr. Aan Dwi Prasetyo Sp.N	300	36	36	0	264	264	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
23	dr. Ahmad Farid Wajdi Sp.N.	915	116	115	1	799	799	0	99.10%	0.90%	100.00%	0.00%
24	dr. Fuad Fauzi Sp.T.H.T.K.L.	47	23	23	0	24	24	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
25	dr Ferdyan Rachmat Efendi Sp.U	363	72	72	0	291	290	1	100.00%	0.00%	99.70%	0.30%
26	dr. Zaki Yamani, Sp. B	185	51	50	1	134	133	1	98.00%	2.00%	99.30%	0.70%
27	dr. Dio Mafazi Fabrianta Sp.U	63	22	21	1	41	41	0	95.50%	4.50%	100.00%	0.00%
28	dr. Aditya Purwaka Sp.PD	278	110	110	0	168	167	1	100.00%	0.00%	99.40%	0.60%
29	dr. Erinda Rahma Mulia Sp. FKR	610	115	114	1	495	491	4	99.10%	0.90%	99.20%	0.80%
30	dr. Eko Nugroho Sp. FKR	330	38	38	0	292	292	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
31	dr. Akhmad Zainul Arifin Sp.N, M.Kes	434	23	23	0	411	410	1	100.00%	0.00%	99.80%	0.20%
32	dr. Ardityo Rahmat Ardhany Sp.PD-KGH	77	11	11	0	66	66	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
33	dr. Latifah Sp.M	207	59	57	2	148	148	0	96.60%	3.40%	100.00%	0.00%
34	dr. Rachmawati Wardani Sp. N.	35	20	20	0	15	15	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
35	dr. Djanuar Fitriadi Sp.B	150	57	55	2	93	93	0	96.50%	3.50%	100.00%	0.00%
36	dr. Agung Wijaya Kusuma, Sp.OG	113	54	54	0	59	59	0	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%
37	dr. Adhya Aji Pratama, Sp.PD	114	52	52	0	62	62	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
38	dr. Julian Hartawan Wijaya Sp. T.H.T.B.K.L	220	111	111	0	109	109	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
39	dr. Dion Setiawan, Sp.JP	192	33	32	1	159	159	0	97.00%	3.00%	100.00%	0.00%
40	dr. Riski Bagus Suhendra, Sp.DVE	123	59	59	0	64	63	1	100.00%	0.00%	98.40%	1.60%
41	dr.Qashastia Sukma Paripurna, Sp.A	23	16	0	16	7	0	7	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
TOTAL		10465	2339	2297	42	8126	8107	19	98.20%	K	99.80%	K
				2339			8126					

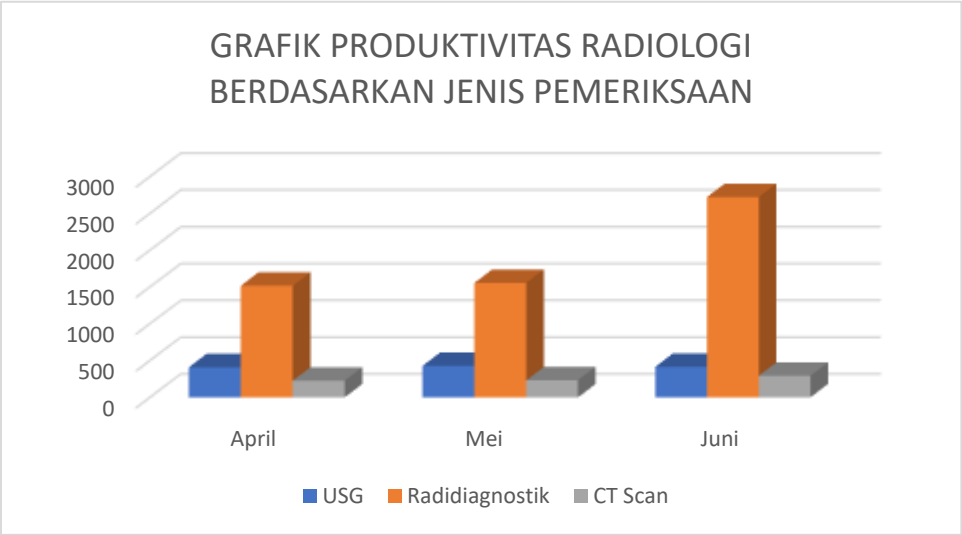
Analisa	Masalah	Rencana Tindak Lanjut
Adanya pengisian ERM yang belum lengkap, di pengkajian medis DPJP dibagian tolak ukur, tanda tangan pasien, tanda tangan dokter	Ketidaklengkapan pengisian ERM untuk pasien umum dan asuransi yang harus membuka billing, akses hanya dimiliki oleh kasir	Koordinasi dengan kepala unit/ kepal aruang terkait untuk supervisi pengisian DRM dengan lengkap

1.4.4. RADIOLOGI

Tabel Kinerja produktivitas Radiologi berdasarkan jenis pemeriksaan

PEMERIKSAAN	JENIS PEMERIKSAAN	PERIODE PEMERIKSAAN		
		April	Mei	Juni
USG	ABDOMEN/UROLOGI	353	363	363
	ABDOMEN CITO	2	2	0
	THORAX	5	5	3
	MAMMAE	6	7	3
	THYROID/COLLI	29	35	36
	TESTIS	9	14	8
	PAROTIS	0	0	0
	VASKULER	6	2	3
	ANKLE	0	0	0
	FEMUR	0	0	0
	KEPALA	0	0	0
	MANDIBULA	0	0	0
	TOTAL	410	428	416
RADIOLOGI	SKULL	12	12	13
	THORAX	932	943	2130
	EXTERMITAS ATAS	161	153	160
	EXTERMITAS BAWAH	176	180	158
	KUB/BNO	120	125	150
	PELVIS	20	17	18
	BABYGRAM	7	16	5
	CERVICAL	16	12	9
	THORACOLUMBAL	1	7	4
	LUMBOSACRAL	60	83	68
	IVP + KONTRAS	0	0	0
	URETROGRAFI	0	0	0
	COLON IN LOOP	0	0	0
	PANORAMIC	12	7	7
	WATERS	0	0	0
	TOTAL	1517	1555	2722
CT SCAN	KEPALA	157	142	195
	KEPALA DENGAN KONTRAS	4	9	7
	KEPALA TRAUMA	58	61	72
	THORAX	1	1	0
	THORAX DENGAN KONTRAS	0	0	0
	ABDOMEN	4	15	17
	ABDOMEN DENGAN KONTRAS	2	2	2
	PELVIS	0	1	0
	VERTEBRAE	0	0	0
	CERVICAL VERTEBRAE	0	0	0
	LUMBOSACRAL	0	0	0
	THORACAL VERTEBRAE NON KONTRAS	0	0	0
	THORAX VERTEBRAE	0	0	0
	CRURIS	0	0	0
	LUMBOSACRAL VERTEBRAE	0	0	0
	EKSTERMITAS LAIN	0	1	0
	TOTAL	226	232	293
TOTAL PEMERIKSAAN		2153	2215	3431

Grafik Produktivitas Radiologi Berdasarkan Jenis Pemeriksaan



Tabel 3.4.1.2 Analisa Data

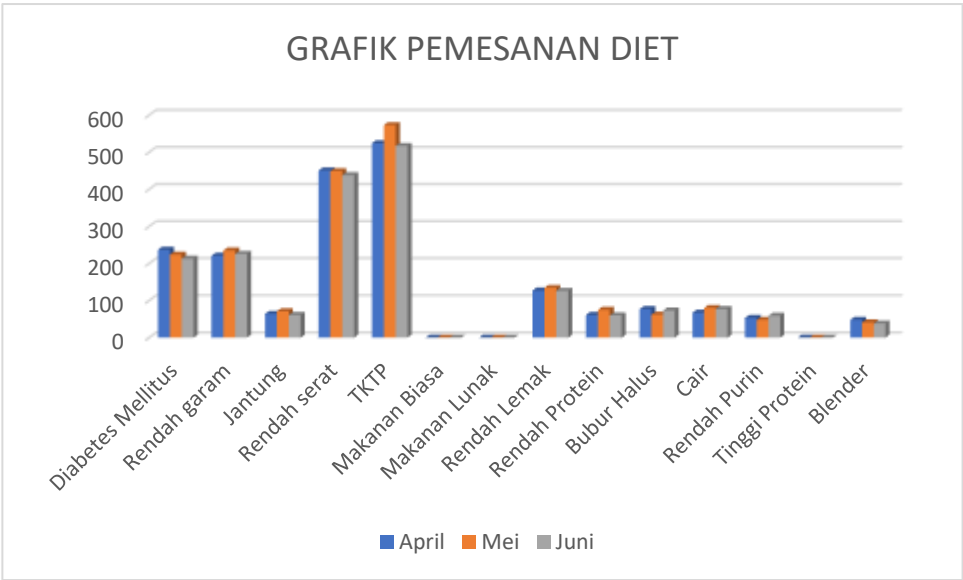
Analisa		Review Hasil Berdasarkan PDSA	
1.	Terjadi peningkatan signifikan total jumlah pemeriksaan dari bulan April ke bulan Juni	Plan : • Menyesuaikan jadwal dan shift kerja radiographer • Evaluasi ketersediaan alat dan BMHP • Do ; • Mengoptimalkan penggunaan alat • Sosialisasi ulang pentingnya pemeriksaan pendukung bagi faskes pengirim Study : • Kenaikan pemeriksaan thorax dikarenakan kegiatan MCU dari salah satu rekanan • Peningkatan CT Scan Kepala dikarenakan peningkatan trauma Action • Maintenance berkala untuk alat – alat radiologi agar penurunan produksi karena kerusakan bisa dicegah • Komunikasi intensif dengan unit pengirim untuk menjaga kesinambungan rujukan	

1.4.5. GIZI

A. Tabel Kinerja Produktivitas Gizi Berdasarkan Jenis pemesanan diet Pasien

Pemesanan Diet				
No	Nama Diet	April	Mei	Juni
1	Diabetes Mellitus	237	224	213
2	Rendah garam	221	235	226
3	Jantung	64	71	61
4	Rendah serat	451	449	438
5	TKTP	524	573	517
6	Makanan Biasa	0	0	0
7	Makanan Lunak	0	0	0
8	Rendah Lemak	127	134	126
9	Rendah Protein	61	75	60
10	Bubur Halus	77	62	73
11	Cair	67	80	77
12	Rendah Purin	53	48	59
13	Tinggi Protein	0	0	0
14	Blender	48	41	38
TOTAL		1833	1930	1888

Grafik Pemesanan Diet Pasien



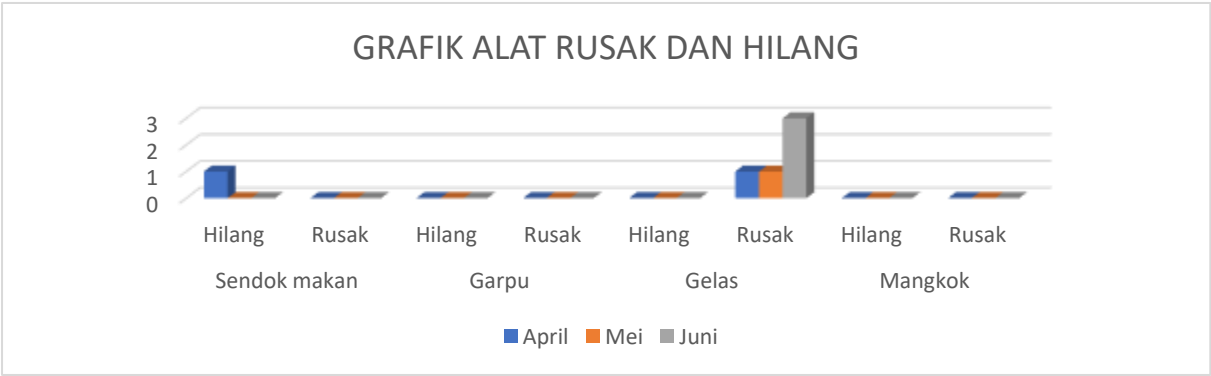
Tabel Analisa Data

Analisa	Review Hasil Berdasarkan PDSA
1. Diet TKTP sangat dominan dan konsisten tinggi tiap bulan 2. Diet rendah lemak, jantung, rendah garam, rendah protein menunjukkan kebutuhan khusus yang berulang	Plan : - Menyediakan diet yang sesuai dengan indikasi medis dan kebutuhan gizi pasien. - Mengoptimalkan system distribusi dan permintaan diet agar lebih efisien dan tepat sasaran - Mengidentifikasi pola pemesanan diet untuk perencanaan kebutuhan bahan makanan dan SDM Do : - Penyediaan bahan makanan difokuskan pada jenis diet dengan frekuensi tinggi (TKTP, rendah garam, serat)

	Study : - Mayoritas diet dipesan untuk penyakit kronis/ metabolic → cerminan epidemiologi pasien. - TKTP naik signifikan → indikasi pasien dengan pemulihan - Diet seperti blender dan rendah purin meskipun kecil, tetap harus tersedia karena menyasar kondisi klinis khusus. Action : - Melakukan konsolidasi penyediaan bahan pokok utama untuk diet TKTP, DM dan rendah garam karena 3 jenis ini menyumbang mayoritas permintaan - Evaluasi dan update indicator mutu layanan gizi ➤ Kepuasan pasien terhadap makanan
--	--

Data Alat Rusak dan Hilang

Bulan	Sendok makan		Garpu		Gelas		Mangkok	
	Hilang	Rusak	Hilang	Rusak	Hilang	Rusak	Hilang	Rusak
April	1	0	0	0	0	1	0	0
Mei	0	0	0	0	0	1	0	0
Juni	0	0	0	0	0	3	0	0



Analisa Data

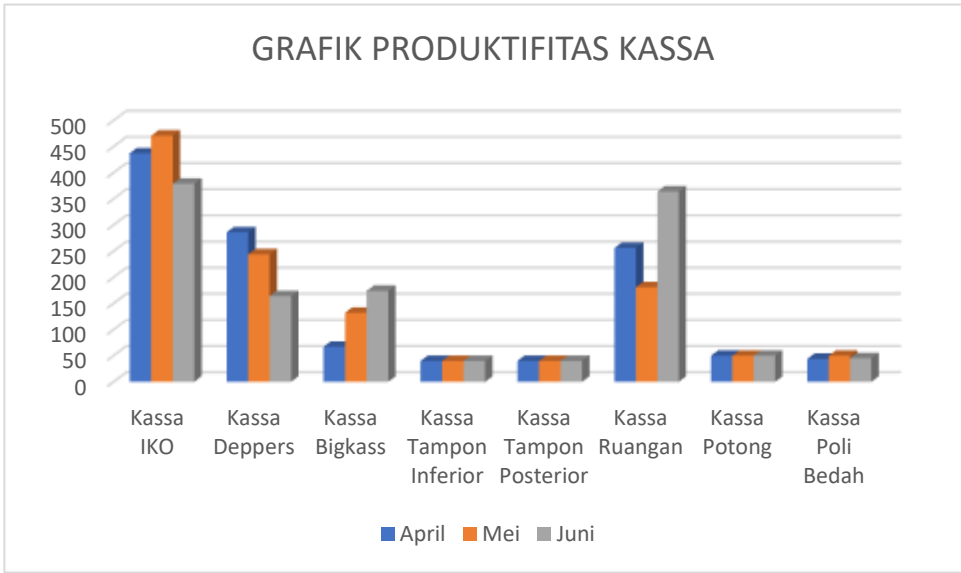
Analisa	Review Hasil
1. Potensi penyebab utama kehilangan dan kerusakan adalah human error	Plan: - Memberi label alat makan - Membuat prosedur pengawasan dan pencatatan alat makan lebih ketat - Edukasi petugas dan pengguna layanan terkait pentingnya menjaga peralatan Do : - Menggunakan label/ penandaan pada alat makan yang memungkinkan - Menerapkan system tanggung jawab bergilir atau kontrol oleh tim yang bertugas Study : - Terjadi penurunan signifikan pada kasus kehilangan. Action : - Mempertahankan system pemantauan dan edukasi yang telah menurunkan kehilangan alat. - Meningkatkan kesadaran staf akan tanggung jawab terhadap alat. - Evaluasi bulanan tetap dilakukan untuk mencegah tren naik kembali.

1.4.6. Instalasi CSSD

Tabel Kinerja Produktivitas CSSD Berdasarkan Produksi Kassa 2025

No	Jenis Kassa	April	Mei	Juni
	Bahan BJ			
1	Kassa IKO	437	471	379
2	Kassa Deppers	286	244	164
3	Kassa Bigkass	67	132	174
4	Kassa Tampon Inferior	40	40	40
5	Kassa Tampon Posterior	40	40	40
	Bahan Hidrofil			
1	Kassa Ruangan	256	181	364
2	Kassa Potong	50	50	50
3	Kassa Poli Bedah	44	50	45

Grafik Produktivitas Kassa



Tabel 3.6.1.2 Analisa Data

Analisa	Review Hasil Berdasarkan PDSA
1. Terjadi fluktuasi jumlah produksi kassa pada beberapa jenis, terutama kassa deppers dan kassa ruangan. 2. Jenis kassa seperti tampon dan potong cenderung stabil, menunjukkan permintaan tetap.	Plan : • Mengevaluasi permintaan unit pengguna • Memantau produksi internal Do ; • Memonitoring dan mencatat data realisasi pemakaian kassa di seluruh unit pelayanan. • Menyesuaikan produksi berdasarkan data permintaan actual dari unit pelayanan. • Optimalisasi SDM CSSD untuk distribusi produksi agar tidak overload di jenis tertentu. • Penerapan jadwal produksi harian/pekanan berdasarkan forecast kebutuhan. Study ;

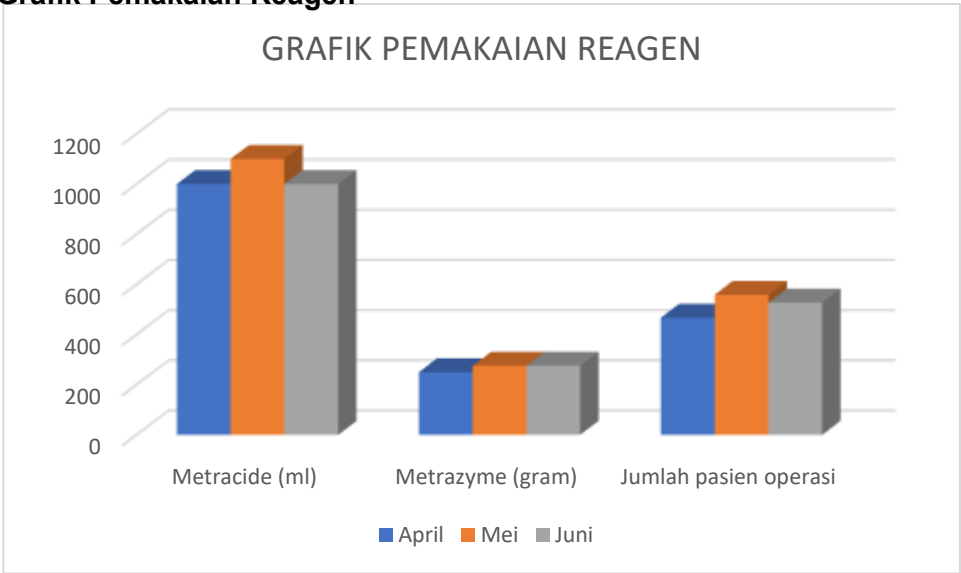
	• Kassa IKO tetap mendominasi, namun cenderung menurun karena menurunnya jumlah tindakan operasi • Kassa ruangan meningkat tajam karena peningkatan permintaan dari ruangan Action • Meningkatkan monitoring permintaan dan pemakaian dengan cara menerapkan form monitoring harian dari unit pengguna • Menyesuaikan produksi
--	---

3.6.1 Reagen

Tabel 3.6.2.1 Pemakaian Reagen

Bulan	Metracide (ml)	Metrazyme (gram)	Jumlah pasien operasi
April	1000	250	467
Mei	1100	275	558
Juni	1000	275	527

Grafik Pemakaian Reagen

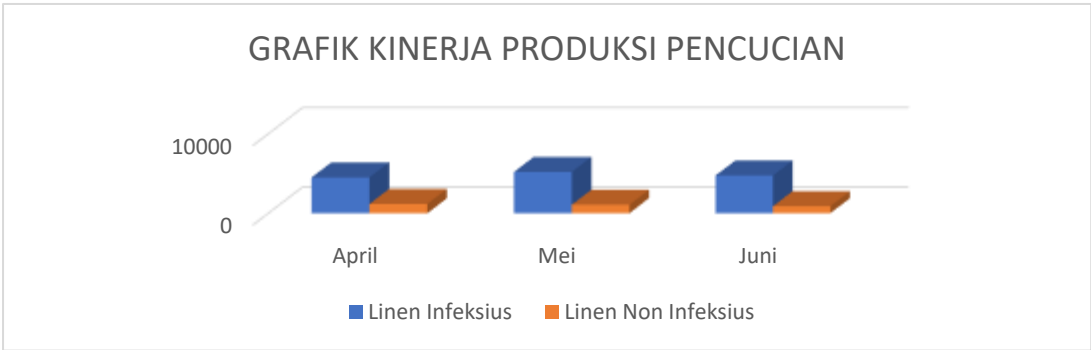


1.4.7. LAUNDRY

Tabel Kinerja Produktivitas Laundry Berdasarkan Jenis Linen 2025

No	Jenis Linen	April	Mei	Juni
		Dalam Kg		
1	Linen Infeksius	4506	5197,6	4737,2
2	Linen Non Infeksius	1155	1057	884,6
	JUMLAH	5661	6254,6	5621,8

Grafik produktivitas linen



Analisis	Review Hasil Berdasarkan PDCA
1. Linen infeksius mendominasi volume pencucian setiap bulan. 2. Pola ini konsisten dan menunjukkan beban utama pada linen infeksius	Plan : - Meningkatkan efisiensi dan produktivitas pencucian linen, baik infeksius maupun non infeksius dengan menjaga standar kebersihan dan keamanan. Do : - Proses pencucian dijalankan secara rutin setiap bulan sesuai dengan SPO - Pemisahan linen infeksius dan non infeksius dilakukan dengan benar. - Meningkatkan koordinasi antar unit dan penggunaan alat yang memadai. Study : - Volume relative stabil, menunjukkan proses berjalan dengan konsisten. - Linen non infeksius mengalami peningkatan, dikarenakan adanya peningkatan jumlah pasien non infeksius. Action : - Menetapkan efisiensi penanganan linen infeksius dengan pelatihan tambahan bagi petugas. - Mengevaluasi jumlah kebutuhan linen non infeksius agar sesuai dengan kebutuhan actual - Memonitoring linen setiap bulan

Tabel Stok Linen di Unit

No	Ruangan	Jenis Linen	Stok Mei	Stok Juni				Ket
				rusak	hilang	Pergantian Linen Rusak	Sisa Stok	
1	IRNA 3A	Sprei	78	0	0	0	78	
		Selimut Hijau	66	0	1	0	65	
		Sarung Bantal	94	0	0	0	94	
		Selimut Coklat	45	0	0	0	45	
		Selimut VIP	25	0	0	0	25	
2	Maternitas	Sprei	60	0	1	0	59	
		Selimut Hijau	50	2	2	0	46	
		Sarung Bantal	31	0	0	0	31	
		Selimut Coklat	6	0	0	0	6	
3	IRNA 2A	Sprei	54	2	2	0	50	
		Selimut Hijau	57	1	0	0	56	
		Sarung Bantal	89	1	4	0	84	
4	IRNA 2B	Sprei	67	3	2	0	62	
		Selimut Hijau	57	1	1	0	55	
		Sarung Bantal	69	2	0	0	67	
		Selimut Coklat	7	0	0	0	7	
5	IRNA 3B	Sprei	54	1	0	0	53	
		Selimut Hijau	79	0	0	0	79	
		Sarung Bantal	71	0	0	0	71	
6	ICU	Sprei	12	1	0	0	11	
		Selimut Hijau	13	0	0	0	13	

		Baju px	11	0	0	0	11	
7	PERIN	Sprei	20	0	0	0	20	
		Selimut Hijau	20	0	0	0	20	
		Sarung Bantal	20	0	0	0	20	
8	REHAB	Sprei	24	0	0	0	24	
		Selimut	23	0	0	0	23	
		Sarung Bantal	19	0	0	0	19	
9	IKO	Gown	56	0	0	0	56	
		Baju Pasien	15	3	0	25	37	
		Baju Tim	36	0	0	0	36	
		Alas Meja Operasi	66	0	0	0	66	
		Duk Kaki	4	0	0	0	4	
		Duk Lubang (B)	16	0	0	0	16	
		Meja Mayo	43	0	0	0	43	
		Duk Kecil	54	1	0	0	54	
		Duk Doble	13	0	0	0	13	
		Duk Sedang	70	0	0	0	70	
		Duk Lubang (K)	42	0	0	0	42	
		Duk Buntu	25	0	0	0	25	
		Selimut Hijau	10	0	0	0	10	
		Handuk	40	0	0	0	40	
10	IGD	Selimut Hijau	32	0	0	0	32	
11	Poli	Selimut Coklat	22	0	0	0	22	
		Sarung Bantal	11	0	0	0	11	
12	IRNA 2D	Sprei	31	1	0	0	30	
		Selimut Hijau	31	0	0	0	31	
		Sarung Bantal	31	0	0	0	31	

Analisa	Review hasil Berdarakan PDSA
1. Linen non infeksius lebih banyak dibanding linen infeksius 2. Ruang rawat inap mendominasi untuk jumlah linen yang hilang dan rusak	Plan : • Meningkatkan pengawasan penggunaan linen di unit karena unit penyumbang kerusakan tertinggi • Melakukan penggantian linen rusak secara berkala setiap bulan. Do : • Sosialisasi penggunaan dan perawatan linen kepada staf. • Monitoring dan pencatatan harian penggunaan linen dengan benar Study : • Linen infeksius masih lebih sedikit dibanding non infeksius, namun sesuai dengan kebutuhan klinis. • Ruangan rawat inap seperti IRNA 3A dan IRNA 2A menunjukkan tren penggunaan tinggi dan kerusakan, menandakan perlunya perhatian khusus terhadap kualitas dan frekuensi pemakaian Action : • Tindakan tegas unit dengan kerusakan/ kehilangan tertinggi untuk melakukan evaluasi internal. • Targetkan unit paling bermasalah untuk prioritas supervisi

3.5 Kinerja Umum dan Keuangan

3.5.1 IPSRS

Data Pemeliharaan dan Perbaikan Alkes Tahun 2025

Bulan	Jumlah Alkes	Jumlah Pemeliharaan Alkes / Prosentase	Jumlah Perbaikan Alkes / Prosentase	Jumlah Kalibrasi Alkes /Prosentase	Jumlah Recall Alkes	Keterangan
Januari	378	242 (64.02%)	6 (1.58%)	296 (78.31%)	0	0
Februari	378	232 (61.37%)	7 (1.85%)	296 (78.31%)	0	0
Maret	383	215 + 133 = 348 (90.86%)	5 (1.31%)	296 (77.28%)	0	0
April	383	119 + 90 = 209 (54.56%)	4 (1.04%)	296 (77.28%)	0	0
Mei						
Juni						
Juli						
Agustus						
September						
Oktober						
November						
Desember						
Total						
Rata-Rata /Bulan						

Pada Januari 2024, dilakukan 2 uji fungsi alat yaitu USG Convex dan Linear di Poli Urologi dan Spirometry di IRNA 2A.

A. Sistem Utilitas

1. Listrik

a. Kegagalan Listrik

Kegagalan Listrik Tahun 2025

Bulan	Jumlah Kegagalan Listrik	ncian Waktu Kegagalan Listrik	Lokasi	Analisis	RTL
Januari	1	18/01/2025	1. Seluruh area (PLN off dan Genset tidak bisa nyala)	1. Accu genset waktunya penggantian	1. Penggantian accu genset
Februari	2	15/02/2025 pukul 12.05	1. Seluruh area (PLN off dan Genset on).	1. PLN Off	Memastikan genset ready to use
		23/02/2025	1. Seluruh area (PLN off	1. PLN Off	Memastikan genset ready to

Bulan	Jumlah Kegagalan Listrik	ncian Waktu Kegagalan Listrik	Lokasi	Analisis	RTL
		off pukul 09.38, on Kembali 10.54	dan Genset on).		use
Maret	0	-	-	-	-
April	3	04/2025 PLN off , Genset On 13.22 N off lagi 14.00 N ON 14.25	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
		04/2025 N off , Genset On 10.07 N on, Genset off 10.36	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
		04/2025 N off , Genset On 17.44 N on, Genset off 18.07	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
Mei					
Juni					
Juli					
Agustus					
September					
Oktober					
November					
Desember					
Rata-Rata					

B. Pemeliharaan dan Perbaikan Listrik
 Pemeliharaan dan Perbaikan Panel Listrik Tahun 2025

Bulan	Jumlah Panel Listik	Pemeliharaan	Perbaikan	Analisis
Januari	29	0	0	-
Februari	32	32	0	Dalam kondisi baik
Maret	32	32	0	Dalam kondisi baik
April	32	0	32	Dalam

Bulan	Jumlah Panel Listik	Pemeliharaan	Perbaikan	Analisis
				kondisi baik
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
Rata-Rata				

C. Pengaduan Billing IPSRS
 Pengaduan Billing IPSRS Tahun 2025

Bulan	Jumlah Pengaduan Billing IPSRS yang terselesaikan	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Unit IPSRS	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Tukang	Prosentase/ Jumlah Pengaduan IT	Rincian Prosentase Pengaduan IPSRS
Januari	63 (100%)	49 (77.78%)	14 (22.22%)	0	Tukang = 14 AC = 31 Alkes = 2 Bed = 2 Bel = 2 Diswashing =1 Kursi = 2 Lampu = 4 Listrik = 1 Mesin Pengereng = 1 Tiang Infus = 2 Trolis = 1
Februari	80 (100%)	44 (55%)	36 (45%)	0	Tukang = 36 IT = 0 AC = 23 Alkes = 5 Lampu = 4 Kursi = 1 Dispenser = 1 Bell = 4 Roda Nakas =1 Roda Standar Infus = 2

Bulan	Jumlah Pengaduan Billing IPSRS yang terselesaikan	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Unit IPSRS	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Tukang	Prosentase/ Jumlah Pengaduan IT	Rincian Prosentase Pengaduan IPSRS
					Televisi = 2 Kulkas = 1
Maret	76 (100%)	60 (78.95%)	16 (21.05%)	0	Tukang = 16 IT = 1 AC= 24 Alkes = 8 Lampu dan Listrik = 7 Diswashing Pantry = 1 Dispenser=3 Exhaust = 2 Kursi = 3 Bell = 5 Handrail = 2 Nursecall= 2 Bed = 2
April	72 (100%)	37 (51.39%)	35 (48.61%)	0	Tukang = 35 IT = 0 AC= 22 Alkes = 1 Heater = 1 Dispenser=3 Lampu dan Stop Kontak =7 Trolis/ Solo= 2 Nursecall = 1
Mei					
Juni					
Juli					
Agustus					
September					
Oktober					
November					
Desember					
Total/ Tahun					
Rata-Rata/ Bulan					

Terdapat 63 pengaduan yang telah diselesaikan oleh IPSRS, Tukang pada Januari 2025. Terdapat 49 (77.78%) pengaduan yang diselesaikan oleh IPSRS dan 14 (22.22%) pengaduan yang diselesaikan oleh tukang bangunan.

D. Pemeliharaan dan Perbaikan AC
 Pemeliharaan dan Perbaikan AC

Bulan	Jumlah AC	Pemeliharaan	Perbaikan	Analisis
Januari	172	0	31 (18.02 %) (Berdasarkan billing SIM IPSRS)	-
Februari	172	0	23 (13.37%) (Berdasarkan billing SIM IPSRS)	
Maret	172	50 (29.07%)	24 (13.95%)	
April	172	0	22 (12.79%) (Berdasarkan billing SIM IPSRS)	
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
Total/Tahun				
Rata-Rata / Bulan				

3.5.2 Parkir

A. Pendapatan Parkir Tahun 2025

Bulan	Total Pendapatan (Rp)	Pajak (Rp)	Keterangan
Januari	114.848.000	1.076.100	-
Februari	108.388.000	1.017.000	-
Maret			
April			
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			

Dari table tersebut diatas terdapat penurunan pendapatan parkir dari januari ke februari karena jumlah hari kalender hanya 28 hari. Tetapi secara rata – rata harian mengalami kenaikan

daripada bulan sebelumnya

B. Pengembangan Parkir

Rencana pembangunan parkir bertingkat untuk sepeda motor (samping IPAL baru)

3.5.3 Humas Marketing

A. Data MCU Pihak Eksternal

No	Bulan	Jumlah Pasien	Review
1	Februari	199	Analisis : Berdasarkan data tersebut, jumlah pasien Medical Check Up Turun di 3 bulan terakhir. Review hasil kunjungan dengan PDSA Plan 1. Meningkatkan kunjungan ke Perusahaan 2. Mempromosikan program MCU 3. Mereview tarif/biaya pemeriksaan 4. Meningkatkan pelayanan MCU Do 1. Mempromosikan program MCU setiap kali melakukan kunjungan ke instansi Perusahaan 2. Koordinasi dengan bagian keuangan terkait review tarif MCU agar bisa bersaing dengan vendor lain Study 1. Harga MCU mempengaruhi jumlah kunjungan MCU 2. Perusahaan memilih harga MCU paling murah diantara vendor 3. Banyak perusahaan memilih MCU yang ditawarkan secara gratis dari klinik rekanan BPJS kesehatan karena hanya sebagai syarat pemenuhan dari Disnaker terkait kesehatan karyawan. 4. Peningkatan pelayanan MCU mempengaruhi loyalitas perusahaan Action 1. Pengajuan MCU ke berbagai Perusahaan 2. Memperbaiki alur pelayanan MCU dengan membuat SPO 3. Mereview ulasan kepuasan terkait pelayanan MCU 3. Mengirimkan penawaran MCU by Watshap Kepada seluruh rekanan perusahaan
2	Maret	109	
3	April	60	

B. Jumlah Kunjungan Pasien Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Pasien				
		Rawat Inap	Rawat Jalan	IGD	Rata Px RI per hari	Rata Px RJ per hari
1	Februari	1446	11177	1768	51,64	399,17
2	Maret	1671	11132	1860	53,90	359,09
3	April	1597	10514	1945	53,23	350,46

Analisis : Berdasarkan data diatas 1. Kunjungan IRNA mengalami kenaikan dari Bulan Maret ke April sebesar 4.76% 2. Kunjungan IRNA terbanyak di Bulan April 2025 adalah spesialis anak sejumlah 390 pasien diikuti dengan spesialis penyakit dalam sejumlah 385 pasien. 3. Kunjungan IRNA dengan kenaikan tertinggi adalah spesialis penyakit dalam sebesar 0.75% 4. Kunjungan IRNA dengan penurunan tertinggi adalah spesialis anak sebesar 2.88% Review hasil kunjungan pasien. Plan 1. Melakukan promosi kepada faskes pertama,Bidan Praktik Mandiri, Dokter Praktik Mandiri dan instansi Perusahaan. 2. Membuat digital marketing kolaborasi dengan Tim PKRS 3. Melakukan marketing internal kepada pasien, keluarga pasien dengan metode penyuluhan kesehatan berbasis promosi Do 1. Meningkatkan kinerja Humas Marketing ke FKTP, BPM/DPM, dan instansi Perusahaan dalam mempromosikan dan melayani para perujuk. 2. Melakukan digital marketing kolaborasi dengan Tim PKRS 3. Kolaborasi dengan kepala bidang terkait dalam pengkondisian DPJP, pelayanan, dan fasilitas untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. Study 1. Keterlambatan DPJP dalam melakukan praktek akan mempengaruhi kinerja pelayanan di Rumah Sakit. 2. Ketidakhadiran dokter di Rumah Sakit akan mempengaruhi jumlah kunjungan pasien. 3. Pelayanan yang kurang baik akan memunculkan komplain dari pasien. Action 1. Perbaiki pelayanan di IGD dan rawat inap a. Meningkatkan Komunikasi -Koordinasi antara Humas dg IGD b. Meningkatkan Komunikasi -Koordinasi antara Humas dg Perujuk c. Meminta Umpan Balik dari perujuk atas Pelayanan yang telah diterima d. Meningkatkan Komunikasi -Koordinasi antara Humas dg Perusahaan
--

C. Pencapaian Kinerja PKS – IKS Pada Bulan Desember 2024 – Februari 2025 di RSPHS

No	Bulan	Target	Jumlah				
			Masih Berlaku	ED	IKS Lama	Baru	Pro gres
1	Januari	5 PKS	101	16	114	1	4
2	Februari	5 PKS	102	1	114	1	5
3	Maret	5 PKS	102	1	114	0	4
Analisis ; Asuransi PT Equity Life Indonesia Ri Cassless sudah di ttd pihak equity akan dikirimkan ke rumah sakit, 1. Pada bulan Februari semua IKS, MOU baru dengan instansi lain masih dalam progress, diantaranya : BRI life, Lippo General Insurance, PT Teknologi pamadya analitika, PT Cheil Jedang, Prudensial syariah 2. RTL : 1. Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke PT maupun ke provider							

D. Progress IKS Baru Bulan Februari Tahun 2025

No	Nama PKS	Progres Pengurusan	Kendala
1	BRI life	Review pihak eksternal	Tidak ada
2	Lippo General Insurance	Review pihak eksternal	Tidak ada
3	PT Teknologi Pamadya Analitika (Meditap)	Kurang checklist	Tidak ada
4	PT Cheil Jedang	Review PT disa prima medika	Tidak ada
5	Prudensial syariah	Tarif	Masih proses

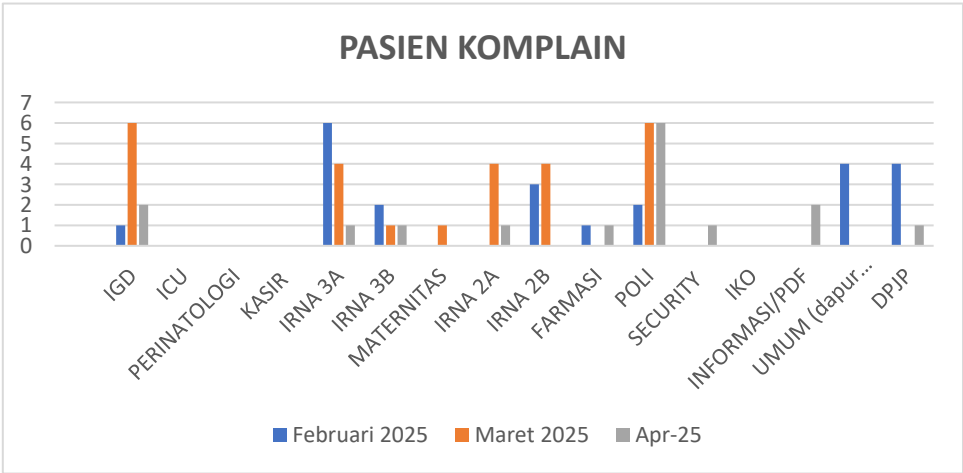
3.5.4 PIPP – MOD – MPP

A. Angka Kepuasan Pasien

Distribusi Laporan Komplain Pasien per unit bulan April 2025 di RS Prima Husada Sukorejo

PASIENT KOMPLAIN	Februari 2025	Maret 2025	April 2025
IGD	1	6	2
ICU	0	0	0
PERINATOLOGI	0	0	0
KASIR	0	0	0
IRNA 3A	6	4	1
IRNA 3B	2	1	1
MATERNITAS	0	1	0
IRNA 2A	0	4	1
IRNA 2B	3	4	0
FARMASI	1	0	1
POLI	2	6	6
SECURITY	0	0	1
IKO	0	0	0
INFORMASI/PDF	0	0	2
UMUM (dapur ipsrs)	4	0	0
DPJP	4	0	1
TOTAL	23	19	16

Grafik Laporan Kompalin Pasien per unit bulan April 2025 di RS Prima Husada Sukorejo



Analisis :

Jumlah pasien komplain selama Bulan April 2025 mengacu pada komplain pasien secara tatap muka langsung dan pesan melalui chatt seperti whatsapp..

- Komplain terbanyak pada bulan April 2025 yaitu dari Poli sebanyak 6 kasus yang disampaikan secara WA maupun tatap muka langsung terkait pelayanan dokter, antrian poli, dan komunikasi ppa sudah koordinasi dengan yang bersangkutan seperti kbid, iprs, dll

Rencana Tindak Lanjut:

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dan komunikasi kepada karu agar lebih disiplin terhadap perawat

3.5.5 Penjaminan

3.5.5.1 Tabel Data Klaim Pending

Bulan	Klaim Pending RJ	Jumlah Berkas Klaim RJ	Klaim Pending RI	Jumlah Berkas Klaim RI
Oktober' 24	0	11.634	13	1.623
November'24	0	10.933	4	1.628
Des'24	82	10.623	226	1.493
Januari	108	9.549	268	1.376
Februari		9.259		1.337
Maret				

kasus pending

1. reseleksi diagnosa utama, dimana secara anamnesa dan klinis menurut BPJS diagnosa sekunder lebih banyak dari pada diagnosa utama, sedangkan bila berdasarkan resource terbanyak diagnosa utama penyumbang resource terbanyak
2. hasil PA yang tidak terlampir, dimana hal tersebut merupakan pasien yang KRS di akhir bulan dan hasil PA membutuhkan waktu kurang lebih 14hr
3. kasus kehamilan dimana diagnos KPD bukan merupakan tanda-tanda inpartu sehingga diagnosa yang digunakan seharusnya bukan KPD
4. pengkodean tindakan flap bila kondisi flap hanya di bagian skin maka gunakan Radical excision of skin lesion, namun pada laporan operasi telah dijelaskan kedalaman, dan lokasi flap tersebut
5. kasus penerbitan surat kontrol bersamaan dengan penerbitan SEP (surat kontrol dan SEP dihari yang sama) dimana kasus tersebut adalah kasus pasien maju/mundur kontrol namun surat kontrol vklaim dihapus dan di buatkan baru sesuai dengan tgl pasien maju/mundur kontrol, seharusnya surat kontrol tidak dihapus namun dilakukan edit tgl kontrol sehingga tgl entri dan tgl terbit SEP akan berbeda
6. kasus KPD pada kehamilan bukan merupakan tanda-tanda persalinan

tindak lanjut

1. koordinasi dengan DPJP terkait reseleksi diagnosa berdasarkan resource terbanyak
2. koordinasi dengan kbid penunjang medik untuk hasil PA dapat dikirim melalui email asuransi center oleh dokter patologi sehingga tidak perlu menunggu dari laborat agar proses lebih cepat

3. koordinasi dengan DPJP terkait ketentuan penegakan diagnosa KPD berdasarkan kolegium
4. bila pasien maju dan mundur kontrol maka pasien di buatkan surat kontrol terlebih kemudian kontrol di lain hari sesuai dengan jadwal DPJP, bila terdapat case tertentu maka bagi pasien yang maju dan mundur kontrol maka dilakukan edit tgl kontrol pada vklaime bukan menghapus surat kontrol agar tidak terdeteksi penerbitan surat kontrol dihari yang sama dengan penerbitan SEP
5. koordinasi dengan DPJP terkait kasus KPD bahwa tanda-tanda persalinan dilihat dari pembukaan pasien

3.6 Komite dan Tim

3.6.1 Komite Mutu

3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

Berikut merupakan penjelasan mengenai capaian indikator mutu nasional RS. Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Tabel Indikator Mutu Nasional

No	Judul Indikator Mutu Nasional	Standar
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥85%
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit	≥80%
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	≥80%
6	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	≤5%
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	≥80%
8	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥80%
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	100%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥80%
13	Kepuasan Pasien	≥76.61%

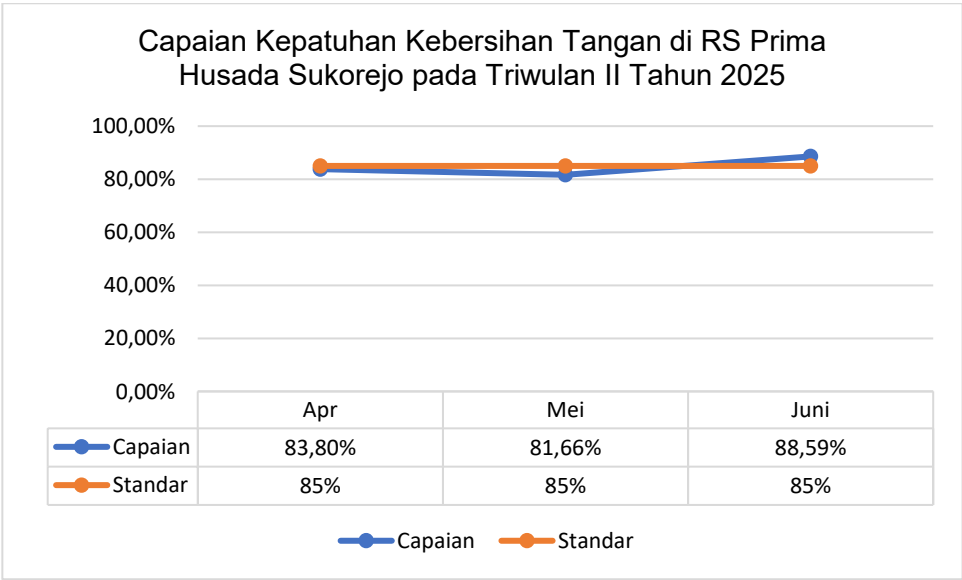
Capaian Indikator Mutu Nasional RSPH Sukorejo Triwulan II Tahun 2025

No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Ket
		April	Mei	Juni			
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	83,80%	81,66%	88,59%	≥85%	84,68%	PDSA
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	97,92%	98,07%	93,83%	100%	96,61%	PDSA
3	Kepatuhan identifikasi pasien	99,65%	99,73%	98,97%	100%	99,45%	PDSA
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit	96,77%	85,71%	100%	≥80%	94,16%	Dipertahankan
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	74,78%	70,14%	79,70%	≥80%	74,87%	PDSA
6	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	4,52%	1,37%	3,84%	≤5%	3,24%	Dipertahankan
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	71,19%	74,97%	77,96%	≥80%	74,71%	PDSA
8	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan

No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Ket
		April	Mei	Juni			
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	98,44%	98,84%	98,75%	≥80%	98,68%	Dipertahankan
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	97,44%	97,99%	98,75%	100%	98,06%	PDSA
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan
13	Kepuasan Pasien	97,87%	94,12%	96,30%	≥76.61%	96,10%	Dipertahankan

3.1.2 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan



Gambar 3.1. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan pada Triwulan II (April–Juni), diperoleh rata-rata sebesar 84,68%. Pada bulan April, tingkat kepatuhan mencapai 83,80%, kemudian menurun menjadi 81,66% di bulan Mei, dan meningkat signifikan menjadi 88,59% di bulan Juni. Meskipun nilai masih berada di atas 80%, capaian belum memenuhi standar ideal kepatuhan kebersihan tangan WHO yaitu ≥ 85%. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi kepatuhan terhadap kebersihan tangan masih menjadi tantangan, dan perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran serta pengawasan terhadap praktik kebersihan tangan di seluruh unit pelayanan.

Tabel 3.3 PDSA Capaian Kepatuhan kepatuhan kebersihan tangan petugas pada Triwulan II Tahun 2025

Problem	Kepatuhan kebersihan tangan pada Triwulan II 2025 hanya mencapai 84,68%, belum mencapai target ≥85%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.

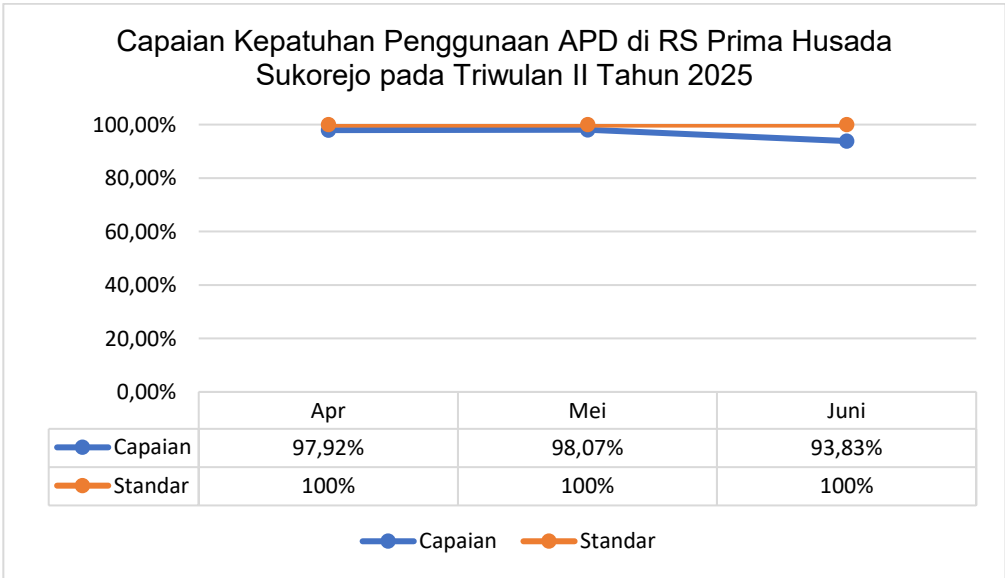
Plan	- Masalah yang ditemukan: - Tingkat kepatuhan kebersihan tangan tenaga kesehatan belum mencapai target $\geq 85\%$, dengan rata-rata kepatuhan saat ini sebesar 84,68%. - Masih ditemukan staf yang belum konsisten menerapkan praktik kebersihan tangan sesuai 5 Momen WHO. - Beberapa unit menunjukkan kepatuhan di bawah 85%, terutama saat jam sibuk atau malam hari. - Tujuan: - Menstabilkan dan mempertahankan kepatuhan $\geq 85\%$ secara konsisten selama Triwulan III (Juli–September 2025). - Membentuk perilaku otomatis kebersihan tangan di semua momen pelayanan - Rencana Aksi: - Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>). - Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. - Memberikan reward pada staff atau unit yang patuh dalam menjalankan kepatuhan kebersihan cuci tangan dan 5 momen
Do	- IPCN/IPCLN melakukan observasi acak langsung dan memberi umpan balik real time minimal 3 kali/minggu - Kepala unit melakukan briefing singkat tentang kepatuhan hand hygiene setiap awal shift. - Memberikan apresiasi mingguan kepada tenaga kesehatan/unit dengan kepatuhan tertinggi.
Study	- Hasil data Kepatuhan kebersihan tangan Triwulan II 2025 yaitu 84,68% - Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan unit pelayanan, unit dengan rerata kepatuhan $\geq 85\%$ adalah IRNA 3A sebesar 84,68%. - Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan profesi tertinggi adalah profesi dokter yaitu sebesar 90,43% walaupun belum mencapai standar - Staff tidak mempraktekkan Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan <i>5 Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO - Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan 5 momen didapatkan - Sebelum kontak dengan pasien sebesar 56,40% - Sebelum Tindakan aseptik sebesar 49,07% - Setelah terpapar cairan tubuh pasien sebesar 58,37% - Setelah kontak dengan pasien sebesar 64,88% - Setelah dari lingkungan pasien sebesar 54,53%
Action	- Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>). - Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. - Memberikan reward pada staff atau unit yang patuh dalam menjalankan kepatuhan kebersihan cuci tangan dan 5 momen

Tabel 3.4 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Wakt u
1	Audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan bedside coaching	Mengetahui secara langsung tingkat kepatuhan petugas terhadap 5 momen kebersihan tangan	Seluruh tenaga kesehatan di masing-masing unit	- Observasi langsung oleh IPCN/IPCLN - Feedback real-time di tempat - Dokumentas i hasil audit untuk evaluasi	IPCN/IPCLN	1 kali/m inggu/ unit (Juli–Sept 2025)

2	Melibatkan kepala unit sebagai role model dalam pelaksanaan kebersihan tangan	Meningkatkan komitmen dan keterlibatan pimpinan unit dalam budaya keselamatan pasien	Kepala ruang/unit pelayanan	- Kepala unit memberikan briefing awal shift tentang hand hygiene - Melakukan contoh perilaku langsung - Melaporkan kepatuhan tim tiap minggu ke manajemen	Kepala Unit, Jajaran Manajemen	Briefing harian & laporan mingguan
3	Memberikan reward kepada staf/unit yang memiliki tingkat kepatuhan terbaik	Memberikan motivasi dan memperkuat budaya positif terhadap kepatuhan kebersihan tangan	Seluruh tenaga kesehatan di masing-masing unit	- Penilaian berdasarkan hasil audit IPC - Pengumuman mingguan/bulanan untuk staf/unit terbaik - Pemberian piagam/apresiasi kecil sebagai motivasi	Tim PPI, Manajemen Mutu, SDM	Reward diberikan tiap akhir bulan (Juli–Des 2025)

2. Kepatuhan Penggunaan APD



Gambar 3.2. Capaian Kepatuhan Penggunaan APD di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan data capaian kepatuhan penggunaan APD diatas pada Triwulan II yakni mencapai 96,61% masih belum mencapai target 100% yang telah ditetapkan sebagai standar rumah sakit. Capaian tertinggi terjadi pada bulan Mei 98,07%. Capaian terendah terjadi pada bulan Juni 93,83%. Terdapat tren penurunan dari Bulan Mei ke Juni sebesar 4,24%

Tabel 3.5 PDSA Capaian Kepatuhan penggunaan APD pada Bulan Bulan Triwulan II Tahun 2025

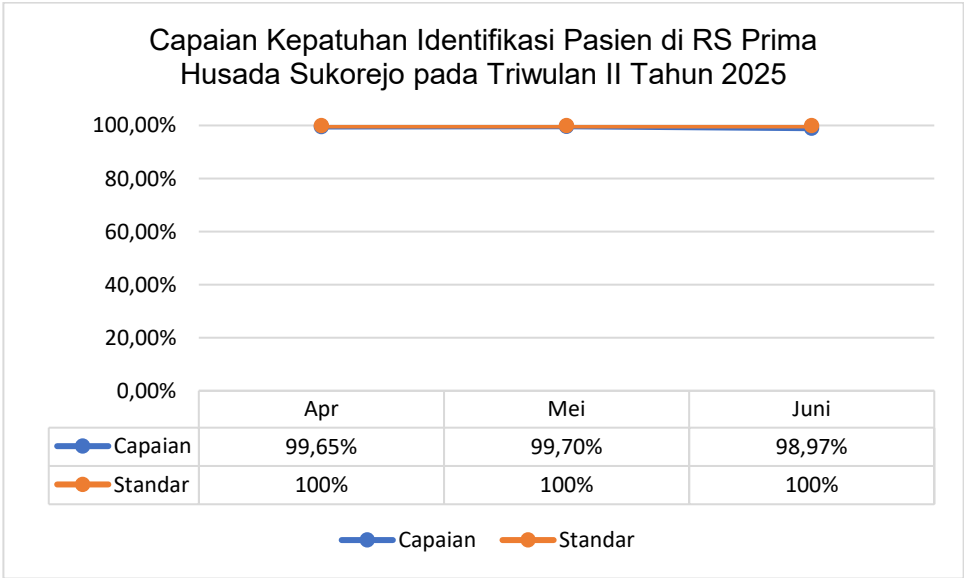
Problem	Persentase kepatuhan penggunaan APD tidak mencapai 100% yakni 96,61%. Meskipun pelatihan penggunaan APD telah dilaksanakan pada bulan Mei (untuk seluruh staf) dan diperkuat kembali dalam pelatihan PMKP bulan Juni (khusus CS dan Unit Umum), tingkat kepatuhan penggunaan APD masih belum mencapai target 100%.
Step	Melakukan penguatan edukasi berkelanjutan dan monitoring langsung kepada seluruh staf, khususnya kepada kelompok yang sudah mendapatkan pelatihan (CS dan Unit Umum), serta mempersiapkan strategi intervensi berikutnya untuk staf penunjang dan pelayanan melalui pelatihan terjadwal di bulan Juli 2025.
Plan	1. Masalah yang ditemukan: a. Kepatuhan tenaga kesehatan dalam penggunaan APD belum mencapai target 100%, dengan rata-rata kepatuhan 96,61%. b. Setelah dua kali pelatihan (umum dan khusus), masih ditemukan staf (terutama CS dan non-medis) yang belum konsisten dalam penggunaan APD sesuai prosedur. c. Rencana pelatihan berikutnya untuk staf penunjang dan pelayanan akan dilakukan pada bulan Juli 2025. 2. Tujuan: a. Meningkatkan dan mempertahankan kepatuhan penggunaan APD hingga mencapai 100%, khususnya pada unit yang telah mendapatkan pelatihan. b. Mempersiapkan intervensi lanjutan untuk unit yang akan mengikuti pelatihan di bulan Juli (penunjang dan pelayanan). 3. Rencana Aksi: a. Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN untuk deteksi dini ketidakpatuhan b. Melaksanakan audit dan supervisi khusus bagi staf CS dan Unit Umum sebagai tindak lanjut pelatihan. c. Menyusun dan membagikan SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan petugas non-medis di area kerja masing-masing. d. Meningkatkan peran Karu dan supervisor untuk memantau dan melaporkan ketidaksesuaian harian. e. Merancang pelatihan khusus penggunaan APD untuk staf penunjang dan pelayanan di bulan Juli, dengan pendekatan berbasis kasus.

	4. Evaluasi pelatihan menunjukkan perlunya penguatan praktik langsung dan coaching on the spot, bukan hanya teori.
Action	1. Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN untuk deteksi dini ketidakpatuhan 2. Melaksanakan audit dan supervisi khusus bagi staf CS dan Unit Umum sebagai tindak lanjut pelatihan. 3. Menyusun dan membagikan SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan petugas non-medis di area kerja masing-masing. 4. Meningkatkan peran Karu dan supervisor untuk memantau dan melaporkan ketidaksesuaian harian. 5. Merancang pelatihan khusus penggunaan APD untuk staf penunjang dan pelayanan di bulan Juli, dengan pendekatan berbasis kasus

Tabel 3.6 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN	Mendeteksi dini ketidakpatuhan dan memberikan pembinaan langsung	Seluruh unit pelayanan, penunjang, CS, dan Unit Umum	• Observasi langsung • Pembinaan di tempat (real-time coaching) • Dokumentasi dan tindak lanjut langsung	IPCN, IPCLN	Juli
2	Audit dan supervisi khusus bagi staf CS dan Unit Umum	Menindaklanjuti hasil pelatihan Juni dan memperkuat penerapan di lapangan	Petugas CS dan Unit Umum	• Audit mingguan • Supervisi oleh IPC dan Karu • Penguatan budaya kerja aman	IPCN, Karu, Supervisor CS, Koordinator Unit Umum	Juli
3	Penyusunan dan distribusi SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan Non-Medis	Menyediakan panduan praktis dan mudah dipahami di area kerja	Bidang Umum, (CS, Keamanan, Gudang, Sopir)	• SPO 1 lembar disesuaikan dengan risiko kerja • Poster visual dipasang di area kerja • Sosialisasi singkat per shift	Tim IPC, Tim PMKP, Kepala Unit	Juli
4	Peningkatan peran Karu dan supervisor dalam monitoring harian	Memastikan keberlanjutan kepatuhan di level unit	Seluruh unit pelayanan, penunjang, dan umum	• Format pelaporan ketidaksesuaian harian • Peningat briefing harian • Koordinasi antar shift	Kepala Ruang	Juli
5	Pelatihan khusus penggunaan APD untuk staf penunjang dan pelayanan berbasis kasus	Meningkatkan pemahaman dan keterampilan penggunaan APD berdasarkan situasi kerja	Petugas laboratorium, radiologi, farmasi, gizi, rawat inap, IGD	• Pelatihan berbasis studi kasus nyata • Diskusi interaktif • Simulasi langsung	Tim Diklat, IPCN/IPC LN, PMKP, Komite PPI	Juli

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.3. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II 2025 mencapai 99,45%. Dari 18698 petugas yang diidentifikasi, 18594 petugas patuh terhadap Identifikasi pasien sedangkan 104 petugas tidak patuh dalam identifikasi pasien. Capaian 99,45% menunjukkan komitmen tinggi tenaga kesehatan dalam menerapkan prinsip keselamatan pasien, khususnya identifikasi pasien dengan dua identitas sebelum tindakan. Namun, capaian ini belum mencapai target standar 100%, sehingga tetap perlu perhatian dan perbaikan. Capaian tertinggi yakni di Bulan Mei (99,70%) dan capaian terendah yakni di Bulan Juni (98,97%), Sebanyak 104 kejadian ketidakpatuhan tercatat. Meski terlihat kecil secara persentase, setiap insiden ketidakpatuhan dapat berdampak serius, termasuk risiko tertukarnya identitas pasien dan kesalahan pemberian tindakan atau obat

Tabel 3.7 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Triwulan II Tahun 2025 adalah belum mencapai target 100% yakni 99,45%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Masalah yang ditemukan : - Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 7 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A, IRNA 3B, Maternitas, ICU dan Ponak - Kepatuhan identifikasi pasien selama Triwulan II menunjukkan penurunan pada bulan Juni, meskipun telah dilakukan pelatihan PMKP untuk staf unit umum pada bulan tersebut. Nilai kepatuhan belum mencapai standar maksimal 100%. Akar Masalah yang teridentifikasi : - Kelalaian petugas dalam menjalankan prosedur identifikasi pasien dua langkah, yaitu tidak melakukan identifikasi secara visual maupun lisan sesuai SOP - Proses identifikasi hanya dilakukan secara lisan tanpa konfirmasi visual - Petugas non-medis (umum) mulai menunjukkan peningkatan kesadaran pasca pelatihan, namun belum diikuti oleh bagian pelayanan dan penunjang. - Sosialisasi hasil pelatihan belum menjangkau seluruh staf karena keterbatasan waktu dan rotasi. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien di seluruh unit menjadi 100% dalam satu bulan. Rencana Aksi :

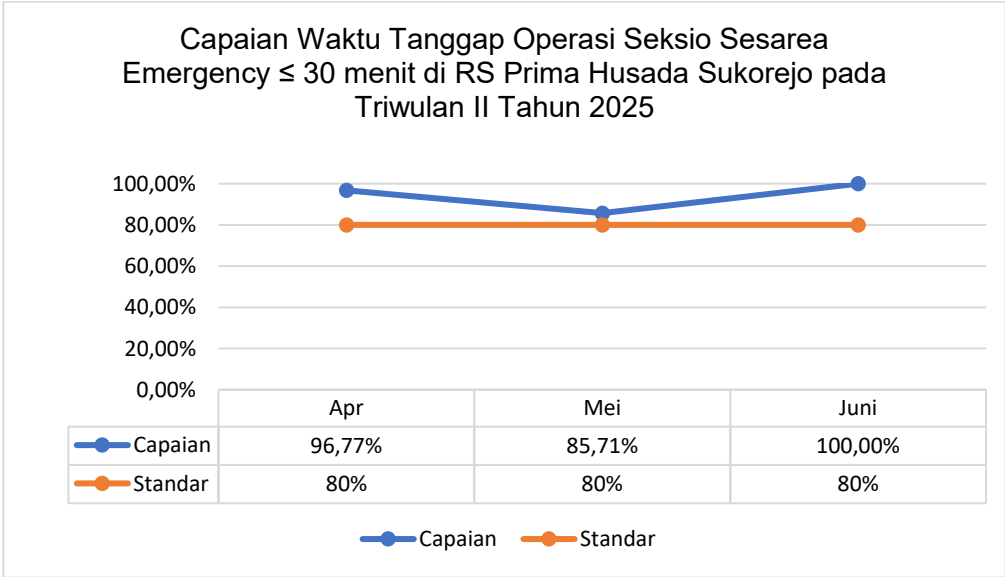
	a. Pelatihan dan Sosialisasi untuk bagian pelayanan dan penunjang akan dilaksanakan di Bulan Juli 2025 b. Melakukan observasi lapangan dan audit mendadak oleh IPCN dan Tim Mutu untuk memantau dampak pelatihan. c. Menyebarkan SPO singkat identifikasi pasien di area kerja unit umum. d. Mempersiapkan materi dan daftar peserta pelatihan PMKP untuk unit pelayanan dan penunjang yang akan dilaksanakan pada bulan Juli.
Do	1. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien 2. Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh 3. Sosialisasi dan Re-edukasi seluruh petugas tentang pentingnya identifikasi pasien dua langkah (visual dan lisan). 4. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Study	1. Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 7 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A, IRNA 3B, Maternitas, ICU dan Ponak 2. Capaian bulan April–Mei relatif tinggi dan stabil. 3. Capaian bulan Juni menurun menjadi 98,97% karena: a. Proses identifikasi hanya dilakukan secara lisan tanpa konfirmasi visual di Rawat Inap b. Perubahan kebiasaan memerlukan waktu untuk tertanam, terutama pada petugas baru dan unit dengan beban tinggi
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? 1. Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada Triwulan II tahun 2025 mencapai 99,45%, masih ditemukan beberapa unit yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Pelatihan dan Sosialisasi untuk bagian pelayanan dan penunjang akan dilaksanakan di Bulan Juli 2025 2. Melakukan observasi lapangan dan audit mendadak oleh Tim SKP untuk memantau dampak pelatihan. 3. Menyebarkan SPO singkat identifikasi pasien di area kerja unit umum. 4. Mempersiapkan materi dan daftar peserta pelatihan PMKP untuk unit pelayanan dan penunjang yang akan dilaksanakan pada bulan Juli.

Tabel 3.8 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pelatihan dan Sosialisasi untuk bagian pelayanan dan penunjang akan dilaksanakan di Bulan Juli 2025	Meningkatkan pemahaman dan implementasi identifikasi pasien yang benar sesuai standar akreditasi	Petugas pelayanan dan penunjang (perawat, dokter, laboratorium, radiologi, farmasi, dll)	Pelatihan tatap muka atau daring, disertai simulasi kasus dan roleplay	Tim PMKP, IPCN/IPCL N, Komite Keperawatan/Medis, SDM	Bulan Juli
2	Melakukan observasi lapangan dan audit mendadak oleh Tim SKP untuk memantau dampak pelatihan	Menilai dampak pelatihan terhadap praktik identifikasi pasien di lapangan	Unit pelayanan dan penunjang pasca pelatihan	Observasi langsung, audit checklist, wawancara petugas	Tim Mutu, Tim SKO Karu/	Bulan Juli, Agustus, September
3	Menyebarkan SPO singkat identifikasi pasien di area kerja unit umum.	Menyediakan panduan praktis yang mudah diakses dan dipahami oleh petugas	Petugas umum, pelayanan, dan penunjang	Cetak SPO ringkas dan pasang di titik strategis (nurse	SKP, Kepala Unit	Bulan Juli

				station, ruang tindakan, dll)		
4	Mempersiapkan materi dan daftar peserta pelatihan PMKP untuk unit pelayanan dan penunjang yang akan dilaksanakan pada bulan Juli	Menjamin kesiapan teknis pelatihan agar berjalan efektif dan tepat sasaran	Seluruh peserta dari unit pelayanan dan penunjang	Identifikasi peserta, pembuatan materi, jadwal, dan undangan	Tim PMKP, SDM, Kepala Unit masing-masing	Bulan Juli

4. Waktu Tunggu Operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 Menit

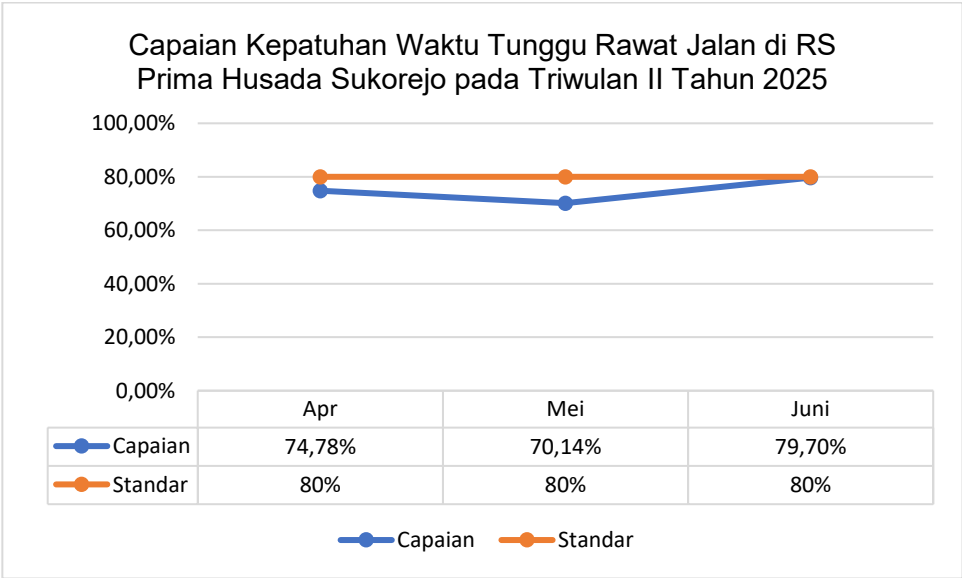


Gambar 3.5. Capaian Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergency kurang dari 30 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai standar yakni dengan rata-rata 94,16%. Pelayanan Ponek, IGD, Maternitas dan IKO dapat melakukan koordinasi dan tindakan kurang dari 30 menit, sehingga operasi dilakukan secara tepat.

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 Menit



Gambar 3.6. Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu tunggu rawat jalan di RS. Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai 74,87%. Nilai ini masih berada di bawah standar yang ditetapkan, yaitu ≥80%. Capaian terendah terjadi pada bulan Mei sebesar 70,14%, sementara capaian tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 79,70%. Meskipun terdapat perbaikan pada bulan Juni, hasil secara keseluruhan menunjukkan bahwa pelayanan rawat jalan belum sepenuhnya memenuhi target mutu, sehingga diperlukan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan dalam sistem dan proses pelayanan.

Tabel 3.9 PDSA Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit pada Triwulan II Tahun 2025

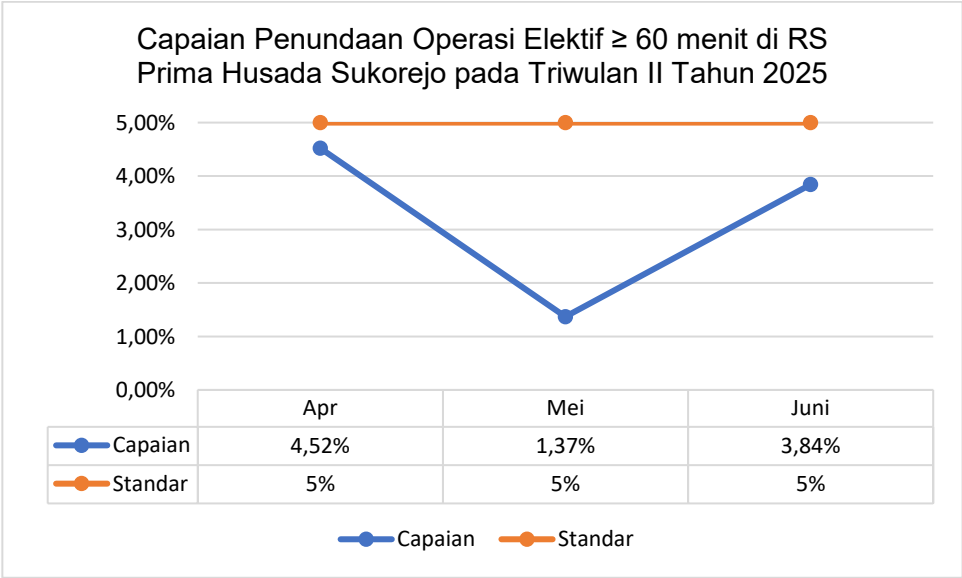
Problem	Rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 74,87% dan belum mencapai target 80%. Rata-rata waktu tunggu rawat jalan yakni 1 jam 09 menit jauh melebihi standar 60 menit.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu tunggu rawat jalan
Plan	Masalah yang ditemukan : Rata-rata waktu tunggu rawat jalan masih tinggi, yakni 1 jam 09 menit, dengan tingkat kepatuhan terhadap standar waktu tunggu ≤ 60 menit hanya sebesar 74,87%. Tujuan : Meningkatkan persentase kepatuhan standar waktu tunggu ≤ 60 menit menjadi minimal 80% pada triwulan berikutnya. Rencana Aksi: 1. Penjadwalan pasien berbasis slot waktu per jam agar kedatangan pasien lebih tersebar dan tidak terpusat di awal waktu praktik. 2. Monitoring ketepatan waktu kedatangan dokter secara harian dan pemberian teguran atau evaluasi bagi yang tidak disiplin. 3. Edukasi pasien melalui call center/pendaftaran online untuk datang sesuai waktu yang ditentukan.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Memonitor waktu kedatangan dokter dan jumlah pasien menumpuk di awal waktu praktik. 2. Melakukan edukasi kepada seluruh petugas front office dan pendaftaran tentang pentingnya efisiensi waktu tunggu.
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Berdasarkan rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan Bulan Triwulan II yakni 74,87% belum mencapai ≥ 80%. 2. Rata-rata waktu tunggu rawat jalan di poli yakni 1 jam 09 menit. Ini dikarenakan: a. Penumpukan Pasien di Awal Jam Poli b. Beberapa dokter spesialis tidak datang tepat waktu sesuai jadwal praktik yang telah ditentukan,
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu rawat jalan ≤60 menit yakni 74,87% belum mencapai ≥ 80%. Rata-rata keterlambatan terjadi dalam waktu 1 jam 09 menit. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Penjadwalan pasien berbasis slot waktu per jam agar kedatangan pasien lebih tersebar dan tidak terpusat di awal waktu praktik. 2. Monitoring ketepatan waktu kedatangan dokter secara harian dan pemberian teguran atau evaluasi bagi yang tidak disiplin. 3. Edukasi pasien melalui call center/pendaftaran online untuk datang sesuai waktu yang ditentukan.

Tabel 3.10 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Penjadwalan ulang atau pembagian tugas pasien di poli untuk DPJP	Meningkatkan pemerataan pasien per DPJP dan mengurangi waktu tunggu	Pasien rawat jalan di poli spesialis	- Review kuota pasien per DPJP - Penjadwalan slot waktu per dokter	Komite Medik, Koordinator Poli	Satu bulan
2	Monitoring kedatangan dokter dan evaluasi	Mengurangi waktu tunggu awal poli	Dokter Poli Rawat	Rapat koordinasi dengan Kabid	Kabid Pelayanan & Komite	Satu bulan

	disiplin waktu praktik		Jalan	Pelayanan & Komite Medik	Medik	
3	Edukasi pasien untuk datang sesuai jadwal melalui call center/pendaftaran online	Meningkatkan kedisiplinan waktu kedatangan pasien sesuai slot waktu	Pasien rawat jalan	- Petugas call center memberi reminder jam kedatangan saat reservasi - Edukasi saat konfirmasi jadwal online	Pendaftaran & CSO	Satu bulan

6. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit

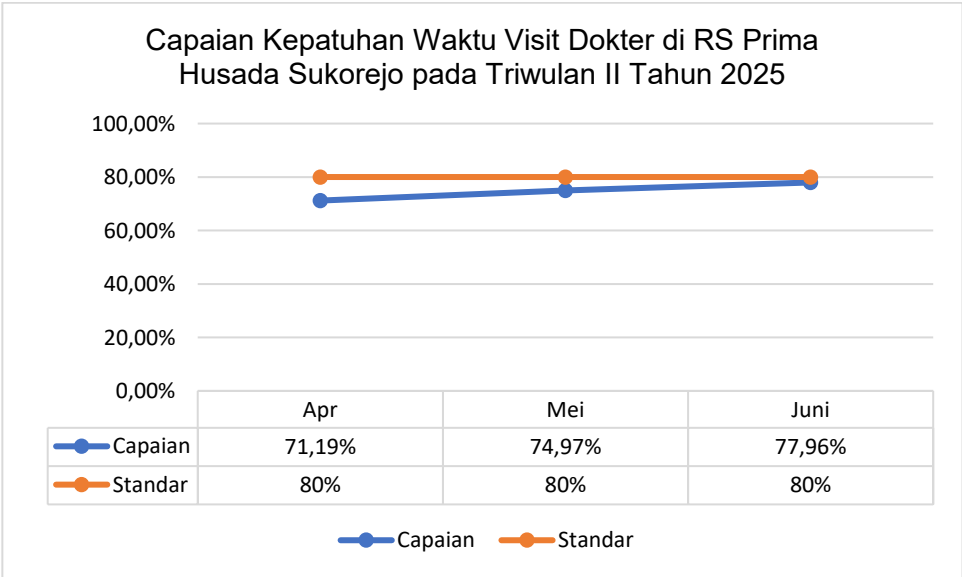


Gambar 3.7. Capaian Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025.

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian penundaan operasi elektif lebih dari 60 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II tahun 2025 yakni 3,24%. Capaian ini sudah mencapai standar <5%.

7. Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis ≤ jam 14.00 WIB



Gambar 3.8. Capaian Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00-14.00 WIB)

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap mencapai 74,71% dan masih dibawah standar $\geq 80\%$.. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah dokter spesialis yang belum melakukan visite pasien secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan jam kerja rumah sakit dan standar pelayanan medik. Hal ini berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan medis, pelaksanaan terapi, dan perencanaan pemulangan pasien.

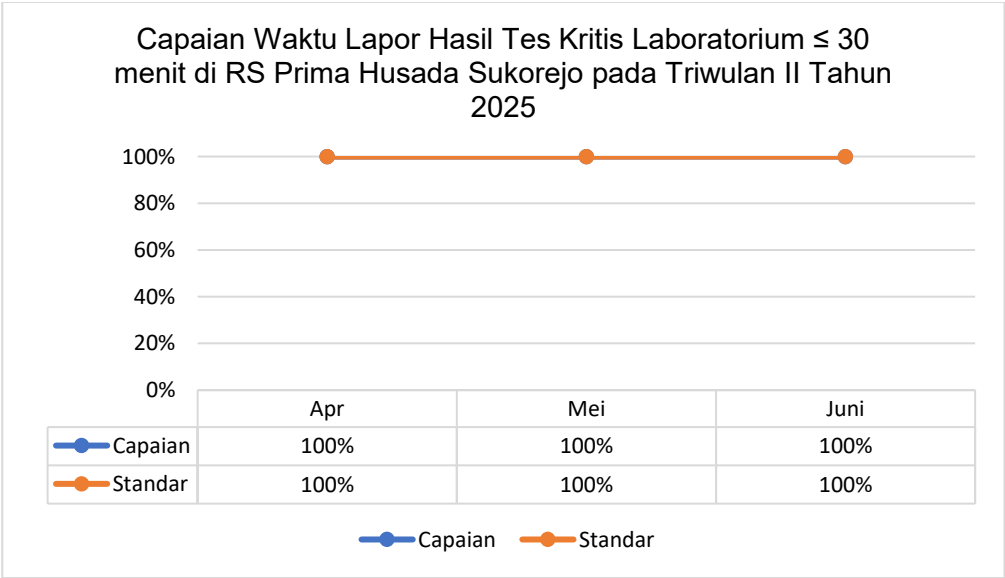
Tabel 3.11 PDSA Capaian Waktu Visite Dokter pada Triwulan II Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian waktu visite dokter pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 74,71% belum mencapai target $\geq 80\%$
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu visite dokter
Plan	Identifikasi Masalah : 1. Capaian kepatuhan waktu visit dokter spesialis masih di bawah standar (rata-rata Bulan Triwulan II yakni 74,71%. 2. Adanya dokter spesialis juga bekerja di tempat lain (RS lain, klinik, dll) pada jam 06.00–14.00 WIB. 3. Terdapat dokter yang cuti, tapi pengganti hanya oleh dokter jaga (bukan DPJP definitif. Tujuan : 1. Meningkatkan kepatuhan visit dokter menjadi minimal 80%. Rencana Aksi: 1. Audit harian oleh kepala ruangan 2. Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter 3. Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat). 4. Peningkatan koordinasi antar tim ICU dan DPJP serta prioritasasi pasien kritis
Do	Apa pengamatan yang dilakukan? 1. Pelaksanaan Visit Rutin Sesuai Jam yang Ditentukan (Pagi $\leq$ 14.00 WIB) 2. Waktu visit dicatat dalam rekam medis dan checklist visit. 3. DPJP mengisi form/checklist visit dengan tanda tangan/paraf sebagai bukti kunjungan.
Study	Apa yang anda pelajari? Apakah sesuai target capaian? Berdasarkan rata-rata capaian pada Bulan Bulan Triwulan II Tahun 2025 yakni 74,71%. Ini dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai $\geq 80\%$. Ini dikarenakan: 1. Rata-rata dokter visite yang lebih dari 14.00 WIB memiliki jadwal praktek di Rumah Sakit lain sehingga jadwal di RS Prima Husada Sukorejo lebih dari jam 14.00 WIB 2. Terdapat dokter yang cuti, tapi pengganti hanya oleh dokter jaga (bukan DPJP definitif. 3. Adanya Pasien yang berada di ICU sebagian besar mengalami kondisi terminal sehingga pasien tersebut berada dalam kondisi kritis dan memerlukan penanganan segera.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Berdasarkan rata-rata capaian pada Bulan Bulan Triwulan II Tahun 2025 yakni 74,71%. Ini dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai $\geq 80\%$. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Audit harian oleh kepala ruangan 2. Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter 3. Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat). 4. Peningkatan koordinasi antar tim ICU dan DPJP serta prioritasasi pasien kritis

Tabel 3.12 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Audit harian oleh kepala ruangan	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Dokter yang datang $\geq$ 14.00	Rapat koordinasi dengan komite medik	Kepala Ruang	Satu bulan
2	Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Seluruh dokter penanggung jawab pasien (DPJP) di rumah sakit	Rapat Koordinasi dengan SDM	Komite Medik & SDM	Satu bulan
3	Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat)	Menjamin kontinuitas pelayanan medis melalui penggantian DPJP saat cuti	Dokter Penanggung jawab Pasien	Menetapkan DPJP pengganti resmi saat dokter cuti, dan mendokumentasikannya secara formal.	Kepala Bidang Pelayanan	Satu bulan
4	Peningkatan koordinasi antar tim ICU dan DPJP serta prioritasasi pasien kritis	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter spesialis pada pasien rawat inap khususnya pasien kritis di ICU melalui sistem koordinasi dan prioritasasi yang lebih baik.	Dokter Penanggung jawab Pasien (DPJP) dan pasien kritis yang dirawat di ICU	- Menyusun daftar harian pasien kritis yang membutuhkan prioritas visite. - Melaksanakan koordinasi pagi antara perawat ICU dan DPJP sebelum jam visite	Kepala Ruang ICU, DPJP, Komite Medi	Satu bulan

8. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium $\leq$ 60 menit

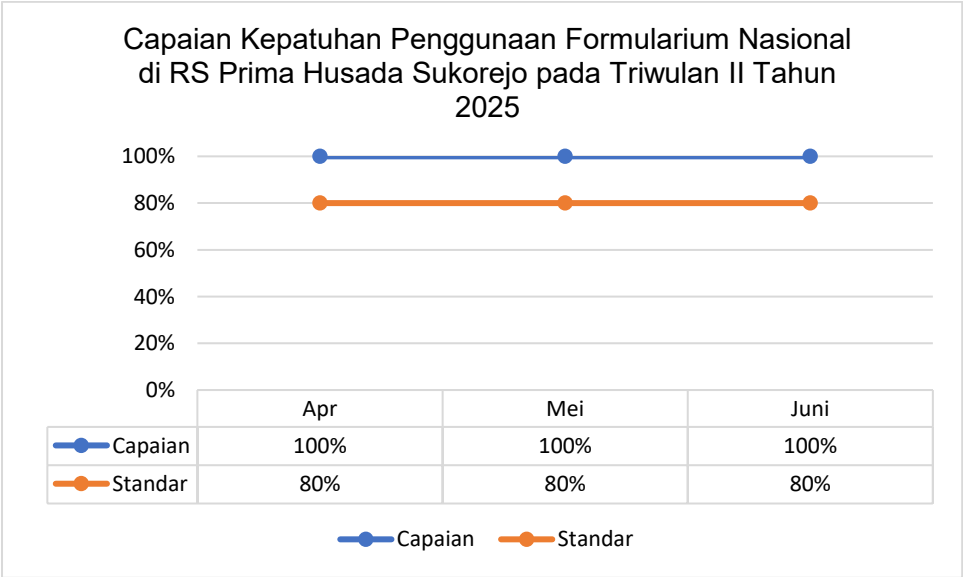


Gambar 3.9. Capaian Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian waktu lapor hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit pada Bulan Triwulan II Tahun 2025 yakni 100% sesuai standar. Dari hasil kritis laboratorium di observasi. Unit Laboratorium telah menyampaikan hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit.

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

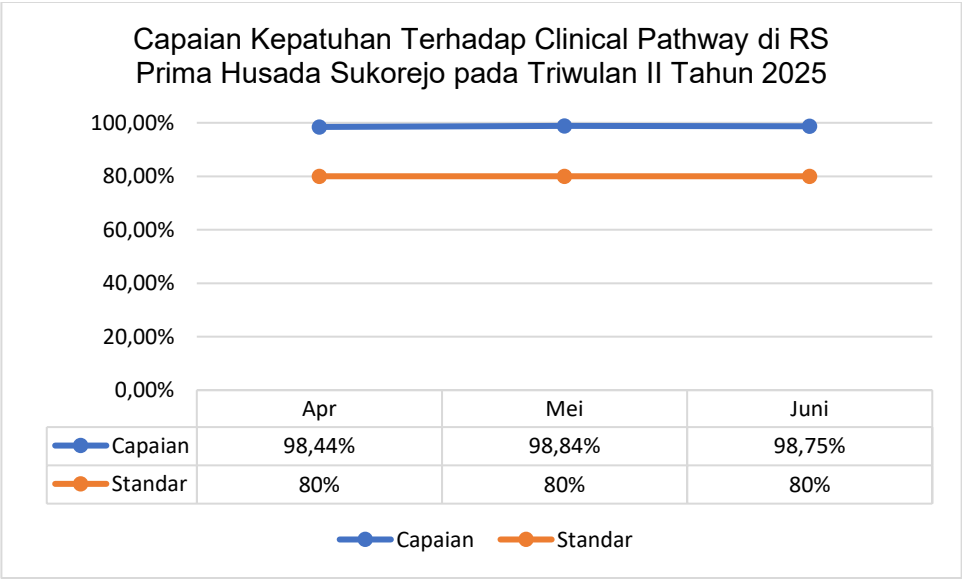


Gambar 3.10. Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional di RS Prima Husada Sukorejo Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai standar yakni 100%. Dari formularium nasional yang diobservasi, Seluruh resep yang diberikan oleh Unit Farmasi menggunakan obat yang termasuk dalam Formularium Nasional (Fornas). Capaian 100% menunjukkan bahwa tidak ada peresepan obat di luar Fornas, sehingga risiko penggunaan obat tidak sesuai standar dapat ditekan.

10. Kepatuhan terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

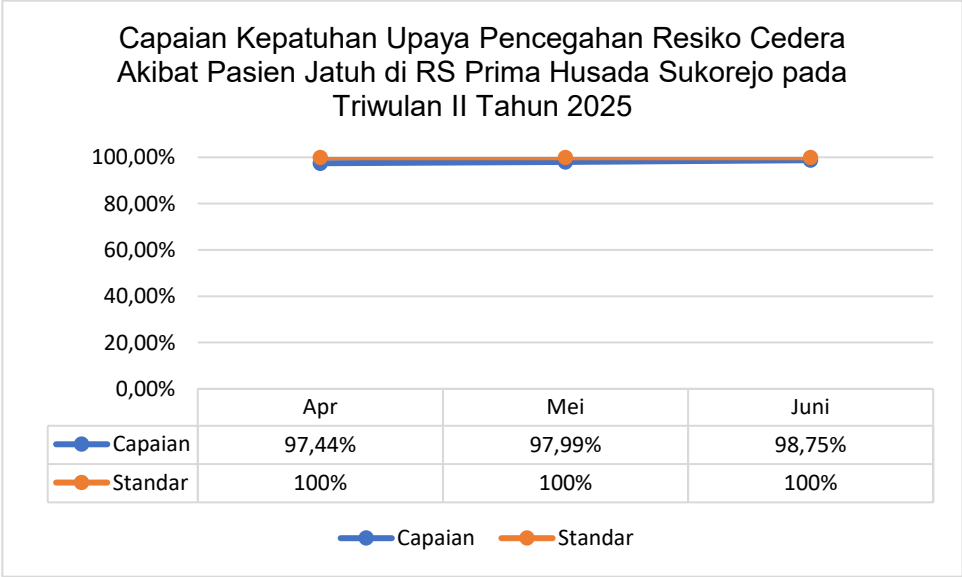


Gambar 3.11. Capaian Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai standar 80%. Capaian kepatuhan terhadap *clinical pathway* Bulan Triwulan II Tahun 2025 di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 98,68%. Angka tersebut sudah mencapai target 80%. Adapun Kriteria yang diukur adalah LOS (*Length of Stay*), Asesmen Klinis, Pemeriksaan Penunjang, Obat yang diberikan kepada pasien, Asesmen Keperawatan, Asesmen gizi dan Asesmen Farmasi. Clinical Pathway Bulan Triwulan II didapatkan dari diagnosa PEB, Partus Normal, Seksio Cesarea, Curretage General & Curretage Regional.

11.Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh



Gambar 3.12. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada Triwulan II tahun 2025 adalah 98,06%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Terdapat tren peningkatan capaian dari bulan ke bulan, yaitu dari 97,44% (April) menjadi 98,75% (Juni). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kepatuhan secara bertahap selama triwulan berjalan.

Tabel 3.13 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2025

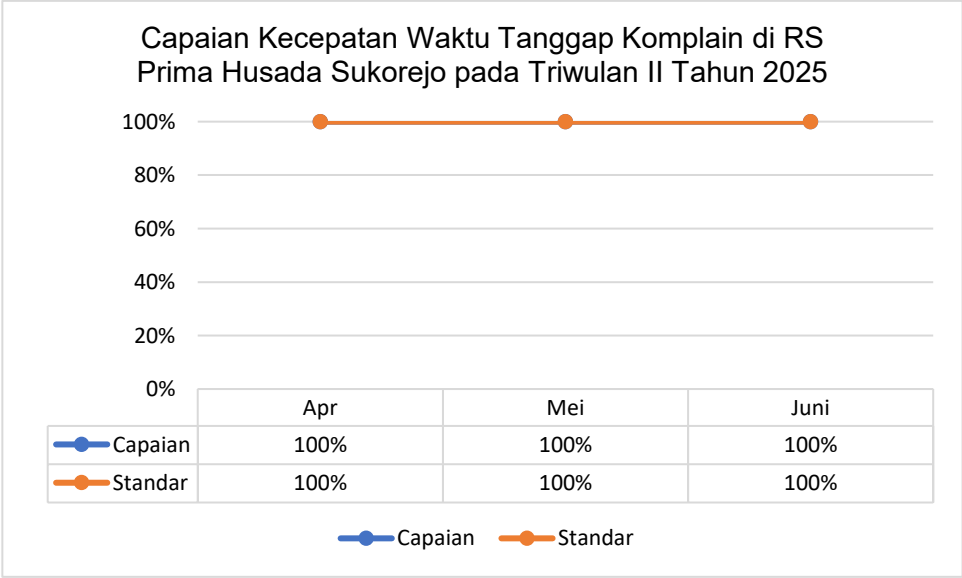
Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 98,06%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan resiko jatuh
Plan	Masalah : 1. Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 98,06% 2. Meskipun telah dilakukan pelatihan di unit umum pada bulan Juni 2025, belum seluruh petugas di unit pelayanan dan penunjang terpapar materi. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh hingga mencapai standar minimal 100%. Rencana Aksi : 1. Memberikan pelatihan PMKP yang mencakup risiko jatuh ke seluruh petugas pelayanan dan penunjang di Bulan Juli 2025 2. Menyusun ulang SPO singkat dan form skrining risiko jatuh yang mudah dipahami. 3. Memasang reminder visual tentang risiko jatuh di setiap tempat tidur pasien. 4. Menyiapkan label risiko jatuh (gelang dan tanda di tempat tidur) serta mengevaluasi kelengkapan dokumentasi.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning awal resiko jatuh pasien 2. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning ulang pasien indikasi resiko jatuh di rawat inap 3. Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 98,06% 2. Asuhan skrining risiko jatuh tidak dilakukan secara menyeluruh, seperti tidak adanya pemasangan tanda risiko jatuh pada alat bantu mobilisasi pasien (misalnya kursi roda). 3. Hand rail di tempat tidur pasien terpasang disebelah sisi, yang seharusnya menjadi alat bantu penting untuk mencegah pasien terjatuh dari tempat tidur. 4. Tidak terempelnya stiker penanda risiko jatuh di tempat tidur pasien 5. Kurangnya edukasi kepada pasien yang memiliki risiko jatuh, yang merupakan langkah penting dalam melibatkan pasien dalam menjaga keselamatan dirinya sendiri
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Triwulan II Tahun 2025 belum sesuai standar yakni 98,06% Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Memberikan pelatihan PMKP yang mencakup risiko jatuh ke seluruh petugas pelayanan dan penunjang di Bulan Juli 2025 2. Menyusun ulang SPO singkat dan form skrining risiko jatuh yang mudah dipahami. 3. Memasang reminder visual tentang risiko jatuh di setiap tempat tidur pasien. 4. Menyiapkan label risiko jatuh (gelang dan tanda di tempat tidur) serta mengevaluasi kelengkapan dokumentasi.

Tabel 3.14 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Memberikan pelatihan PMKP yang mencakup risiko jatuh ke	Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan staf dalam pencegahan	Seluruh petugas pelayanan dan penunjang	Pelatihan klasikal dan simulasi lapangan terkait skrining dan	Komite PMKP, PJ SKP, SDM & Kepala	Juli

	seluruh petugas pelayanan dan penunjang	risiko jatuh	(perawat, dokter, lab, radiologi, farmasi, rehab medik, dll)	tindakan pencegahan risiko jatuh	Ruang	
2	Menyusun ulang SPO singkat dan form skrining risiko jatuh yang mudah dipahami	Menyederhanakan panduan agar mudah diikuti dan konsisten diterapkan di semua unit	Seluruh petugas yang mengisi skrining risiko jatuh	Meninjau SPO lama dan menyusun ulang SPO singkat berbasis praktik terbaik dan hasil audit	Komite PMKP, PJ SKP, SDM & Kepala Ruang	Juli
3	Memasang reminder visual tentang risiko jatuh di setiap tempat tidur pasien	Meningkatkan kesadaran petugas dan keluarga pasien tentang pencegahan risiko jatuh	Seluruh pasien rawat inap dan petugas di ruang perawatan	Pemasangan stiker/peringatan visual pada dinding/tempat tidur pasien dengan risiko jatuh	Kepala Unit	Juli
4	Menyiapkan label risiko jatuh (gelang dan tanda di tempat tidur) serta mengevaluasi kelengkapan dokumentasi	Meningkatkan identifikasi pasien risiko tinggi dan memastikan dokumentasi lengkap	Pasien dengan risiko jatuh dan petugas yang melakukan penilaian risiko	Distribusi label risiko jatuh & audit checklist kelengkapan form risiko jatuh	Kepala Unit	Juli

12. Kepatuhan Waktu Tanggap Komplain

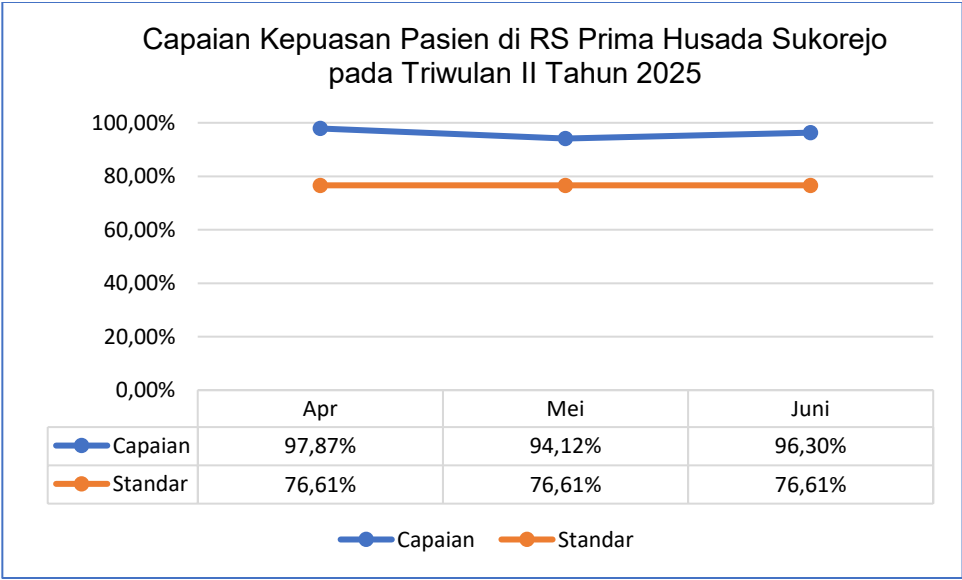


Gambar 3.13. Capaian Kecepatan Waktu Tanggap Komplain di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kecepatan waktu tanggap complain pada Triwulan II Tahun 2025 yakni 100% dan sesuai standar. Unit MOD-PIPP telah menindaklanjuti complain dari pasien.

13. Kepuasan Pasien



Gambar 3.14. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan II Tahun 2025 capaian Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 96,10%. Angka tersebut sudah mencapai target 76,61%. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada bulan Triwulan II, capaian tetap berada jauh di atas standar, yang menunjukkan kualitas pelayanan tetap terjaga.

3.1.3 Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit

Tabel 3.15 Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit pada Bulan Bulan Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
			April	Mei	Juni			
1	Indikator Sasaran Keselamatan Pasien	1. Mengidentifikasi pasien dengan benar: a. Kepatuhan Identifikasi pasien	99,65 %	99,70 %	98,97 %	100%	99,68%	PDSA
		2. Meningkatkan komunikasi yang efektif: a. Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	97,40 %	97,67 %	97,56 %	100%	97,54%	PDSA
		3. Meningkatkan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai (<i>High Alert Medications</i>): a. Kepatuhan pemusnahan	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada Obat Sisa Anestesi

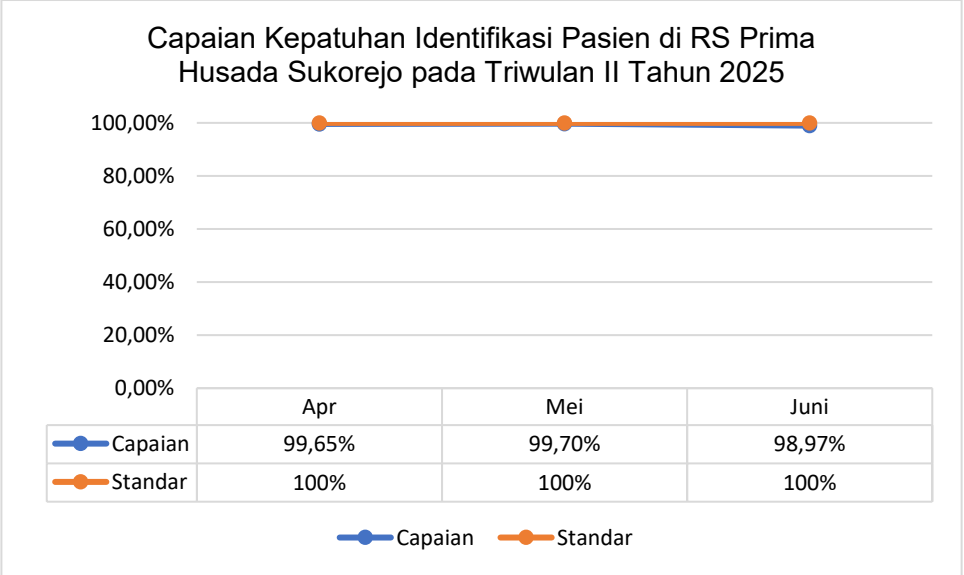
No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
			April	Mei	Juni			
		obat sisa anestesi						
		4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar: a. Kepatuhan Pelaksanaan Surgical Safety Checklist	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
		b. Kejadian tidak dilakukannya penandaan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
		5. Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan: a. Kepatuhan Kebersihan Tangan	83,80 %	81,66 %	88,59 %	100%	84,68%	PDSA
		6. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh: a. Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	97,92 %	97,99 %	98,75 %	100%	98,06%	PDSA
2	Pelayanan Klinis Prioritas	1. Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
		2. Kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
		3. Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan				≥ 90%		Belum diisi

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
			April	Mei	Juni			
		dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.						
		4. Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium				≥ 95%		Belum diisi
		5. Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				≤5%		Dipertahankan
		6. Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		Belum diisi
		7. Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%				≥ 70%		Belum diisi
		8. Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		Belum diisi
		9. Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		Belum diisi
		10. Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				≥ 75 %		Belum diisi
3	Renstra RS	1. Kepuasan pasien	97,87 %	94,12 %	96,30 %	≥ 76,61	96,61%	Dipertahankan

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
			April	Mei	Juni			
						%		
4	Perbaikan Sistem	1. Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
		2. Angka Kelengkapan laporan Operasi yang dilakukan di IKO	100%	99,79 %	100%	100%	99,93%	PDSA
		3. Kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Manajemen Resiko	1. Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
		2. Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

3.1.4 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

- Analisis Capaian Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
 - Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.15. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II 2025 mencapai 99,45%. Dari 18698 petugas yang diidentifikasi, 18594 petugas patuh terhadap Identifikasi pasien sedangkan 104 petugas tidak patuh dalam identifikasi pasien. Capaian 99,45% menunjukkan komitmen tinggi tenaga kesehatan dalam menerapkan prinsip keselamatan pasien, khususnya identifikasi pasien dengan dua identitas

sebelum tindakan. Namun, capaian ini belum mencapai target standar 100%, sehingga tetap perlu perhatian dan perbaikan. Capaian tertinggi yakni di Bulan Mei (99,70%) dan capaian terendah yakni di Bulan Juni (98,97%), Sebanyak 104 kejadian ketidakpatuhan tercatat. Meski terlihat kecil secara persentase, setiap insiden ketidakpatuhan dapat berdampak serius, termasuk risiko tertukarnya identitas pasien dan kesalahan pemberian tindakan atau obat

Tabel 3.16 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

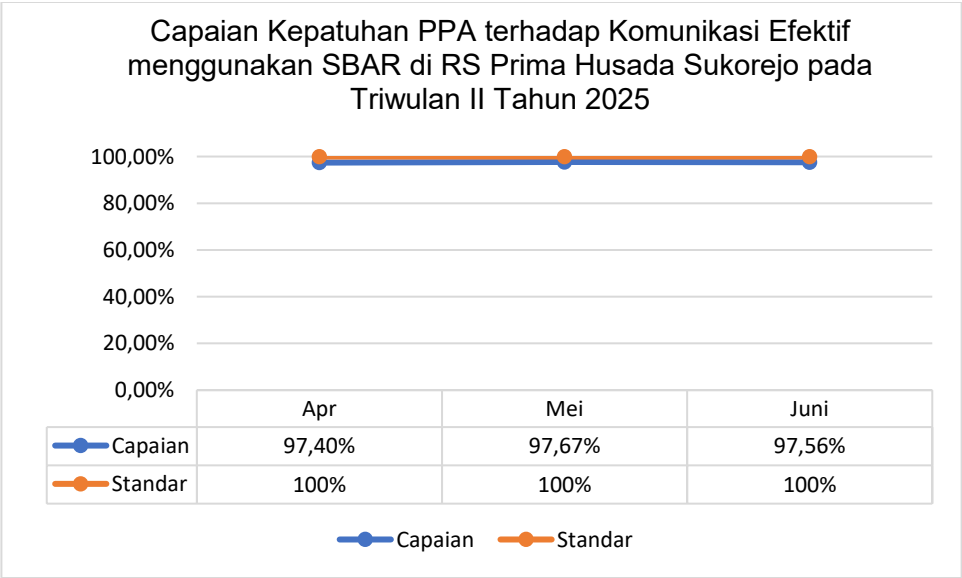
Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Triwulan II Tahun 2025 adalah belum mencapai target 100% yakni 99,45%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Masalah yang ditemukan : 1. Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 7 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A, IRNA 3B, Maternitas, ICU dan Ponek 2. Kepatuhan identifikasi pasien selama Triwulan II menunjukkan penurunan pada bulan Juni, meskipun telah dilakukan pelatihan PMKP untuk staf unit umum pada bulan tersebut. Nilai kepatuhan belum mencapai standar maksimal 100%. Akar Masalah yang teridentifikasi : 1. Kelalaian petugas dalam menjalankan prosedur identifikasi pasien dua langkah, yaitu tidak melakukan identifikasi secara visual maupun lisan sesuai SOP 2. Proses identifikasi hanya dilakukan secara lisan tanpa konfirmasi visual 3. Petugas non-medis (umum) mulai menunjukkan peningkatan kesadaran pasca pelatihan, namun belum diikuti oleh bagian pelayanan dan penunjang. 4. Sosialisasi hasil pelatihan belum menjangkau seluruh staf karena keterbatasan waktu dan rotasi. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien di seluruh unit menjadi 100% dalam satu bulan. Rencana Aksi : a. Pelatihan dan Sosialisasi untuk bagian pelayanan dan penunjang akan dilaksanakan di Bulan Juli 2025 b. Melakukan observasi lapangan dan audit mendadak oleh IPCN dan Tim Mutu untuk memantau dampak pelatihan. c. Menyebarkan SPO singkat identifikasi pasien di area kerja unit umum. d. Mempersiapkan materi dan daftar peserta pelatihan PMKP untuk unit pelayanan dan penunjang yang akan dilaksanakan pada bulan Juli.
Do	1. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien 2. Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh 3. Sosialisasi dan Re-edukasi seluruh petugas tentang pentingnya identifikasi pasien dua langkah (visual dan lisan). 4. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Study	1. Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 7 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A, IRNA 3B, Maternitas, ICU dan Ponek 2. Capaian bulan April–Mei relatif tinggi dan stabil. 3. Capaian bulan Juni menurun menjadi 98,97% karena: a. Proses identifikasi hanya dilakukan secara lisan tanpa konfirmasi visual di Rawat Inap b. Perubahan kebiasaan memerlukan waktu untuk tertanam, terutama pada petugas baru dan unit dengan beban tinggi
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? 1. Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada Triwulan II tahun 2025 mencapai 99,45%, masih ditemukan beberapa unit yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Pelatihan dan Sosialisasi untuk bagian pelayanan dan penunjang akan dilaksanakan di Bulan Juli 2025 2. Melakukan observasi lapangan dan audit mendadak oleh Tim SKP untuk memantau dampak pelatihan. 3. Menyebarkan SPO singkat identifikasi pasien di area kerja unit umum.

	4. Mempersiapkan materi dan daftar peserta pelatihan PMKP untuk unit pelayanan dan penunjang yang akan dilaksanakan pada bulan Juli.
--	--

Tabel 3.17 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pelatihan dan Sosialisasi untuk bagian pelayanan dan penunjang akan dilaksanakan di Bulan Juli 2025	Meningkatkan pemahaman dan implementasi identifikasi pasien yang benar sesuai standar akreditasi	Petugas pelayanan dan penunjang (perawat, dokter, laboratorium, radiologi, farmasi, dll)	Pelatihan tatap muka atau daring, disertai simulasi kasus dan roleplay	Tim PMKP, IPCN/IPCL N, Komite Keperawatan/Medis, SDM	Bulan Juli
2	Melakukan observasi lapangan dan audit mendadak oleh Tim SKP untuk memantau dampak pelatihan	Menilai dampak pelatihan terhadap praktik identifikasi pasien di lapangan	Unit pelayanan dan penunjang pasca pelatihan	Observasi langsung, audit checklist, wawancara petugas	Tim Mutu, Tim SKO Karu/	Bulan Juli, Agustus, September
3	Menyebarkan SPO singkat identifikasi pasien di area kerja unit umum.	Menyediakan panduan praktis yang mudah diakses dan dipahami oleh petugas	Petugas umum, pelayanan, dan penunjang	Cetak SPO ringkas dan pasang di titik strategis (nurse station, ruang tindakan, dll)	SKP, Kepala Unit	Bulan Juli
4	Mempersiapkan materi dan daftar peserta pelatihan PMKP untuk unit pelayanan dan penunjang yang akan dilaksanakan pada bulan Juli	Menjamin kesiapan teknis pelatihan agar berjalan efektif dan tepat sasaran	Seluruh peserta dari unit pelayanan dan penunjang	Identifikasi peserta, pembuatan materi, jadwal, dan undangan	Tim PMKP, SDM, Kepala Unit masing-masing	Bulan Juli

b. Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR



Gambar 3.16. Capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Bulan Triwulan II Tahun 2025 yakni 97,54%. meskipun angkanya tergolong tinggi capainnya masih dibawah standar 100% Ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kasus atau tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya menerapkan komunikasi efektif dengan metode SBAR.

Tabel 3.18 PDSA Capaian Kepatuhan Petugas terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

Problem	Rata-Rata Persentase Angka Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR mencapai 97,54%.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
Plan	1. Identifikasi Masalah: Tingkat kepatuhan petugas pelaksana asuhan (PPA) terhadap penggunaan komunikasi efektif dengan format SBAR belum mencapai standar 100%. Hasil monitoring menunjukkan adanya variasi dalam penerapan, terutama pada bagian <i>Assessment</i> dan <i>Recommendation</i>, yang sering tidak lengkap atau tidak sesuai format. 2. Tujuan: Meningkatkan kepatuhan petugas terhadap penggunaan komunikasi SBAR hingga mencapai 100% pada seluruh unit pelayanan, khususnya pada proses serah terima pasien dan komunikasi antar-profesi 3. Rencana Aksi: a. Melakukan peningkatan supervisi pelaksanaan komunikasi SBAR secara rutin oleh Tim PKRS dan Tim Mutu. b. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala oleh Kepala Unit Rawat Inap untuk menilai kelengkapan dan konsistensi penggunaan SBAR dalam dokumentasi serta praktik komunikasi. c. Menyediakan contoh-contoh SBAR yang baik di link sebagai panduan praktis. d. Feedback langsung kepada staf yang tidak mengisi dengan lengkap

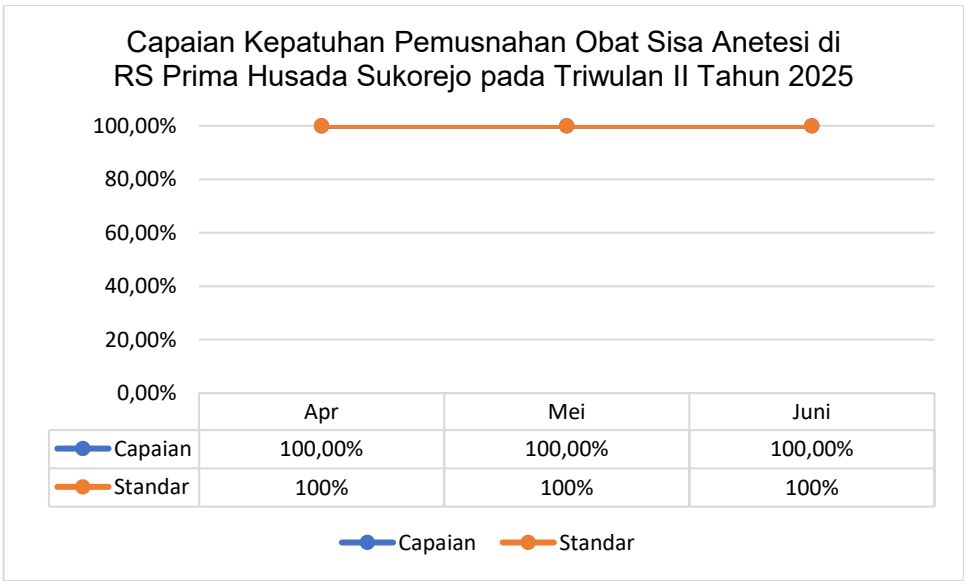
	1. Rata-rata capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada bulan Triwulan II Tahun 2025 yakni 97,54%. 2. Adapun temuan bagian yang tidak lengkap yakni : a. Bagian Appearance b. Bagian Rekomendasi c. Bagian Tanggal d. Bagian TTD Pemberi e. Bagian TTD penerima pesan 3. Ini disebabkan karena: a. SBAR disiapkan setelah tindakan dilakukan bukan sebelum komunikasi klinis b. Petugas tidak memahami pentingnya informasi klinis pasien secara menyeluruh c. Kelalaian teknis
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Bulan Triwulan II Tahun 2025 yakni 97,54%. meskipun angkanya tergolong tinggi capainnya masih dibawah standar 100% Ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kasus atau tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya menerapkan komunikasi efektif dengan metode SBAR. Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Melakukan peningkatan supervisi pelaksanaan komunikasi SBAR secara rutin oleh Tim PKRS dan Tim Mutu. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala oleh Kepala Unit Rawat Inap untuk menilai kelengkapan dan konsistensi penggunaan SBAR dalam dokumentasi serta praktik komunikasi. 3. Menyediakan contoh-contoh SBAR yang baik di link sebagai panduan praktis. 4. Feedback langsung kepada staf yang tidak mengisi dengan lengkap

Tabel 3.19 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
1	Supervisi Pelaksanaan Komunikasi Efektif Menggunakan SBAR	Meningkatkan kepatuhan petugas pelaksana asuhan (PPA) dalam menggunakan format komunikasi efektif SBAR secara konsisten dan lengkap, guna menunjang keselamatan pasien dan kualitas pelayanan.	Seluruh PPA (perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain) di unit rawat inap dan unit pelayanan lainnya.	Supervisi, pemberian umpan balik langsung dan edukasi singkat kepada petugas saat ditemukan ketidaksesuaian	PKRS, Tim SKP, dan Tim Mutu	1 minggu
2	Monitoring dan evaluasi berkala oleh Kepala Unit Rawat Inap untuk menilai kelengkapan dan konsistensi penggunaan SBAR dalam	Meningkatkan kepatuhan petugas pelaksana asuhan (PPA) dalam menggunakan format komunikasi efektif SBAR secara	Seluruh PPA (perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain) di unit rawat inap dan unit pelayanan lainnya	Monitoring dan evaluasi petugas saat ditemukan ketidaksesuaian	Kepala Ruangan	1 bulan

	dokumentasi serta praktik komunikasi	konsisten dan lengkap, guna menunjang keselamatan pasien dan kualitas pelayanan.				
3	Penyediaan contoh-contoh SBAR yang baik di link sebagai panduan praktis	Meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas pelaksana asuhan (PPA) dalam menggunakan format komunikasi SBAR melalui akses mudah terhadap contoh-contoh praktik baik (best practice) yang tersedia secara digital.	Seluruh PPA (perawat, bidan, tenaga medis) di seluruh unit pelayanan, khususnya yang melakukan serah terima pasien, komunikasi antar shift, dan komunikasi antar profesi.	Menyusun beberapa contoh SBAR yang baik dan lengkap yakni dalam bentuk dokumentasi tertulis	Tim SKP, PKRS	1 bulan
4	Feedback langsung kepada staf yang tidak mengisi dengan lengkap	Memberikan pembinaan dan perbaikan langsung kepada tenaga kesehatan yang tidak mengisi form SBAR secara lengkap	Seluruh tenaga kesehatan (perawat, bidan, atau tenaga lainnya) yang form SBAR tidak lengkap dan pengisian SBAR tetapi tidak terdokumentasi dengan benar	1. Menunjukkan bagian yang tidak terisi dan jelaskan dampaknya terhadap keselamatan pasien. 2. Berikan contoh pengisian yang benar dan arahkan untuk perbaikan ke depan	Tim SKP, PKRS	1 bulan

c. Kepatuhan Pemusnahan Obat Sisa Anestesi

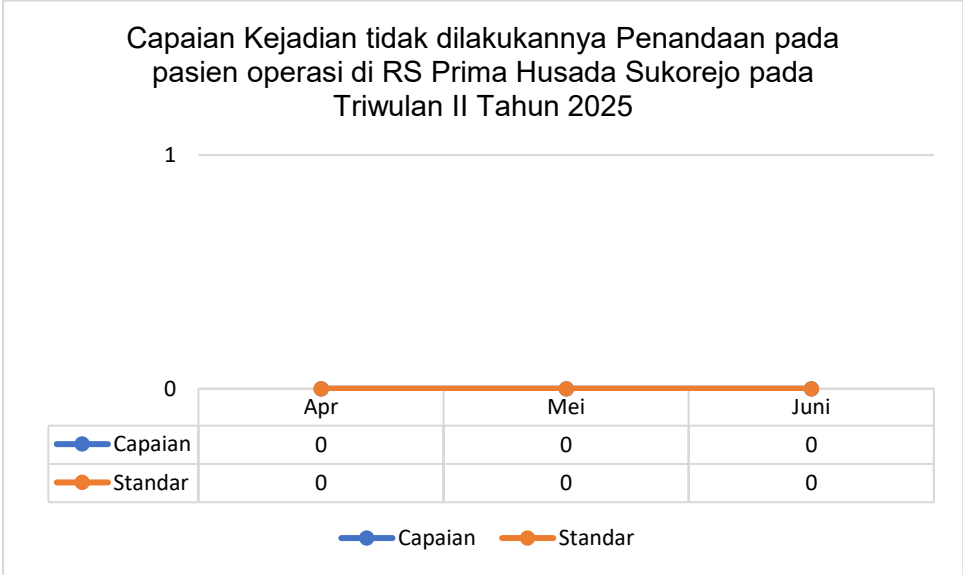


Gambar 3.17. Capaian Kepatuhan Pemusnahan Obat Sisa Anestesi di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II Tahun 2025 mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan dan pemusnahan obat sisa anestesi di rumah sakit sudah berjalan sesuai prosedur, dan kontrol terhadap risiko penyalahgunaan obat-obatan anestesi sudah diterapkan secara maksimal.

d. Kepatuhan Pelaksanaan Surgical Safety Checklist

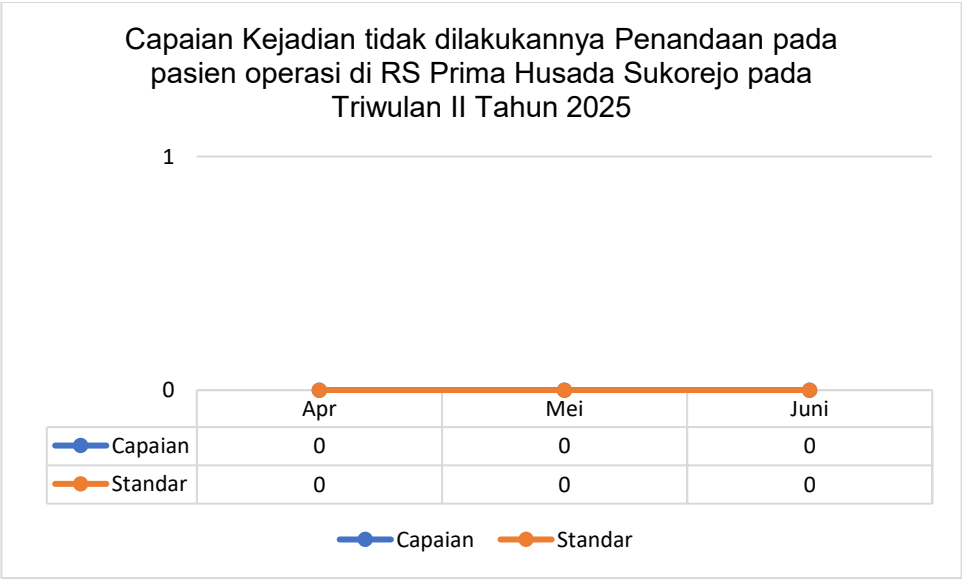


Gambar 3.18. Capaian Kepatuhan Pelaksanaan Surgical Sfety Checklist di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, kepatuhan pelaksanaan Surgical Safety Checklist (SSC) mencapai angka 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur keselamatan pasien pra, saat, dan pasca operasi telah dijalankan dengan sangat baik dan sesuai standar WHO.

e. Kejadian Tidak Dilakukannya Penandaan pada Pasien Operasi

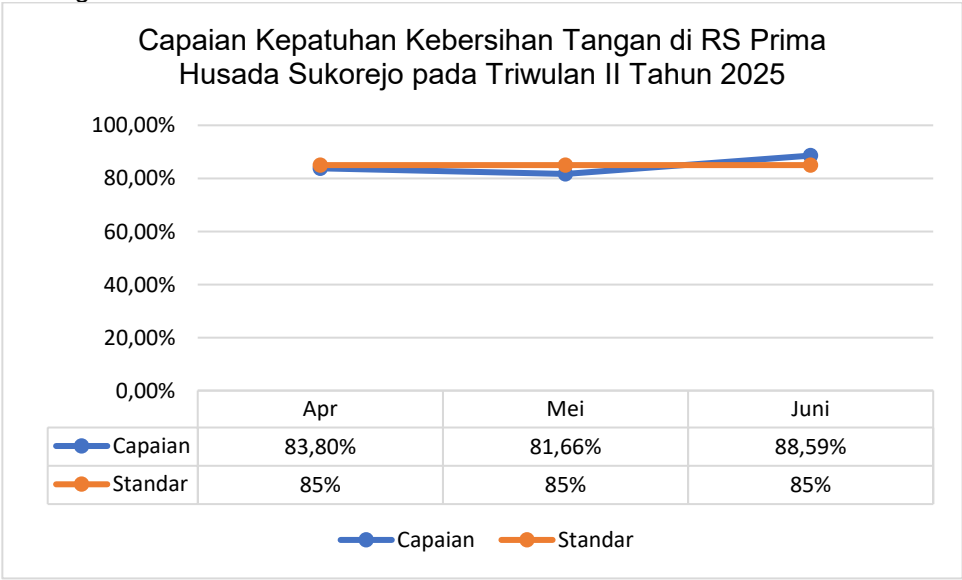


Gambar 3.19. Capaian Kejadian tidak dilakukannya Penandaan pada pasien operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa kejadian tidak dilakukannya Penandaan pada pasien operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II Tahun 2025 mencapai target 0 kejadian. Angka kejadian tercatat nol (0) dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

f. Kebersihan Tangan



Gambar 3.20. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan pada Triwulan II (April–Juni), diperoleh rata-rata sebesar 84,68%. Pada bulan April, tingkat kepatuhan mencapai 83,80%, kemudian menurun menjadi 81,66% di bulan Mei, dan meningkat signifikan menjadi 88,59% di bulan Juni. Meskipun nilai masih berada di atas 80%, capaian belum memenuhi standar ideal kepatuhan kebersihan tangan WHO yaitu $\geq 85\%$. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi kepatuhan terhadap kebersihan tangan masih menjadi tantangan, dan perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran serta pengawasan terhadap praktik kebersihan tangan di seluruh unit pelayanan.

Tabel 3.20 PDSA Capaian Kepatuhan kepatuhan kebersihan tangan petugas pada Triwulan II Tahun 2025

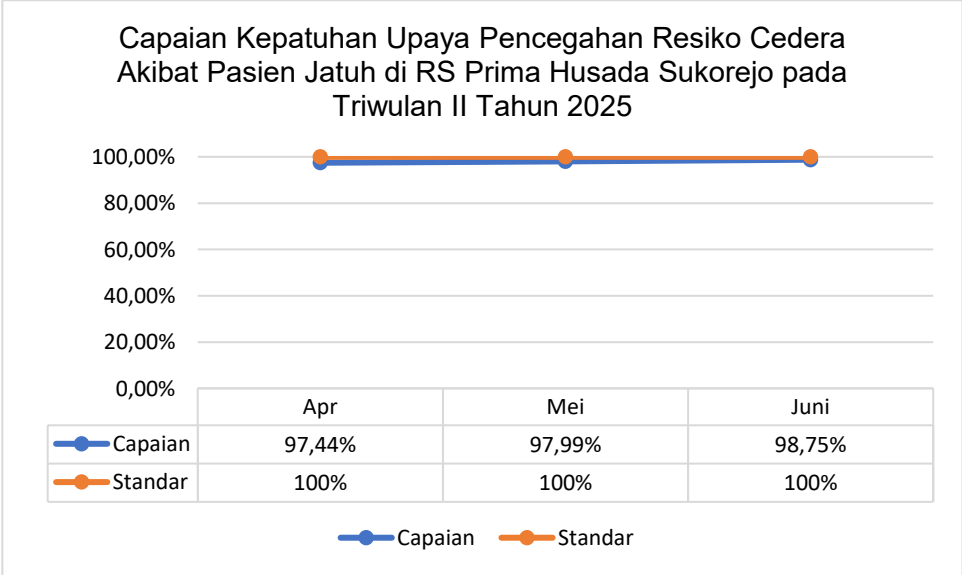
Problem	Kepatuhan kebersihan tangan pada Triwulan II 2025 hanya mencapai 84,68%, belum mencapai target $\geq 85\%$.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	- Masalah yang ditemukan: - Tingkat kepatuhan kebersihan tangan tenaga kesehatan belum mencapai target $\geq 85\%$, dengan rata-rata kepatuhan saat ini sebesar 84,68%. - Masih ditemukan staf yang belum konsisten menerapkan praktik kebersihan tangan sesuai 5 Momen WHO. - Beberapa unit menunjukkan kepatuhan di bawah 85%, terutama saat jam sibuk atau malam hari. - Tujuan: - Menstabilkan dan mempertahankan kepatuhan $\geq 85\%$ secara konsisten selama Triwulan III (Juli–September 2025). - Membentuk perilaku otomatis kebersihan tangan di semua momen pelayanan - Rencana Aksi: - Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>). - Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. - Memberikan reward pada staff atau unit yang patuh dalam menjalankan kepatuhan kebersihan cuci tangan dan 5 momen
Do	- IPCN/IPCLN melakukan observasi acak langsung dan memberi umpan balik real time minimal 3 kali/minggu - Kepala unit melakukan briefing singkat tentang kepatuhan hand hygiene setiap awal shift. - Memberikan apresiasi mingguan kepada tenaga kesehatan/unit dengan kepatuhan tertinggi.
Study	- Hasil data Kepatuhan kebersihan tangan Triwulan II 2025 yaitu 84,68% - Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan unit pelayanan, unit dengan rerata kepatuhan $\geq 85\%$ adalah IRNA 3A sebesar 84,68%. - Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan profesi tertinggi adalah profesi dokter yaitu sebesar 90,43% walaupun belum mencapai standar - Staff tidak mempraktekkan Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan <i>5 Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO - Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan 5 momen didapatkan - Sebelum kontak dengan pasien sebesar 56,40% - Sebelum Tindakan aseptik sebesar 49,07% - Setelah terpapar cairan tubuh pasien sebesar 58,37% - Setelah kontak dengan pasien sebesar 64,88% - Setelah dari lingkungan pasien sebesar 54,53%
Action	- Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>). - Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. - Memberikan reward pada staff atau unit yang patuh dalam menjalankan kepatuhan kebersihan cuci tangan dan 5 momen

Tabel 3.21 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Wakt u
1	Audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan	Mengetahui secara langsung tingkat kepatuhan	Seluruh tenaga kesehatan di masing-masing unit	- Observasi langsung oleh IPCN/IPCLN - Feedback	IPCN/IPCLN	1 kali/minggu/unit (Juli–

	bedside coaching	petugas terhadap 5 momen kebersihan tangan		real-time di tempat - Dokumentasi hasil audit untuk evaluasi		Sept 2025)
2	Melibatkan kepala unit sebagai role model dalam pelaksanaan kebersihan tangan	Meningkatkan komitmen dan keterlibatan pimpinan unit dalam budaya keselamatan pasien	Kepala ruang/unit pelayanan	- Kepala unit memberikan briefing awal shift tentang hand hygiene - Melakukan contoh perilaku langsung - Melaporkan kepatuhan tim tiap minggu ke manajemen	Kepala Unit, Jajaran Manajemen	Briefing harian & laporan mingguan
3	Memberikan reward kepada staf/unit yang memiliki tingkat kepatuhan terbaik	Memberikan motivasi dan memperkuat budaya positif terhadap kepatuhan kebersihan tangan	Seluruh tenaga kesehatan di masing-masing unit	Penilaian berdasarkan hasil audit IPC - Pengumuman mingguan/bulanan untuk staf/unit terbaik - Pemberian piagam/apresiasi kecil sebagai motivasi	Tim PPI, Manajemen Mutu, SDM	Reward diberikan tiap akhir bulan (Juli–Des 2025)

g. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh



Gambar 3.12. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada Triwulan II tahun 2025 adalah 98,06%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Terdapat tren peningkatan capaian dari bulan ke bulan, yaitu dari 97,44% (April) menjadi 98,75% (Juni). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kepatuhan secara bertahap selama triwulan berjalan.

Tabel 3.22 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 98,06%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan resiko jatuh
Plan	Masalah : - Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 98,06% - Meskipun telah dilakukan pelatihan di unit umum pada bulan Juni 2025, belum seluruh petugas di unit pelayanan dan penunjang terpapar materi. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh hingga mencapai standar minimal 100%. Rencana Aksi : - Memberikan pelatihan PMKP yang mencakup risiko jatuh ke seluruh petugas pelayanan dan penunjang di Bulan Juli 2025 - Menyusun ulang SPO singkat dan form skrining risiko jatuh yang mudah dipahami. - Memasang reminder visual tentang risiko jatuh di setiap tempat tidur pasien. - Menyiapkan label risiko jatuh (gelang dan tanda di tempat tidur) serta mengevaluasi kelengkapan dokumentasi.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? - Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning awal resiko jatuh pasien - Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning ulang pasien indikasi risiko jatuh di rawat inap - Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? - Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 98,06% - Asuhan skrining risiko jatuh tidak dilakukan secara menyeluruh, seperti tidak adanya pemasangan tanda risiko jatuh pada alat bantu mobilisasi pasien (misalnya kursi roda). - Hand rail di tempat tidur pasien terpasang disebelah sisi, yang seharusnya menjadi alat bantu penting untuk mencegah pasien terjatuh dari tempat tidur. - Tidak terempelnya stiker penanda risiko jatuh di tempat tidur pasien - Kurangnya edukasi kepada pasien yang memiliki risiko jatuh, yang merupakan langkah penting dalam melibatkan pasien dalam menjaga keselamatan dirinya sendiri
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Triwulan II Tahun 2025 belum sesuai standar yakni 98,06% Follow-up dan Rencana Lanjutan - Memberikan pelatihan PMKP yang mencakup risiko jatuh ke seluruh petugas pelayanan dan penunjang di Bulan Juli 2025 - Menyusun ulang SPO singkat dan form skrining risiko jatuh yang mudah dipahami. - Memasang reminder visual tentang risiko jatuh di setiap tempat tidur pasien. - Menyiapkan label risiko jatuh (gelang dan tanda di tempat tidur) serta mengevaluasi kelengkapan dokumentasi.

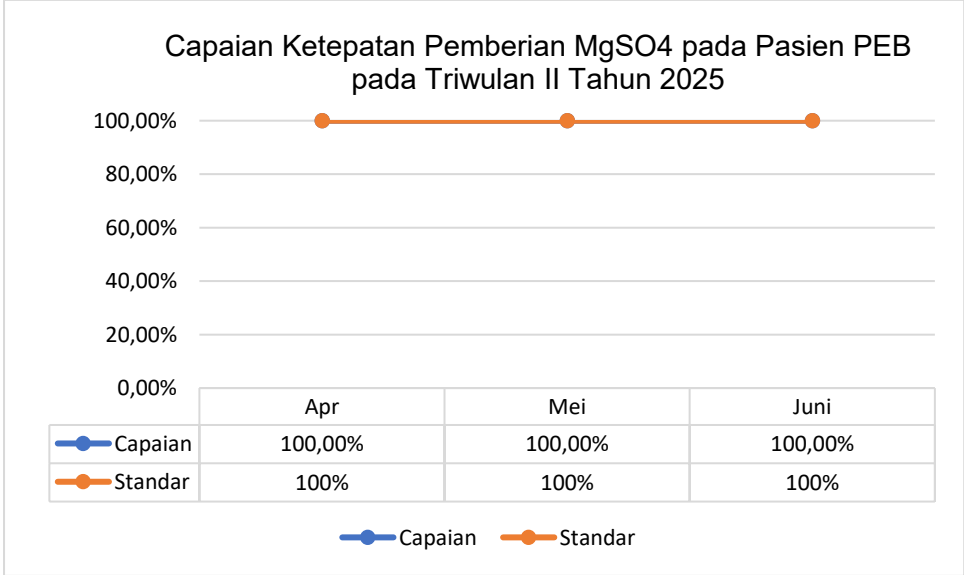
Tabel 3.23 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
----	---------	--------	---------	-----------	-----------	-------

	Kegiatan					
1	Memberikan pelatihan PMKP yang mencakup risiko jatuh ke seluruh petugas pelayanan dan penunjang	Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan staf dalam pencegahan risiko jatuh	Seluruh petugas pelayanan dan penunjang (perawat, dokter, lab, radiologi, farmasi, rehab medik, dll)	Pelatihan klasikal dan simulasi lapangan terkait skrining dan tindakan pencegahan risiko jatuh	Komite PMKP, PJ SKP, SDM & Kepala Ruang	Juli
2	Menyusun ulang SPO singkat dan form skrining risiko jatuh yang mudah dipahami	Menyederhanakan panduan agar mudah diikuti dan konsisten diterapkan di semua unit	Seluruh petugas yang mengisi skrining risiko jatuh	Meninjau SPO lama dan menyusun ulang SPO singkat berbasis praktik terbaik dan hasil audit	Komite PMKP, PJ SKP, SDM & Kepala Ruang	Juli
3	Memasang reminder visual tentang risiko jatuh di setiap tempat tidur pasien	Meningkatkan kesadaran petugas dan keluarga pasien tentang pencegahan risiko jatuh	Seluruh pasien rawat inap dan petugas di ruang perawatan	Pemasangan stiker/peringatan visual pada dinding/tempat tidur pasien dengan risiko jatuh	Kepala Unit	Juli
4	Menyiapkan label risiko jatuh (gelang dan tanda di tempat tidur) serta mengevaluasi kelengkapan dokumentas	Meningkatkan identifikasi pasien risiko tinggi dan memastikan dokumentasi lengkap	Pasien dengan risiko jatuh dan petugas yang melakukan penilaian risiko	Distribusi label risiko jatuh & audit checklist kelengkapan form risiko jatuh	Kepala Unit	Juli

2. Analisis Capaian Indikator Pelayanan Klinis Prioritas

a. Ketepatan Pemberian MgSO4 pada Pasien PEB



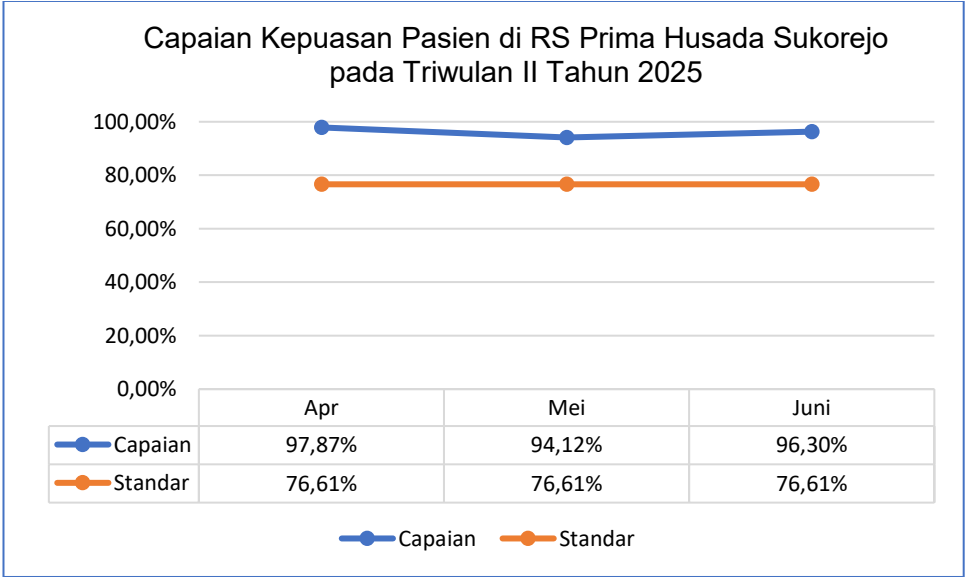
Gambar 3.22. Capaian Ketepatan Pemberian MgSO4 pada Pasien PEB di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Bulan Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketepatan pemberian MgSO4 pada Pasien PEB di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Bulan Triwulan II Tahun 2025 yakni mencapai 100%.

b. Kepatuhan Penanganan Bronchopneumonia sesuai dengan Kriteria Klaim BPJS

- c. Pasien dengan Dengue yang Mendapatkan Pemantauan dan Intervensi Tepat Waktu untuk Mencegah Komplikasi Berat (Seperti Shock atau Perdarahan) dalam 24 Jam Pertama Setelah Diagnosis
 - d. Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium
 - e. Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan
 - f. Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol
 - g. Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c $<7\%$
 - h. Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)
 - i. Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor
 - j. Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah $<140/90$ mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis
3. Analisis Capaian Indikator Rencana Strategis RS
- a. Kepuasan Pasien

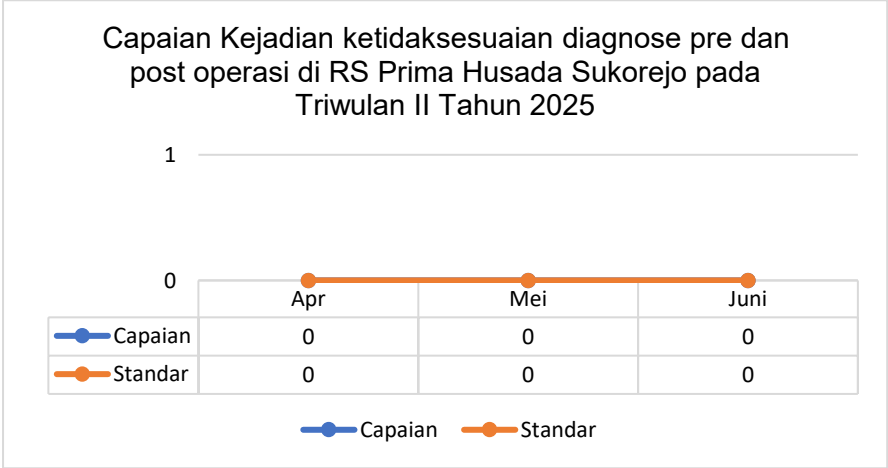


Gambar 3.32. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Bulan Triwulan II Tahun 2025 capaian Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 96,10%. Angka tersebut sudah mencapai target 76,61%.

4. Analisis Capaian Indikator Perbaikan Sistem
- a. Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi



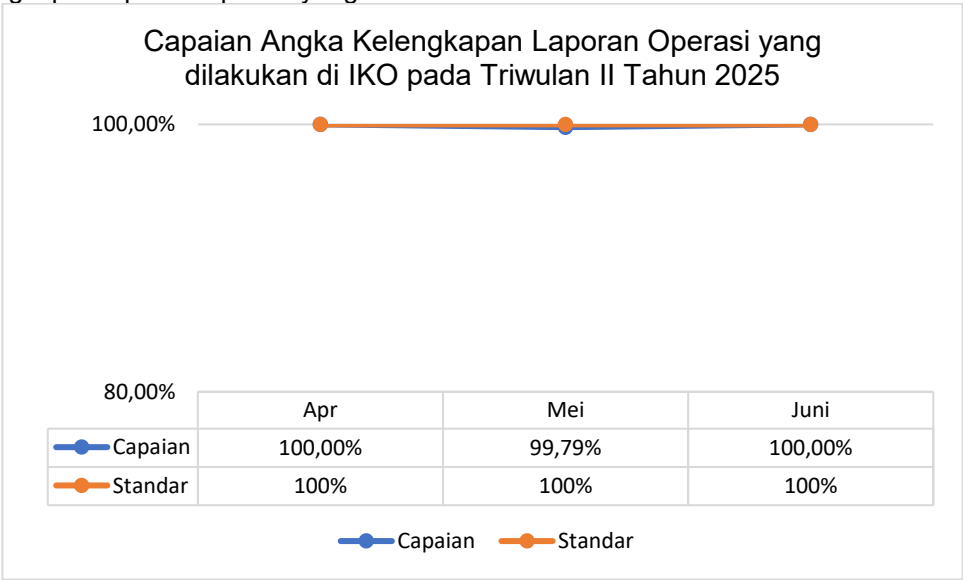
Gambar 3.33. Capaian Kejadian Ketidaksesuaian Diagnosa Pre dan Post Operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Bulan Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan II Tahun 2025 capaian kejadian ketidaksesuaian diagnose pre & post operasi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 0 kejadian. Angka

tersebut sudah mencapai target 0 kejadian.

b. Angka Kelengkapan laporan Operasi yang dilakukan di IKO

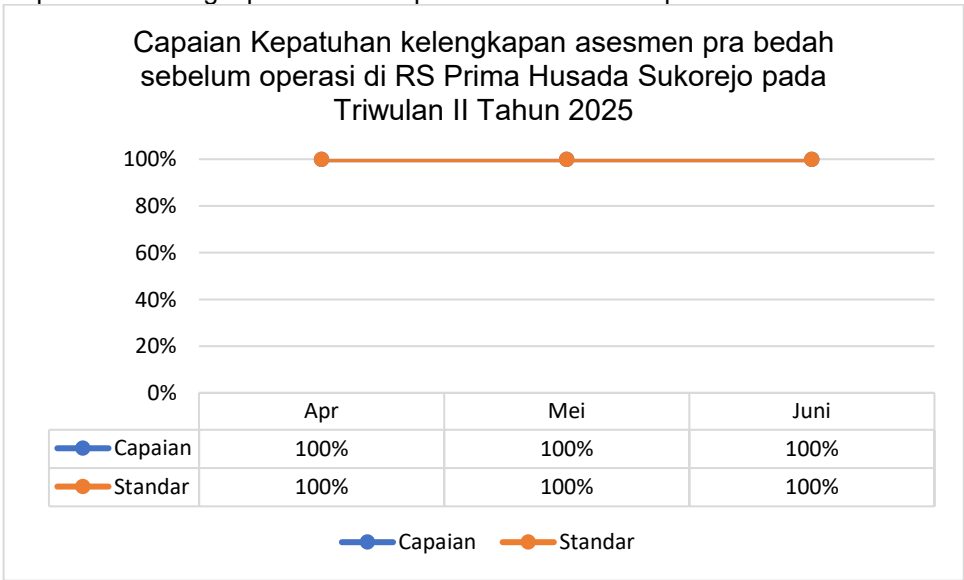


Gambar 3.34. Capaian Angka Kelengkapan Laporan Operasi yang dilakukan di IKO di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan II Tahun 2025 capaian angka kelengkapan laporan operasi yang dilakukan di IKO di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 99,93% belum sesuai standar 100%.

c. Kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi

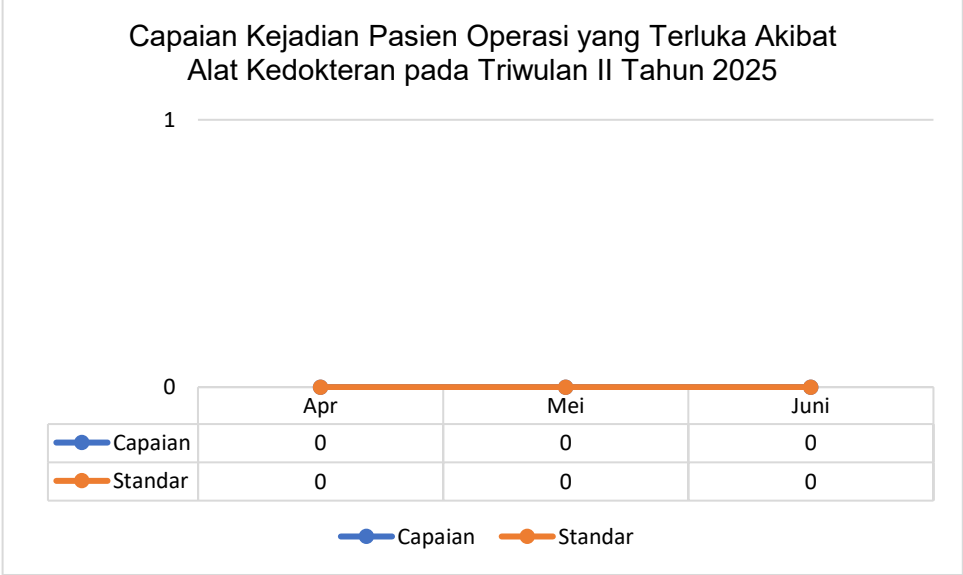


Gambar 3.35. Capaian Kepatuhan Kelengkapan Asesmen Pra Bedah Sebelum Operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan II Tahun 2025 capaian kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa prosedur asesmen pra bedah sudah menjadi bagian dari kegiatan rutin yang terstandarisasi di ruang tindakan/pre-operatif.

5. Analisis Capaian Indikator Manajemen Resiko
- a. Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran

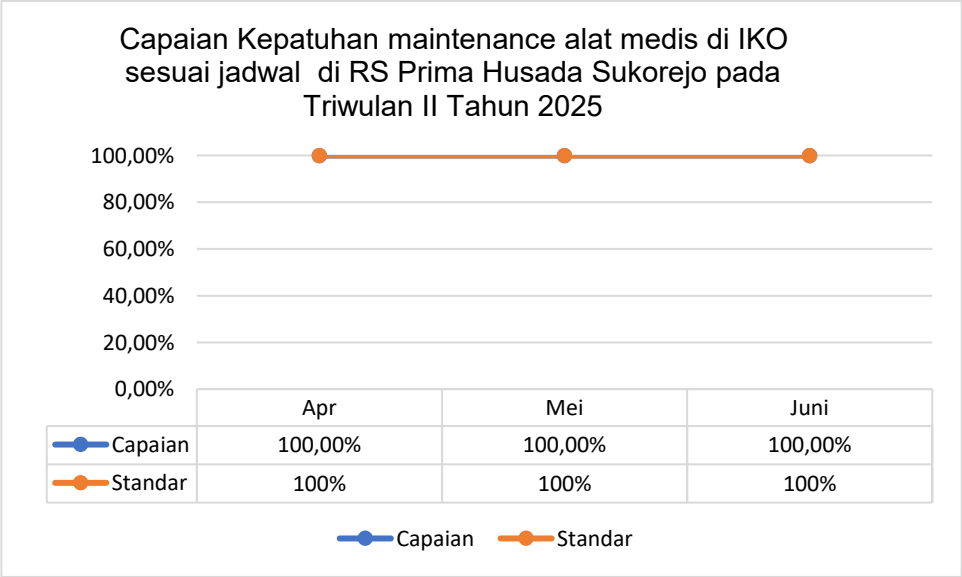


Gambar 3.36. Capaian Kejadian Pasien Operasi yang Terluka Akibat Alat Kedokteran di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Bulan Bulan Triwulan II Tahun 2025 kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran di RS Prima Husada Sukorejo yakni 0 kejadian. Pada bulan Maret 2025, telah dilakukan pergantian alat kedokteran, khususnya harum pen. Dampak positifnya pada Bulan April dan Triwulan II Tahun 2025 yakni menurunnya risiko cedera pada pasien operasi, dan meningkatkan kinerja tim bedah dan sterilisasi karena alat sudah memenuhi standar.

- b. Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal



Gambar 3.37. Capaian Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Bulan Triwulan II Tahun 2025 capaian Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 100%. Angka tersebut sudah mencapai target 100%. Kepatuhan 100% menunjukkan bahwa program maintenance alat medis di IKO berjalan optimal dan sesuai dengan jadwal. Tidak ditemukan keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan preventive maintenance maupun kalibrasi alat-alat kritis

3.1.5 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit

1. INSTALASI GAWAT DARURAT

Tabel 3.24 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Gawat Darurat pada Triwulan II Tahun 2025

No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	82,35%	80,49%	94,59%	≥ 85 %	85,81%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan pasien	95,74%	92,16%	92,59%	≥ 76,61 %	98,67%	Dipertahankan
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	97,33%	88,39%	98,67%	100%	94,80%	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa anestesi yang dimusnahkan
3	Pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		Belum diisi
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Instalasi Gawat Darurat <5 menit setelah pasien datang	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kematian pasien< 24 (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	13/1945	20/1921	24/1200	≤ dua per seribu	1,24%	PDSA
3	Kelengkapan pengisian pengkajian medis E-Rm.	96,00%	89,03%	88,39%	100%	91,14%	PDSA
4	Kelengkapan pengisian pengkajian keperawatan E-Rm.	96,67%	96,01%	97,33%	100%	96,67%	PDSA
5	Kelengkapan pengisian LOP	97,33%	89,68%	87,74%	100%	91,58%	PDSA
6	Kelengkapan berkas triage E-RM pada pasien IGD	93,75%	90,32%	90%	100%	91,36%	PDSA
7	Waktu Tunggu Pemasangan Gelang Identitas pasien dari pasien mendaftar sampai terpasang di	90,32%	0,9%	0,9%	100%	30,71%	PDSA

No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	pasien < 15 menit						
8	Respon time pengantaran pasien P2 & P3 ke Rawat Inap < 3 jam	90,32%	90,32%	90,32%	100%	90,32%	PDSA

2. INSTALASI RAWAT JALAN

Tabel 3.25 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Jalan pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	84,40%	86,96%	79,07 %	≥ 85 %	83,48%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	58,33%	-	67,83 %	100%	63,08%	PDSA
4	Kepuasan pasien	-	-	-	≥ 76,61%	-	Belum diisi
5	Waktu tunggu rawat jalan	74,78%	70,14%	79,70 %	≥80%	74,87%	PDSA
6	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan	-	-	-	≤5%	-	Belum diisi
2	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol	-	-	-	≥ 95%	-	
3	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%	-	-	-	≥ 70%	-	
4	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)	100%	100%	100%	≥ 95%	100%	Dipertahankan
5	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		
6	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah				≥ 75 %		

	<140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis						
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Angka keterlambatan dokter di poli rawat jalan ≥ 30 menit	9,98%	9,68%	14,00 %	0%	11,22%	PDSA
2.	Kelengkapan pengisian pengkajian awal medis E-RM pasien rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Kelengkapan pengisian pengkajian awal keperawatan E-RM pasien rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Kelengkapan Form E-RM PRMRJ Pasien	100%	95,87%	100%	100%	98,62%	PDSA

3. INSTALASI RAWAT INAP 2A

Tabel 3.26 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2A pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	94,55%	94,55%	96,19%	100%	95,10%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	77,91%	69,03%	86,67%	≥ 85 %	77,87%	PDSA
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	93,64%	95,45%	96,19%	100%	95,09%	PDSA
4	Kepuasan pasien	85,71%	80%	100%	≥ 76,61 %	88,57%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	87,27%	84,55%	76,19%	≥ 80%	82,67%	Dipertahankan
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-	≥ 80%	-	Tidak ada diagnosa tunggal
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	91,38%	94,37%	100%	100%	95,25%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada obat sisa anestesi
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.				≥ 90%		
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium				≥ 95%		
5	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				≤5%		
6	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		
7	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%	25%	33,33%	0%	≥ 70%	19,44%	PDSA
8	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		
9	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		
10	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg				≥ 75 %		

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis						
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	1,82%	1,33%	0,73%	≤ 0,24 %	1,29%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	6	3	5	0 kejadian	5 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	3	0	0	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	96,36%	94,55%	100%	100%	96,97%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	93,64%	95,45%	100%	100%	96,36%	PDSA

4. INSTALASI RAWAT INAP 2B

Tabel 3.27 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2B pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	99,33%	99,35%	99,33%	100%	99,34%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	77,91%	73,12%	80,85%	≥ 85 %	77,29%	PDSA
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	95,33%	95,48%	95,33%	100%	95,38%	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	100%	-	≥ 76,61 %	100%	Bulan Juni tidak ada pasien yang mengisi Barcode Kepuasan Pasien
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	68,67%	78,71%	66,00%	≥ 80%	71,13%	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-	≥ 80%	-	Tidak ada diagnosa tunggal
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi	92,67%	93,55%	94,00%	100%	93,41%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	efektif menggunakan SBAR						
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-		100%		Tidak ada obat sisa anestesi
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.				≥ 90%		
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium				≥ 95%		
5	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				≤5%		
6	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		
7	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%		5%	0%	≥ 70%	2,50%	PDSA
8	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		
9	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		
10	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah				≥ 75 %		

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	<140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis						
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	1,40%	0,24%	0,25%	≤ 0,24 %	0,63%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	2 kejadian	2 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	90,67%	91,61%	94,00%	100%	92,09%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	91,33%	92,90%	92,00%	100%	92,08%	PDSA

5. INSTALASI RAWAT INAP 3A

Tabel 3.28 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3A pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	99,33%	98,06%	98,67%	100%	98,69%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	82,46%	85,11%	95,83%	≥ 85 %	87,80%	Dipertahankan
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	98,67%	96,77%	98,00%	100%	97,81%	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	92,86%	100%	≥ 76,61 %	97,62%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	94,00%	91,29%	97,33%	≥ 80%	94,21%	Dipertahankan
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-	≥ 80%	-	Tidak ada diagnosa tunggal
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	95,15%	100%	-	100%	97,58%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	96,13%	97,42%	99,33%	100%	97,63%	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa anestesi
3	Pasien dengan				≥ 90%		

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.						
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium				≥ 95%		
5	Kepatuhan Penanganan Bronchopneumonia sesuai dengan Kriteria Klaim BPJS				100%		Dipertahankan
6	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%				≥ 70%		
7	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		
8	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		
9	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				≥ 75 %		
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0%	0%	0,59%	≤ 0.24 %	0,20%	Dipertahankan
2.	Kejadian pulang paksa	2 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	4 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal	98%	96,77%	98,67%	100%	97,81%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	medis oleh DPJP ≤24 Jam						
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

6. INSTALASI RAWAT INAP 3B

Tabel 3.29 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3B pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	98,00%	99,35%	97,33%	100%	98,23%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	86,96%	85,03%	71,05%	≥ 85 %	81,01%	PDSA
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	98,67%	90,32%	95,33%	100%	94,77%	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	78,26%	87,50%	≥ 76,61 %	88,59%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	35,33%	48,39%	53,33%	≥ 80%	45,68%	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	100%	-	-	≥ 80%	100%	Tidak ada diagnosa tunggal
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	98,00%	98,71%	93,33%	100%	96,68%	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-		100%		Tidak ada obat sisa anestesi
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.				≥ 90%		
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik				≥ 95%		

	yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium						
5	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				$\leq 5\%$		
6	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				$\geq 95\%$		
7	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c $<7\%$	33,33%	0%	88,89%	$\geq 70\%$	40,74%	PDSA
8	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				$\geq 95\%$		
9	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				$\geq 90\%$		
10	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah $<140/90$ mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				$\geq 75\%$		
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0,37%	1,36%	1,01%	$\leq 0.24\%$	0,91%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	2 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
4.	Angka Kepatuhan Pengisihan pengkajian awal medis oleh DPJP ≤ 24 Jam	79,33%	42,58%	75,33%	100%	65,75%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box	96,67%	98,71%	98,00%	100%	97,79%	PDSA

	Obat						
--	------	--	--	--	--	--	--

7. INSTALASI KAMAR OPERASI

A. Bedah

Tabel 3.30 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Bedah pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	75%	46,15%	-	≥ 85 %	61%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Penundaan operasi elektif ≥ 60 menit	4,52%	1,37%	3,84%	≤ 5%	3,24%	Dipertahankan
5	Kepuasan pasien	100%	-	-	≥ 76,61 %	100%	Dipertahankan
6	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	0%	100%	0%	100%	33,33%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan pelaksanaan <i>surgical safety checklist</i> sesuai standart	100%	100%	100%	100%		Dipertahankan
2	Kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian		Dipertahankan
3	Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB	-	-	-	100%		Tidak ada pemberian MgSO4 di Ruang IKO
4	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		Dipertahankan
5	Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian		Dipertahankan
6	Angka kelengkapan laporan operasi yang dilakukan di IKO	100%	99,79%	100%	100%		PDSA
7	Angka kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
8	Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	kedokteran						
9	Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kepatuhan pembersihan ruang IKO antar jeda waktu operasi (30 menit)				100%		Belum diisi
2.	Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari				100%		Belum diisi
3.	Kejadian Kematian di meja Operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Kejadian operasi salah sisi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Kejadian operasi salah orang	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6.	Kejadian salah tindakan pada operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7.	Kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

B. Anestesi

Tabel 3.31 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Anestesi pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada sisa obat anestesi
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Kejadian komplikasi anestesi karena overdosis	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	≤ 6 %	0 kejadian	Dipertahankan
2	Kejadian reaksi anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	≤ 6 %	0 kejadian	Dipertahankan
3	Kejadian salah penempatan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	≤ 6 %	0 kejadian	Dipertahankan
4	Kejadian ketidaklengkapan pengisian asesmen praanestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kejadian konversi regional anestesi ke general anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Angka efek samping selama	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan

	sedasi moderat						
7	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring status fisiologis selama anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring pemulihan pasca anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

8. MATERNITAS

Tabel 3.32 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Maternitas pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	93,57%	96,13%	97,84%	100%	95,85%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	86,67%	92,47%	94,00%	≥ 85 %	91,05%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 mnt	91,67%	100%	100%	> 80%	97,22%	Dipertahankan
6	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	88,57%	88,99%	92,73%	≥ 80%	90,10%	Dipertahankan
7	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	98,44%	98,84%	98,75%	≥ 80%	98,68%	Dipertahankan
8	Kepuasan Pasien	100%	100%	100%	≥ 76,61 %	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa anestesi
3	Kepatuhan DPJP dalam penggunaan MgSO4 pada pasien Pre eklamsi Berat/Eklamsi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kepatuhan Kasus hemoragi post partum yang ditatalaksana dengan asam traneksamat	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kejadian pasien	0	0	0	0	0	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	Preeklamsia yang mengalami perburukan menjadi eklamsi	kejadian	kejadian	kejadian	kejadian	kejadian	
3	Kejadian pasien dengan kasus Preeklamsi berat aterm yang dilahirkan dalam waktu > 24 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Kejadian pasien dengan Eklamsia yang dilahirkan dalam waktu > 12 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh PEB	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh Eklampsia	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7	Kepatuhan Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala III segera setelah bayi lahir	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
8	Kejadian kematian ibu karena HPP	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
9	Kejadian korioamnionitis pada ibu hamil dengan ketuban pecah dini prematur	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
10	Kepatuhan pemberian antibiotika profilaksis sebelum operasi SC < 1 jam	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
11	Kejadian kematian ibu persalinan karena sepsis	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
12	Kepatuhan pemberian kortikosteroid pada persalinan premature	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
13	Kepatuhan Pemeriksaan DJJ saat kala II	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

9. PONEK

Tabel 3.34 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PONEK pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan	100%	99,07%	100%	100%	99,69%	PDSA

	identifikasi pasien						
2	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 mnt	100%	85,71%	100%	> 80%	95,24%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	-	-	-	≥ 76,61 %	-	Belum diisi
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa
3	Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Kepatuhan Kasus hemoragi post partum yang ditatalaksana dengan asam traneksamat	-	-	-	100%	-	Tidak ada pasien HPP di Ponek
2	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit yang dilakukan oleh Tim ponek yang terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
3	Persentase Ibu bersalin yang dilakukan skrining penilaian kegawatan/ severitas saat masuk ke Fasyankes	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan

10. NEONATOLOGI

Tabel 3.35 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Neonatologi pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	98,65%	100%	100%	100%	99,55%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	88,79%	93,55%	96,81%	≥ 85%	93,05%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	60,81%	65,82%	93,41%	≥ 80%	73,35%	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical	-	-	-	≥ 80%	-	Tidak ada pasien

	pathway)						dengan Diagnosa tunggal
7	Kepuasan Pasien	100%	-	100%	$\geq$ 76,61%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir	2 kejadian	8 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	4 kejadian	PDSA
2	Kepatuhan petugas dalam melakukan tindakan Ventilasi Tekanan positif (VTP) pada bayi baru lahir tanpa ada usaha napas (< 1 menit)	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Bayi baru lahir yang mengalami sesak napas yang mendapatkan T-piece resuscitator/CPAP dalam waktu 2 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Bayi baru lahir hidup stabil berat lahir 1500-2000 gr yang mendapatkan perawatan metode kanguru minimal 1 jam per hari	92,31%	100%	80%	100%	90,77%	PDSA
5	Kepatuhan DPJP dalam pemberian antibiotik pada BBL infeksi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
6	Kejadian kematian bayi di Rumah Sakit	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
7	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

11. ICU

A. ICU

Tabel 3.36 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ICU pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	97,83%	93,10 %	100%	96,98%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	75%	100%	65%	≥ 85%	80%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	53,57%	50%	68,97 %	≥ 80%	57,51%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	45,45%	100%	100%	100%	81,82%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa anestesi
3	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol	-	-	-	≥ 95%	-	Tidak ada pasien ca mammae
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Angka pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	0%	0%	0%	≤ 3 %	0%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan pengisian pengkajian form kriteria keluar masuk ICU pada pasien ICU	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

B. ICU ISOLASI

Tabel 3.37 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ICU Isolasi pada Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	-	-	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	-	-	100%	≥ 85%	100%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	-	-	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	-	-	50%	≥ 80%	50%	PDSA (2 Pasien)
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	-	-	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan penanganan bronchopneumoni a sesuai dengan kriteria klaim BPJS	-	-	-	100%	-	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kepatuhan Waktu Pelayanan dokter di ICU isolasi (≤ 30 menit)	-	-	50%	≥ 80%	50%	PDSA
2.	Kepatuhan Pembersihan dan	-	-	100%	≥ 95%	100%	Dipertahankan

No	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	desinfeksi ruangan						

12. RADIOLOGI

Tabel 3.38 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Radiologi pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	77,78%	100%	100%	≥ 85%	92,59%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Kepuasan pasien	-			≥ 76,61%		Belum diisi
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤ 1 jam	96%	94,84%	90,32 %	100%	93,72%	PDSA
2.	Complain DPJP atas pembacaan hasil radiologi	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3.	Angka ketidaklengkapan form permintaan radiologi	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
4.	kejadian kesalahan cetak hasil radiologi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

13. LABORATORIUM

Tabel 3.39 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laboratorium pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	88,51%	-	-	≥ 85%	29,50%	PDSA (Mei dan Juni tidak dilakukan pengukuran)
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	84,62%	-	-	100%	28,21%	PDSA (Mei dan Juni tidak dilakukan pengukuran)
4	Kepuasan pasien				≥76,61%		
5	Pelaporan nilai kritis ≤30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 120 menit kimia darah & darah rutin	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	kesalahan	0	0	0	0	0 kejadian	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	pemberian hasil pemeriksa laboratorium	kejadian	kejadian	kejadian	kejadian		
3	Angka Kerusakan Sampel Darah	0%	0,05%	0%	0%	0,02%	PDSA
4	Angka ketidaklengkapan form permintaan laboratorium	5,02%	5,25%	5,98%	0%	5,42%	PDSA
5	Kejadian Kesalahan Pemindahan Hasil Laboratorium ke SIMRS	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Kejadian Ketidaktepatan Waktu Pemeliharaan Alat KSO	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7	Kejadian Keterlambatan Backup Alat Error Dalam Waktu 1x24 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8	Kejadian Keterlambatan Hasil Laboratorium CITO ≥30menit	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
9	Kejadian Keterlambatan Penyerahan labu darah > 1 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
10	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
11	Angka Reaksi Tranfusi Darah	0%	0%	0%	< 0,01%	0%	Dipertahankan
12	Kejadian ED labu darah	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

14. REHAB MEDIS

Tabel 3.40 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rehab Medis pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	84,44%	86,96%	79,07%	≥ 85%	83,49%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	-	-	-	≥ 76,61%	-	Belum ada pasien yang scan barcode
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Kejadian kesalahan Tindakan fisioterapi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2	Kelengkapan pengisian pengajian medis & protokol pasien rehab medik	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Kelengkapan pengisian pengkajian fisioterapi pasien rehab medik	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan pengisian pengkajian reassesment setiap 2 minggu & akhir terapi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

15. FARMASI

Tabel 3.41 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Farmasi pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	88,10%	87,36%	100%	≥ 85%	91,82%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan pasien	97,87%	94,12%	96,30 %	≥ 76,61 %	96,10%	Belum diisi
5	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat yang dimusnahkan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 30 menit	83,85%	81,67%	88,00 %	100%	84,51%	PDSA
2	waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60 menit	69,23%	75,83%	72,80 %	100%	72,62%	PDSA
3	Kejadian kesalahan pernberian obat	0 Kejadian	5 Kejadian	2 Kejadian	0 kejadian	2 Kejadian	PDSA (kesalahan obat di rawat inap)
4	Kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
5	Kejadian pemberian antibiotik profilaksis < 60 menit sebelum insisi	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
6	Kejadian perubahan pemberian obat profilaksis menjadi teraupetik	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

16. GIZI

Tabel 3.42 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gizi pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	84,72%	80,65%	96,30%	≥ 85%	87,22%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	80,65%	65,22%	100%	81,96%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	97,87%	94,12%	96,30%	≥ 76,61%	96,10%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	100%	100%	100%	≥ 90 %	100%	Dipertahankan
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	19%			≤ 20 %	19%	Dipertahankan
3	Kejadian kesalahan pemberian diet	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Angka kelengkapan pengisian asuhan gizi pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Kejadian ditemukannya benda asing dalam makanan pasien	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Tersedianya air panas di tempat cucian alat dapur dengan standar 70 derajat	0%	0%	0%	100%	0%	PDSA

17. REKAM MEDIS

Tabel 3.43 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rekam Medis pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepuasan Pasien	97,87%	94,12%	96,30	76,61%	96,10%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
				%			
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	91,74%	95,87%	94,83 %	100 %	94,15%	PDSA
2	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	53,97%	42,24%	30,43 %	100 %	42,21%	PDSA
3	Kejadian Nomor Rekam Medis Ganda	6 kejadian	11 kejadian	9 kejadian	0 kejadian	9 kejadian	PDSA
4	Kejadian SEP tidak diterbitkan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kelengkapan RM pasien rawat inap (nama, TTD, jam, tgl)	63%	57%	57%	100%	59%	PDSA
6	Angka keterlambatan pengembalian DRM Pasien umum dan asuransi > 1x24 jam	28,13%	24,27%	28,71 %	0%	27,04%	PDSA
7	Kelengkapan NIK di data pasien	97,18%	96,84%	96,76 %	100%	96,93%	PDSA
8	Kelengkapan General Consent	98,58%	98,51%	99,25 %	100%	98,78%	PDSA
9	Kelengkapan berkas E-RM IGD	4,03%	3,87%	15,33 %	100%	7,74%	PDSA
10	Ketepatan laporan dengan pihak eksternal	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

18.
LIMBAH – K3RS

Tabel 3.44
Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Limbah-K3RS pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Baku mutu limbah cair	a. BOD = 8,53 mg/l b. COD = 35,70 mg/l c. TSS = 5,72 mg/l d. PH =7,20	a.BOD = 14,75 mg/l b. COD =41,10 mg/l c. TSS = 9,88 mg/l d. PH =7,30	a.BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	a.BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	a. BOD = mg/l b. COD = mg/l c. TSS = mg/l d. PH =	Dipertahankan
2.	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dipertahankan
3.	Angka kepatuhan staf dalam	48,18%	61,82%	61,82%	100%	61,82%	1 Tahun

	mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali						
4.	Kejadian pelaporan kecelakaan kerja ≤ 48 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

19. SDM

Tabel 3.45 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit SDM pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Kelengkapan pelaporan penilaian kinerja staf	62,96%	62,96%	60,74%	100 %	62,22%	PDSA
2.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	0%	0%	0%	≥ 60 %	0%	1 Tahun
3.	Angka turn over staf	0,86%	1,52%	1,30%	≤10% / bulan	1,23%	Dipertahankan
4.	Kejadian SIP staf habis masa berlaku	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Angka keterlambatan staf ≥10 menit	8,62%	10,85%	12,99%	0%	10,82%	PDSA
6.	Angka staff tersertifikasi khusus a. IGD : BLS/PPG D/GELS/ALS b. PONEK : PPGD c. ICU d. HD e. IKO f. Hiperkes g. NICU/PICU	65,02%	65,02%	65,02%	100%	65,02%	PDSA
7.	Kepuasan karyawan	69%			≥ 80 %	69%	Semesteran PDSA
8.	Respon time penanganan masalah karyawan ≤ 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

20. KESEKRETARIATAN

Tabel 3.46 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Kesekretariatan pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

	unit ke sekretariat						
3.	Ketepatan pendistribusian surat masuk	100%	97,06%	100%	100%	99,02%	PDSA
4.	Ketepatan pendistribusian surat keluar	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

21. DRIVER

Tabel 3.47 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Driver pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Kepatuhan waktu pengantaran penggunaan ambulance < 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan pelaksanaan dekontaminasi ambulance	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan
3.	Response time driver ambulance < 5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

22. PEMULASARAAN JENAZAH

Tabel 3.48 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Pemulasaran Jenazah pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pendokumentasian pemulasaraan jenazah	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

23. ATEM – IPSRS

Tabel 3.49 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ATEM – IPSRS pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
ATEM							
1.	Waktu tanggap kerusakan alat medis non critical 1x24 jam	100%	100%	100%	≤ 80%	100%	Dipertahankan
2.	Waktu tanggap kerusakan alat medis critical ≤ 15 menit	-	-	-	100%	-	Tidak ada alat medis kritikal
3.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat medis	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Ketepatan kalibrasi alat sesuai dengan jadwal				100%		Alat di Kalibrasi di Bulan Agustus
IPSRS							
1.	Waktu tanggap kerusakan alat non	100%	70,59%	43,35 %	100%	71,31%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	medis ≤ 15 menit						
2.	Waktu tanggap kesiapan fungsi alat genset ≤ 10 detik	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Ketepatan Uji Coba Alat Genset (1 bulan sekali)				100%		Belum diisi

24. LAUNDRY

Tabel 3.50 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laundry pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1.	Kepatuhan penggunaan APD	70%	0%	0%	100%	23,33%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kejadian linen yang hilang	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2.	Kejadian terdapat benda asing di linen	2 kejadian	1 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
3.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat – alat pencucian linen	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

25. CSSD

Tabel 3.51 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Kepatuhan staf CSSD dalam menggunakan APD di area dekontaminasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Kejadian kertas steam indicator tidak berubah sesuai standar 135 derajat (merubah pedoman di 2025)	1 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
3.	Kepatuhan waktu pengembalian instrumen dari user ke CSSD dalam bentuk rendaman	90,48%	95,61%	97,19%	100%	94,43%	PDSA
4.	Kepatuhan hasil biological test negative pada BMHP reuse: 1. Breathing circuit 2. Begging 3. LMA 4. JR	100%	100%	100%	100%	100%	Hasil Swab Instrumen Negative
5.	Kejadian tidak	0	0	0	0	0	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	terpasangnya label LED pada instrumen	kejadian	kejadian	kejadian	kejadian	kejadian	
6.	Terpasangnya label frekuensi pemakaian pada BMHP	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
7.	Kepatuhan petugas unit terkait penulisan serah terima alat pada buku sertir cssd baik bersih dan kotor	88,10%	95,20%	96,48%	100%	93,26%	PDSA
8.	Kepatuhan unit dalam melakukan proses pengiriman dan pengambilan alat sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan CSSD (kecuali cito)	86,51%	95,93%	98,24%	100%	93,56%	PDSA
9.	Kejadian tercampurnya benda tajam dengan instrumen kotor	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan

26. **CLEANING SERVICE**

Tabel 3.52 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CS pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1.	Kepatuhan Penggunaan APD	0%	0%	100%	100%	33,33%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kepatuhan clening service dalam membersihkan ruangan pasien setiap 2x dalam sehari untuk pasien non infeksius	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Respon time petugas kebersihan ≤ 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Ketepatan waktu jadwal pengambilan sampah medis dan non medis ≤3/4 Tempat sampah	100%	75%	100%	100%	91,67%	PDSA
4.	Kepatuhan petugas dalam membersihkan area umum 3x dalam sehari	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

27. KEAMANAN

Tabel 3.53 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keamanan pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Kejadian kehilangan barang milik pasien, penggungjung dan karyawan	0 kejadian	1 kejadian	3 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
2.	Kepatuhan petugas keamanan melaksanakan pengawasan keliling RS 2x dalam setiap shift	100%	100%	98,89%	100%	99,63%	PDSA
3.	Kepatuhan jam berkunjung sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Kejadian kekerasan staf, pasien, & pengunjung di Rumah sakit	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Kejadian merokok di Area Rumah Sakit	566 kejadian	741 kejadian	642 kejadian	0 kejadian	650 kejadian	PDSA
6.	Kepatuhan penggunaan id card pengunjung di area rumah sakit	100%	98,71%	99,89%	100%	99,53%	Dipertahankan
7.	Kepatuhan penggunaan id card staff di area rumah sakit	67,56%	83,23%	88,44%	100%	79,74%	PDSA

28. GUDANG UMUM

Tabel 3.54 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gudang Umum pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Kepatuhan unit dalam pengambilan barang	93,20%	96,09%	93,10%	100%	94,13%	PDSA
2.	Selisih barang fisik dengan inputan SIMRS (SO dan kartu stock)	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3.	Kejadian komplain dari user	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka kepatuhan pengajuan pengadaan ke PT ≤ (lihat SPO)	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

29. PPI

Tabel 3.55 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PPI pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	83,80%	81,66%	88,59%	≥ 85%	84,68%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
2.	Kepatuhan APD	97,92%	98,07%	93,80%	≥ 100%	96,60%	PDSA
Indikator Mutu Komite PPI							
1.	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	82,39%	96,86%	90%	60 %	89,75%	Dipertahankan
2.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	6,33%	75,85%	69,66%	75 %	50,61%	PDSA
3.	Angka infeksi daerah operasi	0%	0%	0%	≤ 1,5%	0%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan Penempatan pasien infeksius (kewaspadaan transmisi)	95%	100%	88%	100%	94,33%	PDSA
5.	Kejadian pelaporan tertusuk jarum ≤ 48 jam	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
6.	Kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap	79,50%	72,75%	86,09%	100%	79,45%	PDSA
7.	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standar (2/3 wadah)	97,31%	84,42%	90,91%	100%	90,88%	PDSA
8.	Kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN	56,67%	75,85%	78,54%	100%	70,35%	PDSA
9.	Kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 & DUH tubuh	11,90%	100%	16,67%	100%	42,86%	PDSA
10.	Kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi kelompok terkait PPI	50%	44,12%	50%	100%	48,04%	PDSA

30. PKRS

Tabel 3.56 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PKRS pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Angka kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi Kelompok	50,00%	55,36%	64,29%	100%	56,55%	PDSA
2.	Kepatuhan petugas dalam pengisian form edukasi kolaborasi	53,93%	86,98%	100%	100%	80,30%	PDSA
3.	Ketepatan pengisian form edukasi terintegrasi	52,50%	97,14%	58,60%	100%	69,41%	PDSA
4.	Kepatuhan staff	50%	55,36%	64,29%	100%	56,55%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	dalam menggunakan media edukasi melalui elektronik (barcode leaflet)						
5.	Kepatuhan Komunikasi efektif terkait SBAR (CPPT, HO, SBAR)	96,88%	97,67%	100%	100%	98,18%	PDSA
6.	Kepatuhan pembinaan komunitas berbasis RSPH (prognas dan geriatri)	41,67%	100%	100%	100%	80,56%	PDSA

31. ASURANSI CENTER

Tabel 3.57 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Asuransi Center pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	kepatuhan DPJP dalam penegakan diagnosa sesuai dengan ketentuan BPJS	95,03%	96,81%	97,24%	80%	96,36%	Dipertahankan
2.	kelengkapan berkas penunjang klaim pelayanan	94,81%	99,10%	99,76%	100%	97,89%	PDSA
3.	Kepatuhan petugas rawat inap terhadap penyeroran rekam medis BPJS Kesehatan < 24jam	93,09%	96,42%	95,43%	100%	94,98%	PDSA
4.	kelengkapan berkas triage E-RM pada pasien IGD	87,87%	90,12%	91,67%	100%	89,89%	PDSA
5.	Kejadian berkas pending klaim pasien BPJS	216 kejadian	188 kejadian	164 kejadian	0 kejadian	189 kejadian	PDSA

32. HUMAS & MARKETING

Tabel 3.58 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Humas & Marketing pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Kepuasan Pasien MCU	100%	0%	0%	≥ 76,61%	33,33%	PDSA Mei, Juni tidak ada pasien MCU yang scan barcode
2.	Ketidakpatuhan perbaruan dokumen kerjasama dengan instansi eksternal	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3.	Kenaikan jumlah	0,03%	0,03%	0,03%	10% / tahun	0,03%	Tahunan

	Kerjasama dengan pihak eksternal						
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

33. CSO

Tabel 3.59 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSO pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Resptime CSO <30 mnt (WA)	16,15%	12,09%	11,96%	100%	13,40%	PDSA
2.	Ketepatan perubahan jadwal dokter spesialis	-			100%		Adanya SE tentang Penyesuaian Kebijakan Sesuai HFIS Versi 6.0

34. MOD-MPP-PIPP

Tabel 3.60 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit MOD-MPP pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepuasan Pasien	97,87%	94,12%	96,30%	≥ 76,61%	96,10%	Dipertahankan
2	Respon time penanganan complain <5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu MOD-MPP-PIPP							
3	Angka kelengkapan Form A & Form B pada pasien sesuai kriteria MPP	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Angka kelengkapan form Dischard planning	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

35. TB di IRJA

Tabel 3.61 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TB pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1	Angka kepatuhan pasien mengambil obat di rumah sakit	100%	-	-	100%	-	Belum diisi
2	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penualaran ke pasien TB	100%	-	-	≥ 90%	-	Belum diisi

36. KEUANGAN

Tabel 3.62 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keuangan pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1	Persentase selisih uang setoran kasir dengan LHK (Laporan harian kasir)	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2	Angka keterlambatan pelayanan kasir saat pelayanan >10 menit	0%	0%	0%	<5%	0%	Dipertahankan
3	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	0%	0%	0%	100%	0%	Dipertahankan
4	Jumlah piutang ≥ 60 hari				0%		Belum ada capaian

37. TIM HIV

Tabel 3.63 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TIM HIV pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penularan ke pasien HIV	100%	0%	0%	≥ 90%	33,33 %	PDSA

38. KB

Tabel 3.64 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit KB pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Kepatuhan pengisian kartu K4 KB	100%	100%	88,96%	100%	96,32%	PDSA
2.	Angka terlaksannya program KB pasca persalinan & pasca keguguran	69,15%	7,20%	16,06%	50%	30,80%	PDSA
3.	Semua ibu melahirkan dan curretage mendapatkan KIE KB	100%	100%	96,35%	100%	98,78%	PDSA
4.	Angka pelaksanaan pelayanan konseling KB bagi calon peserta dan peserta program KB	97,26%	100%	88,96%	30%	95,41%	Dipertahankan

39. STUNTING

Tabel 3.65 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Stunting pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada balita	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan petugas melakukan KIE	0%	0%	100%	100%	33%	PDSA

	kelompok pada ibu balita 1x dalam sebulan						
3.	Kepatuhan Pembinaan jejaring pengelolaan gizi pasien stunting dan wasting tiap 3bulan sekali				100%		Triwulanan
4.	Kepatuhan pencatatan pelaporan sesuai waktu yang ditentukan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

40. IT - SIM RS

Tabel 3.66 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit IT – SIM RS pada Triwulan II Tahun 2025

No .	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Kepatuhan petugas dalam memonitoring jaringan sebulan 1 kali	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Waktu tanggap penanganan internet dan billing error < 10 mnt	100%	100%	66,67%	100%	91,67 %	PDSA
3.	Waktu tanggap untuk penanganan computer < 10 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pemeliharaan computer dan perlengkapannya 1 bulan sekali	37,50%	11,54%	58,54%	100%	51,90 %	PDSA

3.6.2 Komite PPI

3.6.2.1 Kewaspadaan Standar

a. Kewaspadaan Standart

NO	INDIKATOR PENILAIAN	STANDART	BULAN												RATA-RATA
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PENYUNTIKAN YANG AMAN	80,00%	89,30%	86,50%											89,30%
2	PENYIMPANAN DAN TRANSPORTASI VAKSIN	80,00%	100,00%	94,44%											100,00%
3	PENGELOLAAN STERILISASI DAN BMHP	80,00%	97,24%	92,72%											97,24%
4	PENGELOLAAN LINEN/LAUNDRY	80,00%	96,43%	88,31%											96,43%
5	PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS RS	80,00%	100,00%	94,05%											100,00%
6	PENANGANAN SPESIMEN DARAH DAN CAIRAN TUBUH LAIN	80,00%	90,48%	100%											90,48%
7	PENANGANAN TUMPAHAN DARAH DAN CAIRAN TUBUH	80,00%	91,09%	85,96%											91,09%
8	PENANGANAN DAN PENGIRIMAN SAMPAH DI RUANGAN	80,00%	93,33%	95,36%											93,33%
9	PEMBUANGAN BENDA TAJAM	80,00%	72,77%	72,08%											72,77%
10	PELAYANAN MAKANAN	80,00%	75,00%	90,83%											75,00%
11	LINGKUNGAN RUMAH SAKIT	80,00%	33,70%	63,31%											33,70%
12	KETERSEDIAAN DAN KESESUAIAN APD DI UNIT	80,00%	96,45%	91,42%											96,45%
13	KAMAR JENAZAH	80,00%	87,50%	91,43%											87,50%

14	FASILITAS KEBERSIHAN TANGAN	80,00%	96,59%	95,83%											96,59%
15	DEKONTAMINASI MOBIL AMBULAN	80,00%	95,00%	90%											95,00%
16	ETIKA BATUK	80,00%	98,61%	99,16%											98,61%
17	KELENGKAPAN PENGISIAN DATA PPI	80,00%	47,08%	58,53%											47,08%

b. Kewaspadaan Isolasi

NO	INDIKATOR PENILAIAN	STANDART	BULAN												RATA-RATA
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PENEMPATAN PASIEN INFEKSI AIRBONE DALAM WAKTU SINGKAT	80,00%													#DIV/0!
2	PENEMPATAN PASIEN IMMUNOCOMPROMISED	80,00%	62,50%	58,33%											62,50%
3	PENEMPATAN DAN TRANSFER INFEKSI PASIEN AIRBONE	80,00%	63,49%	73,15%											63,49%

3.3.1 Audit Bundle HAI's PPI

NO	INDIKATOR PENILAIAN	STANDART	BULAN												RATA- RATA
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	CAUTI		0%	0%											0,00%
2	CLABSI		0%	0%											0,00%
3	VAP		0%	0%											0,00%
4	PLEBITIS & PLABSI		1,39%	1,14%											1,39%
5	IDO		0%	0,89%											0,00%
6	DEKUBITUS		0%	0%											0,00%

NO	INDIKATOR PENILAIAN	KET	BULAN												RATA- RATA
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	CAUTI (ISK)	HARI PEMAKAIAN	62	142											62
2	CLABSI (CVC)		11	10											11
3	VAP		41	13											41
4	IDO	JUMLAH PASIEN OP DALAM PERIODE TERTENTU (BULAN)													
	SC		81	63											81
	ORIF		25	40											25
	APENDICTOMI		12	9											12
	HERNIOTOMI		25	22											25
	KATARAK		31	33											31
	CABG		0	0											0
	TU MAMAE		20	30											20
	LAPAROTOMI		26	37											26

3.3.2 Mutu PPI

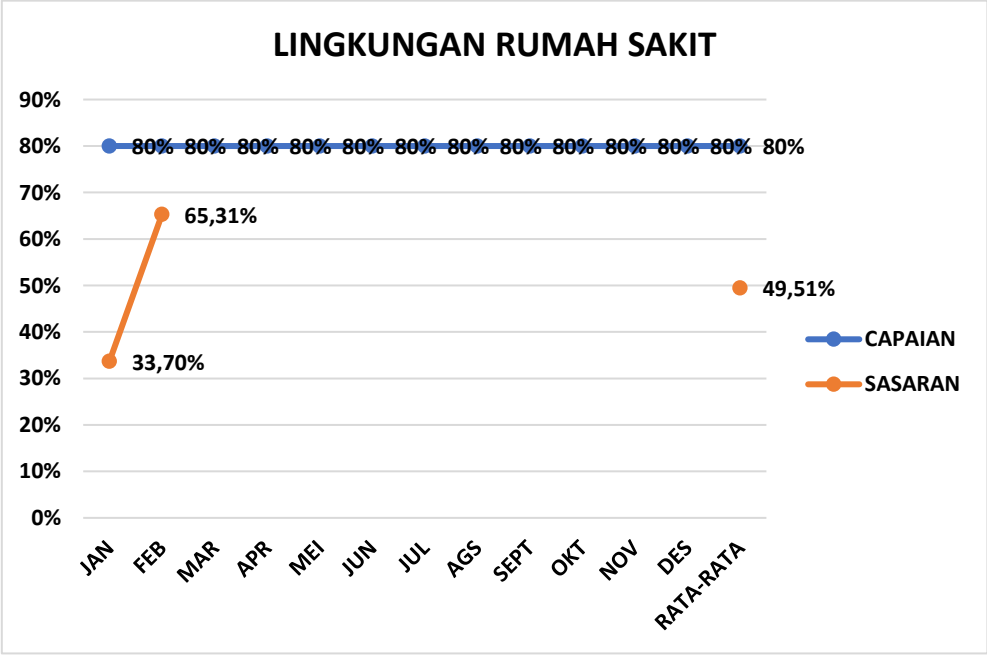
NO	INDIKATOR PENILAIAN	STANDART	BULAN												RATA-RATA
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Tersedia APD di setiap instalasi/departemen	60%	62%	82,75%											61,60%
2	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI's (Health care Associated Infection) di RS	75%	3,55%	1,07%											3,55%
3	Kepatuhan kebersihan tangan	>85%	74,75%	77,24%											74,75%
4	Kepatuhan APD	100%	89,64%	89,87%											89,64%
5	Angka infeksi daerah operasi	<1.5%	0%	0,89%											0,00%
6	Kepatuhan penempatan pasien infeksius (kewaspadaan transmisi)	100%	52,46%	87,50%											52,46%
7	Kejadian pelaporan tertusuk jarum <48 jam	0 kejadian	0	0											0
8	Kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap	100%	55,24%	63,69%											55,24%
9	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standar (2/3 wadah)	100%	87,10%	83%											87,10%
10	Kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN	100%	47,13%	58,53%											47,13%
11	Kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh	100%	1,24%	1,37%											1,24%
12	Edukasi kelompok terkait PPI	100%	27,28%	47,22%											27,28%

1.1.1 Monitoring Kewaspadaan Isolasi

a. Kewaspadaan Standart

a) Lingkungan Rumah Sakit

Gambar 4.1.1.1 Lingkungan Rumah Sakit



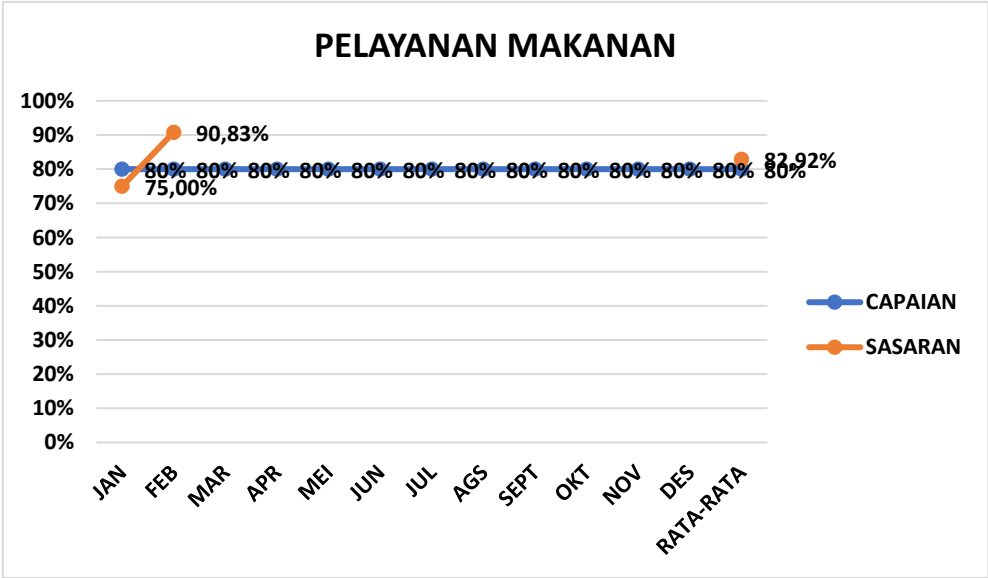
Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.1 diketahui bahwa rerata lingkungan rumah sakit di bulan Februari 2025 sebesar 65.31% dan belum mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.1 Lingkungan Rumah Sakit

PROBLEM	Persentasi kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan belum mencapai 100%.
STEP	Memonitor berkelanjutan dalam mempertahankan atau meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pengendalian infeksi lingkungan di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan. b. Meningkatkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang pengendalian infeksi lingkungan di unit. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit.
DO	Kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan mencapai 100%
STUDY	1. Rerata kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan bulan Februari tahun 2025 yaitu sebesar 65,31% belum mencapai sasaran 80%. 2. Staff belum cukup baik dalam melakukan pengendalian kebersihan lingkungan. 3. Masih ditemukan beberapa area perawatan yang berdebu, kotor, dan tidak rapi serta ruangan perawatan bau tidak enak 4. CS kurang detail dalam pembersihan sehingga saat disupervisi ditemukan area bed dan nakas tampak kotor, lantai masih banyak rambutnya, dan lantai lengket 5. Masih ditemukan troli tindakan yang terdapat bercak noda darah 6. Masih ditemukan tirai/gorden di ruang perawatan yang kotor, berdebu dan di lipat diatas bed serta di ikat mati 7. Masih ditemukan linen infeksius yang terletak dilantai 8. Masih ditemukan area kamar pasien atau kamar mandi pasien yang masih kotor dan berbau
ACTION	1. Kolaborasi dengan tim umum terkait pengadaan sumber daya pembersihan lingkungan dengan baik sesuai dengan standart 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Beri teguran saat melakukan monitoring pengendalian infeksi lingkungan di unit. 4. Monitoring pembersihan dan disinfeksi permukaan lingkungan yang berisiko tinggi

b) Pelayanan Makanan

Gambar 4.1.1.2 Pelayanan Makanan



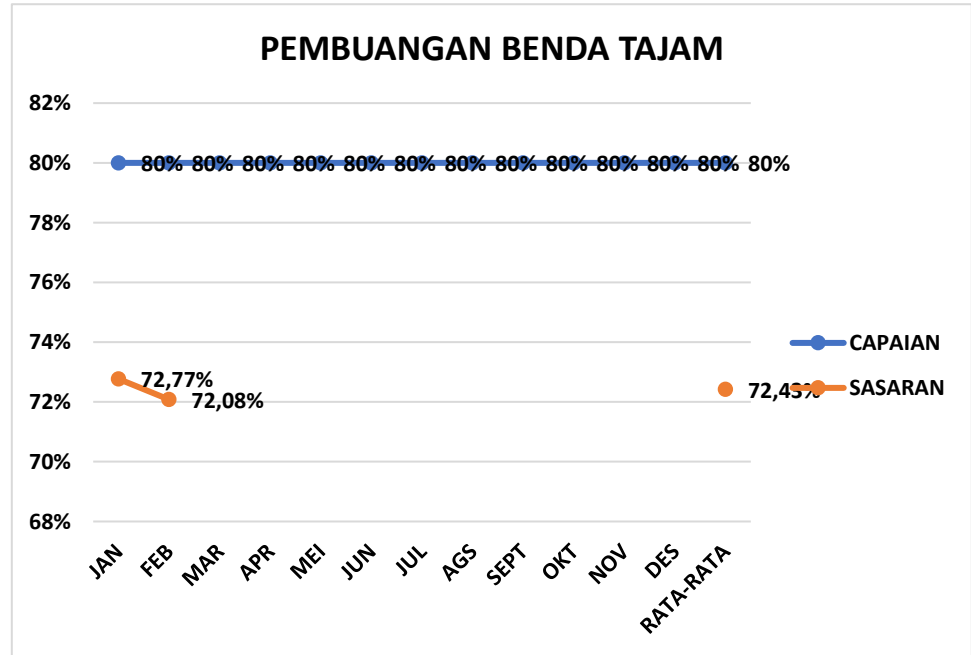
Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.2 diketahui bahwa rerata pelayanan makanan di bulan Februari 2025 sebesar 90,83% dan sudah mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.2 Pelayanan Makanan

PLAN	Meningkatkan kepatuhan pelayanan makanan di rumah sakit hingga mencapai target 100%.
DO	1. Monitoring kepatuhan pelayanan makanan menggunakan form supervisi 2. Audit kebersihan tangan dan penggunaan APD menggunakan form audit
STUDY	1. Rerata kepatuhan pelayanan makanan bulan Februari tahun 2025 adalah 82,92%. 2. Masih ditemukan petugas yang tidak menggunakan APD sesuai standart 3. Ditemukan staff dapur tidak melakukan cuci tangan sebelum melakukan penyiapan makanan, 4. Ditemukan makanan yang sudah masak, tidak ditutup. 5. Ditemukan hewan rodent di area dapur belakang
ACTION	1. Beri <i>feedback</i> hasil temuan 2. Koordinasi dengan CS <i>pantry</i> terkait kebersihan ruang dapur dan gizi 3. Monitoring kebersihan tangan dan penggunaan APD di dapur melalui supervise dan lembar audit

c) Pembuangan Benda Tajam

Gambar 4.1.1.3 Pembuangan Benda Tajam



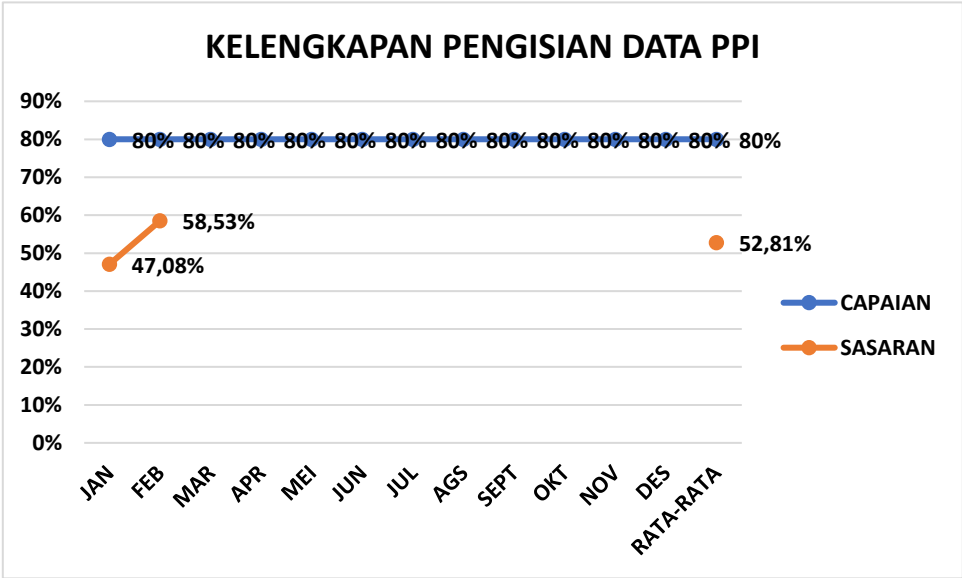
Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.3 diketahui bahwa rerata pembuangan benda tajam di bulan Februari 2025 sebesar 72,08% dan belum mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.3 Pembuangan Benda Tajam

PROBLEM	Persentase kepatuhan pembuangan limbah benda tajam belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pembuangan jarum dan benda tajam untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertusuk jarum pada petugas.
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pembuangan sampah jarum dan benda tajam di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit pembuangan jarum dan benda tajam di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang pembuangan jarum dan benda tajam di unit. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam di unit.
DO	Kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam meningkat hingga mencapai 100%
STUDY	1. Rerata kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam bulan Februari tahun 2025 yaitu sebesar 72,02%, 2. Ditemukan <i>safety box</i> yang tidak segera dibuang saat $\frac{3}{4}$ penuh 3. Ditemukan <i>safety box</i> tidak menggantung di unit pelayanan IRNA 3A (Ruang Obat)
ACTION	1. Review kepada staf terkait pembuangan jarum dan benda tajam. 2. Lakukan <i>supervise</i> terhadap jumlah stok <i>safety box</i> di area pelayanan yang ditunjukkan dengan bukti <i>spreedshet</i> jumlah kebutuhan dan jumlah pemakaian di all lantai 3. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 4. Beri teguran saat melakukan monitoring pembuangan jarum dan benda tajam di unit.

d) Kelengkapan Penginputan Data Surveilans

Gambar 4.1.1.4 Kelengkapan Penginputan Data Surveilans



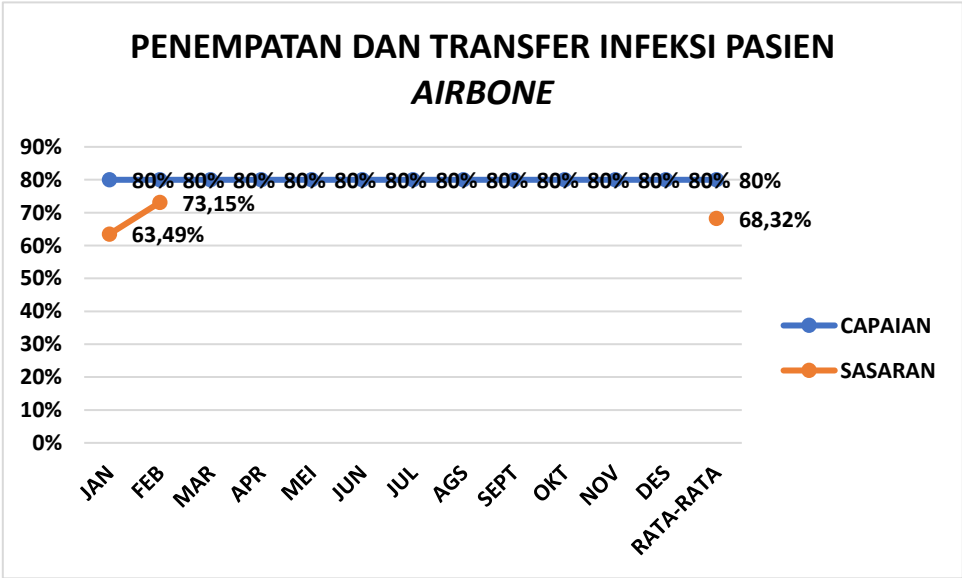
Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.4 diketahui bahwa rerata kelengkapan penginputan data surveilans di bulan Februari 2025 sebesar 58,53% dan belum mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.4 Kelengkapan Penginputan Data Surveilans

PROBLEM	Persentase kelengkapan penginputan data surveilans bulan Februari tahun 2025 sebesar 58,53% dan belum memenuhi target 80%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pelaporan dan penginputan hasil serta temuan di unit terkait surveilans HAI's dan monitoring kewaspadaan isolasi.
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh IPCLN dan PIC PPI unit melakukan penginputan data surveilans secara <i>real time</i> dan <i>ontime</i> sehingga target kepatuhan dapat tercapai. 3. Tindakan a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh IPCLN dan PIC PPI terhadap pelaporan melalui web PPI https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo b. Berkolaborasi dengan kepala ruang, kepala bidan dan SDM terkait kepatuhan IPCLN dan PIC PPI dalam melakukan kepatuhan penginputan data surveilans dan monitoring kewaspadaan isolasi.
DO	Kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans belum mencapai target 80%.
STUDY	1. Rerata kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans di tahun 2025 di bulan Februari 2025 sebesar 52,81% dan belum memenuhi standart. 2. Unit dengan kelengkapan penginputan data surveilans secara <i>on time</i> dan <i>real time</i> dari unit Maternitas, IRNA 2A, dan Neonatologi 3. Ketidakepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans disebabkan adanya, a. Staff IPCLN dan PIC PPI bertambah dan adanya perubahan formasi setelah adanya perotasian b. Banyaknya jumlah kunjungan yang mengakibatkan IPCLN / PIC PPI tidak melakukan penginputan data
ACTION	1. Lakukan evaluasi pengisian form PPI by web setiap bulan 2. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kelengkapan data yang telah di isi dengan melibatkan Karu dan Kabid terkait. 3. Lakukan sosialisasi dan edukasi ulang kepada PIC PPI yang belum faham 4. Buatkan SPO pengisian data surveilans dan monitoring kewaspadaan isolasi 5. Lakukan audit per unit dengan identifikasi dan berikan award pada unit dengan tingkat kepatuhan tinggi dalam pelaporan 6. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 7. Berikan teguran pada IPCLN dan PIC PPI yang tidak patuh dalam melakukan pelaporan

- b. Kewaspadaan Transmisi
- a) Penempatan dan Transfer Infeksi Pasien *Airbone*

Gambar 4.1.1.5 Penempatan dan Transfer Infeksi Pasien *Airbone*



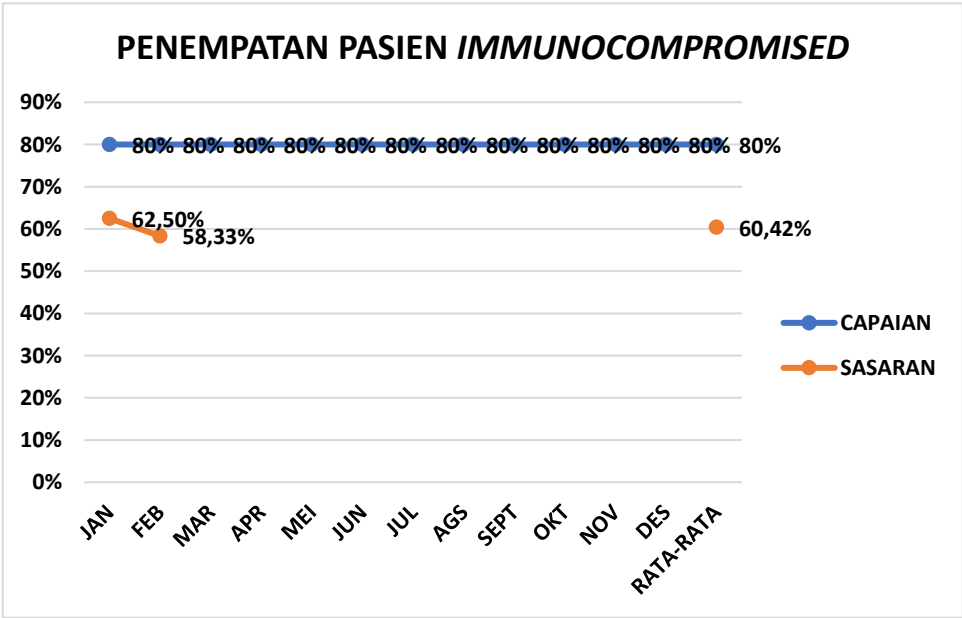
Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.5 diketahui bahwa rerata penempatan dan transfer infeksi pasien *airbone* di bulan Februari 2025 sebesar 73,15% dan belum mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.5 Penempatan dan Transfer Infeksi Pasien *Airbone*

PROBLEM	Persentase kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan dalam penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i>
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.
DO	Kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> belum mencapai 80%
STUDY	1. Rerata kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> bulan Februari tahun 2025 yaitu sebesar 68,32%, 2. Masih ditemukan kurangnya edukasi penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> kepada pasien sehingga sering keluar masuk pengunjung yang tidak menggunakan masker, tidak menutup pintu kembali 3. Masih ditemukan pengunjung keluar masuk ke dalam ruang isolasi, 4. Ditemukan beberapa rekam medis tidak tertulis edukasi pasien dan keluarga terkait tata tertib ruang isolasi, 5. Ditemukan staff IRNA 2A tidak menggunakan APD yang sesuai seperti masker N95 6. Ditemukan pasien TB yang di tempatkan di ruang perawatan Anggrek 3A di karenakan keluarga APS perawatan di ruang VIP

ACTION	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i>. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu IRNA 2A untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi 3. Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video) 4. Aktivkan CCTV diarea R. Isolasi dan lakukan kolaborasi dengan satpam RS untuk penertiban pengunjung di area ruang Isolasi, 5. Lakukan sosialisasi 6. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan, 7. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> dengan tepat
--------	--

b) Penempatan Pasien *Immunocomprised*
Gambar 4.1.1.6 Penempatan Pasien *Immunocomprised*



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.6 diketahui bahwa rerata kepatuhan penempatan pasien *immunocomprised* di bulan Februari 2025 sebesar 58,33% dan belum mencapai standart 80%.

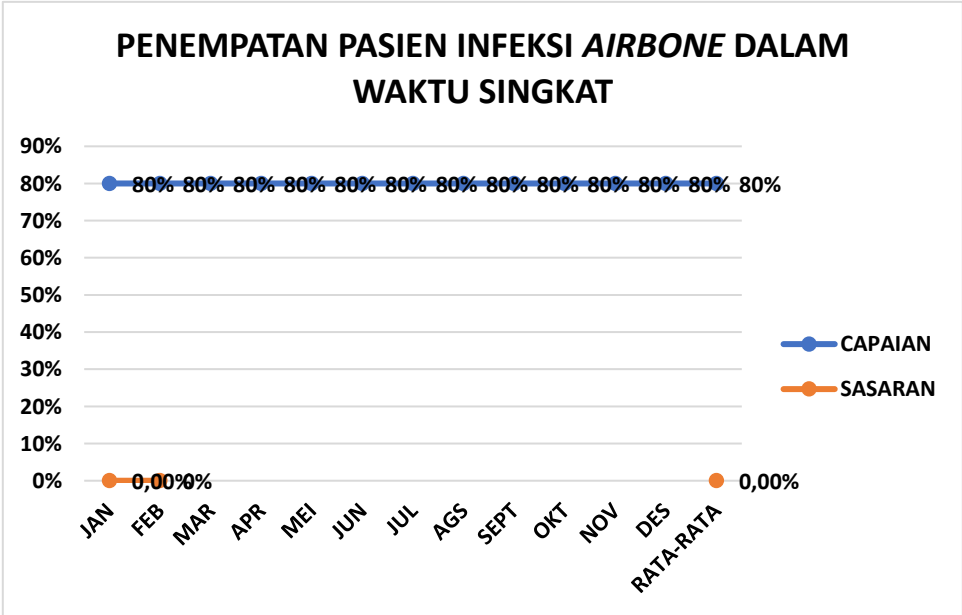
Tabel 4.1.1.5 Penempatan Pasien *Immunocomprised*

PROBLEM	Persentase kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i> .
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.
DO	Kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> belum mencapai 80%
STUDY	1. Rerata kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> bulan Januari tahun 2025 yaitu sebesar 60,42%, 2. Masih ditemukan kurangnya edukasi penempatan pasien <i>immunocomprised</i> kepada pasien dan keluarga sehingga sering keluar masuk pengunjung yang tidak menggunakan masker, 3. Terdapat penurunan penggunaan ruang <i>immunocomprised</i> pada pasien non infeksius.

ACTION	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i>. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu IRNA 2A untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi 3. Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video) 4. Aktivkan CCTV diarea R. Isolasi dan lakukan kolaborasi dengan satpam RS 5. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 6. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i>
--------	--

c) Penempatan Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat

Gambar 4.1.1.7 Penempatan Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.7 diketahui bahwa rerata kepatuhan penempatan pasien infeksi *airbone* dalam waktu singkat di bulan Februari 2025 sebesar 0% dan belum mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.7 Penempatan Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat

PROBLEM	Persentase kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit IGD dan rawat inap mengenai pentingnya kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i>
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit secara berkesinambungan. 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit secara berkesinambungan, b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat, c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.
DO	Kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat belum mencapai 80%.
STUDY	1. Rerata kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat bulan Februari tahun 2025 yaitu sebesar 0%, 2. Ditemukan data sebesar 0% dikarenakan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat tidak adapat terukur secara <i>real time</i>

ACTION	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu IGD untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi 3. Lakukan audit secara berkesinambungan Bersama IPCLN IGD 4. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 5. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat.
---------------	--

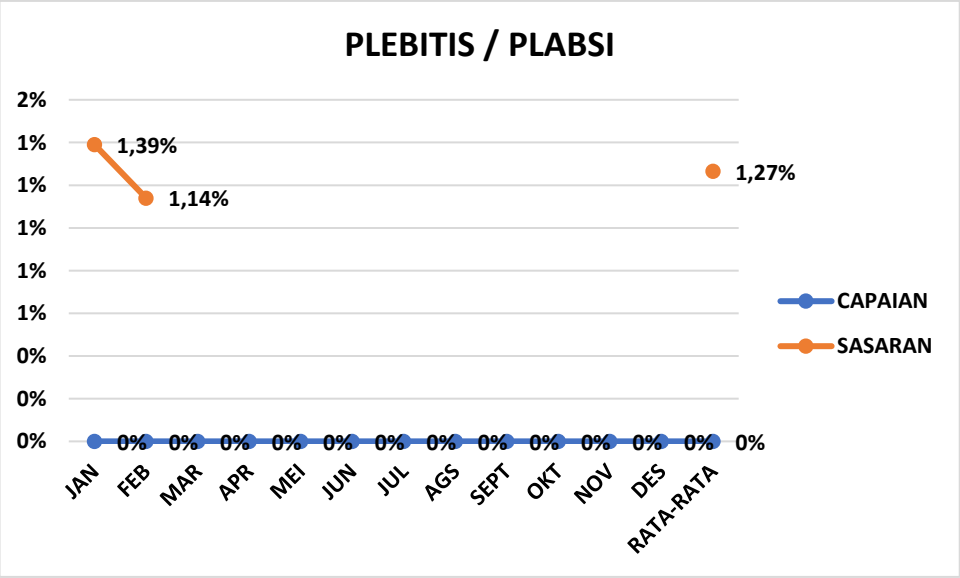
1.1.2

Audit *Bundle* HAI's PPI

a.

Bundle Phlebitis

Gambar 4.1.2.1 Phlebitis



Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.1 diketahui bahwa rerata kejadian phlebitis di bulan Februari 2025 sebesar 1,14% dan belum mencapai standart 0%.

Tabel 4.1.2.1 Phlebitis

No	Bulan	Unit	Jumlah Phlebitis
1	Januari	IRNA 3A	11
		IRNA 3B	3
		IRNA 2A	4
		IRNA 2B	2
		MATERNITAS	0
		NEONATOLOGI	0
		ICU	0
2	Februari	IRNA 3A	0
		IRNA 3B	3
		IRNA 2A	7
		IRNA 2B	6
		MATERNITAS	0
		NEONATOLOGI	1
		ICU	0
TOTAL			17

Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.1 diketahui kejadian plebitis terbanyak di unit IRNA 2A sebesar 7 kejadian dengan rincian semua pasien dewasa.

Tabel 4.1.2.2 PDSA Phlebitis

PLAN	1. Melaksanakan <i>bundles phlebitis</i> sesuai SPO 2. Monitoring dan evaluasi oleh IPCLN 3. Supervisi oleh IPCN
DO	1. Surveilans phlebitis dilakukan menggunakan form <i>surveilans</i> 2. Monitoring kepatuhan <i>bundles</i> dilakukan menggunakan <i>google form</i>
STUDY	1. Rata-rata kejadian phlebitis pada bulan Februari 2025 sebesar 1,14%. 2. Jumlah kejadian phlebitis terbanyak pada bulan Februari 2025 terjadi pada unit IRNA 2A 3. Ketidakpatuhan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan dan teknik aseptik yang tidak tepat menjadi penyebab rendahnya kepatuhan <i>bundles insersi</i> phlebitis. 4. Kenaikan kasus phlebitis dikarenakan meningkatnya proses perawatan luka infus oleh petugas dan dari sisi internal pasien sendiri yang menjaga agar lokasi infus tidak bengkak. 5. Risiko pembengkakan area insersi meningkat karena semakin tingginya penggunaan obat seperti furosemid, dobutamin, dan nicarpidin yang dimasukkan ketubuh pasien melalui syringe pump serta kondisi fisik pasien (ada penyakit penyerta seperti DM, gagal jantung dll). 6. Jumlah phlebitis rata-rata bulan Februari terjadi pada kasus dewasa dengan <i>case</i>, a. Jumlah perawatan yang memanjang b. Penggunaan obat-obatan pekat (KCL, Manitol, penggunaan obat deuretik, dll)
ACTION	1. Lakukan sosialisasi kepada perawat tentang <i>bundles insersi</i> dan <i>maintenance phlebitis</i>. 2. Koordinasi dengan komite keperawatan untuk melakukan pelatihan pemasangan infus serta prosedur perawatan luka infus. 3. Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap <i>bundles phlebitis</i> 4. Berikan <i>feed back</i> terhadap temuan

3.6.3 Tim PKRS

Tabel Kinerja Produktifitas PKRS Tahun 2025

No	Hal	Target	Januari	% bulan sebelumnya	Ket
	Produksi Leaflet baru	2x/bln	1 buah	$(1/2) \times 100\% = 50\%$ ↓50%	Ditingkatkan
	Produksi Poster/Flyer	4x/bln	6 buah	$(4/4) \times 100\% = 100\%$ ↑100%	Pertahankan
	Pembuatan Video	1x/bln	1 buah	$(4/1) \times 100\% = 400\%$ ↑400%	Pertahankan
	Pembuatan Podcast/ Audio edukasi	2x/bln	-	$(1/2) \times 100\% = 100\%$ ↑100%	Meningkat
	KIE Massa Radio Central	25x/bln tiap hari	2x putar	$(1/25) \times 100\% = 4\%$ ↓4%	Kurang 96% Rekaman Diinventaris jika punya 10 macam audio. Di putar setiap hari dan diulang berkali-kali. Buat audio materi Prognas : 5
	KIE WAG Komunitas	25x/bln tiap hari	4	$(2/25) \times 100\% = 8\%$ ↓ 8 %	Ditingkatkan
	Edukasi di sosmed (IG, FB)	25x/bln tiap hari	6	$(4/25) \times 100\% = 16\%$ ↓ 16 %	Ditingkatkan Buat metode baru : jadwalkan untuk edukasi live di IG
	Pemberdayaan Komunitas (F-KUL)	4x/bln	5	$(4/4) \times 100\% = 100\%$ ↑ 100%	Pertahankan
	Pemberdayaan Komunitas (DOLINA)	2x/bln	2	$(1/2) \times 100\% = 50\%$ ↓ 50%	Pertahankan

Analisis :

1. Pembuatan podcast pada bulan januari belum terlaksana.
2. Edukasi di sosmed hanya dilakukan dengan memposting poster belum terlaksana live Instagram.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Buat jadwal bulanan terkait program podcast dan pembuatan video, audio edukasi (Jadwalkan tiap DPJP wajib mengisi 1 menit edukasi sesuai PHBK poli)
2. Lakukan koordinasi dengan kepala ruang dan pic PKRS unit untuk menjadwalkan edukasi melalui sosmed dan edukasi langsung menggunakan audio central. (tiap unit diminta untuk membuat rekaman edukasi)
3. Evaluasi tim dolina dan menjadwalkan lagi petugas, agar aktif ikut serta dalam pelaksanaan dolina

Tabel Hasil Kinerja KIE Kelompok tiap Unit di RSPHS pada Bulan April Tahun 2025

No	Unit	Target	Jan	Mandok	Ket
1.	IRNA 2A	8x/bln	2x	<u>Lampiran B</u>	Kurang dari Target
2.	IRNA 2B	8x/bln	4x	<u>Lampiran B</u>	Kurang dari Target
3.	IRNA 3A	8x/bln	10x	<u>Lampiran B</u>	Melampaui Target
4.	IRNA 3B	8x/bln	4x	<u>Lampiran B</u>	Kurang dari target
5.	ICU	8x/bln	9x	<u>Lampiran B</u>	Melampaui Target
6.	MATERNITAS	8x/bln	9x	<u>Lampiran B</u>	Melampaui Target
7.	PERINATOLOGI	8x/bln	3x	<u>Lampiran B</u>	Kurang dari target
8.	IRJA	8x/bln	-	-	-
9.	IGD	8x/bln	6x	<u>Lampiran B</u>	Kurang dari Target
10.	GIZI	8x/bln	1x	<u>Lampiran B</u>	Kurang dari target
11.	LABORATORIUM	8x/bln	-	-	-
12.	RADIOLOGI	8x/bln	-	-	-
13.	FARMASI	8x/bln	-	-	-
14.	IKO	8x/bln	1x	<u>Lampiran B</u>	Kurang dari target

Analisis :

Petugas cenderung tidak melaksanakan edukasi sesuai target, hanya beberapa unit yang melaksanakan sesuai target.

Rencana Tindak Lanjut :

- Beri feedback dan followup petugas
- Menindaklanjuti karu dan pic pkrs yang bertugas
- Menjadwalkan tiap minggu edukasi
- Membuatkan jenjang peringkat agar petugas lebih semangat lagi untuk edukasi
- Catat nama petugas/ unit yang tidak patuh dalam melakukan edukasi.
- Lapor kabid agar di followup ke karu, apabila belum ada perubahan

3.6.4 Tim Prognas

3.6.4.1 PONEK

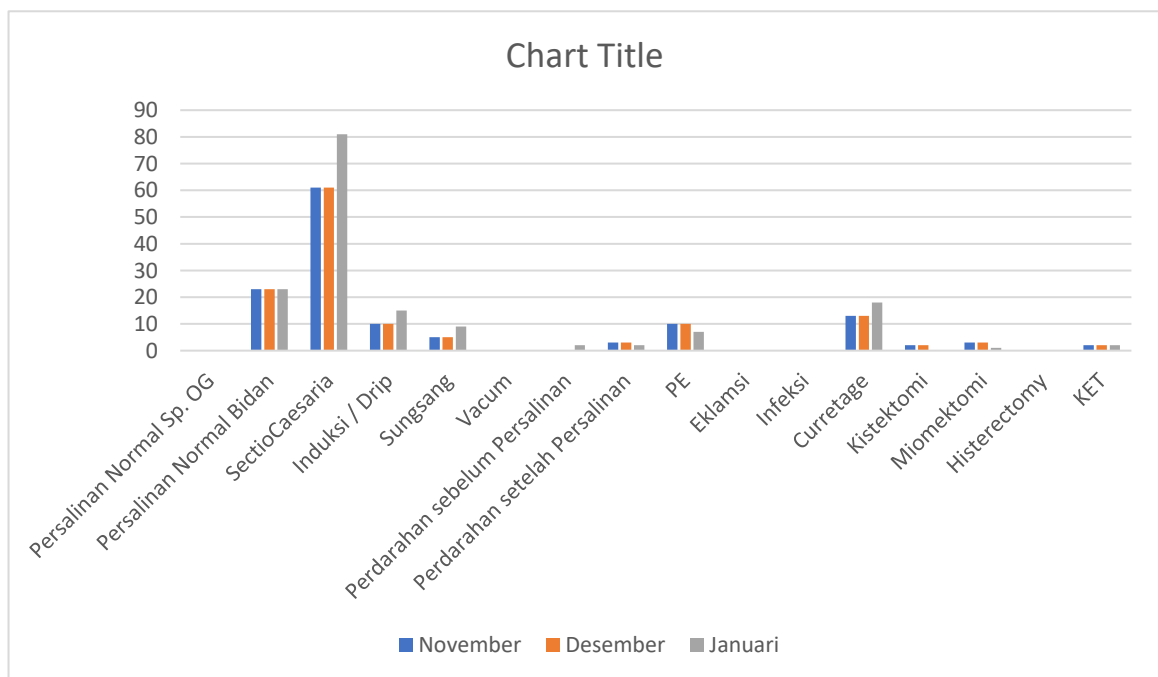
A. Kegiatan Pelayanan Maternal

Tabel Kegiatan Pelayanan Maternal

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		November 2024	Desember 2024	Januari 2025
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal Sp. OG	0	0	0
	b. Persalinan Normal Bidan	23	26	23
	c. <i>SectioCaesaria</i>	61	65	81
2	Persalinan dengan tindakan			
	a. Induksi / Drip	10	10	15

	b. Sungsang	5	5	9
	c. Vacum	0	0	0
3	Persalinan dengan Komplikasi			
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	0	2
	b. Perdarahan setelah Persalinan	3	0	2
	c. PE	10	9	7
	e. Eklamsi	0	0	0
	f. Infeksi	0	0	0
4	Kebidanan :			
	a. Curretage	13	13	18
	b. Kistektomi	2	1	0
	c. Miomektomi	3	2	1
	d. Histerectomy	0	0	0
	e. KET	2	2	2

GRAFIK 1
JUMLAH KEGIATAN PELAYANAN MATERNAL DI RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA BULAN JANUARI 2025



Evaluasi :

1. Persalinan normal dengan Sp.Og untuk bulan januari tidak ada sama sekali
2. Untuk jumlah persalinan dengan bidan bulan ini turun dari bulan sebelumnya dikarenakan jumlah persalinan bulan ini naik di Tindakan SC
3. Untuk kasus persalinan sc dalam bulan ini naik dari bulan kemarin, karena rujukan emergency dari IGD dan lodingan dari poli juga naik
4. Persalinan dengan induksi untuk bulan ini jumlahnya naik dengan bulan kemarin . Untuk induksi sendiri di berikan kalau benar-benar ada indikasi yang sesuai dengan

- kriteri dilakukan induksi supaya pasiennya aman
- Kasus persalinan sungsang bulan ini naik dengan bulan kemarin, dan rata-rata adalah pasien dari rujukan.
 - Tidak ada kasus persalinan dengan tindakan vacuum
 - Kasus perdarahan sebelum persalinan untuk bulan naik dari bulan sebelumnya dan itu pasien dari IGD
 - Kasus perdarahan setelah melahirkan pada bulan ini naik dari bulan sebelumnya di karenakan pasien dengan PEB dan plasenta letak renda
 - Pasien dengan Preeklampsia bulan ini turun dengan bulan sebelumnya dan kebanyakan pasien rujukan dari bidan atau klinik.
 - Infeksi pada bulan ini tidak ada.
 - Tindakan curretage bulan ini lebih banyak dari bulan sebelumnya dengan diagnose terbanyak AUB
 - Tindakan miomektomi pada bulan ini turun dari bulan sebelumnya
 - Tindakan kistektomi pada bulan ini tidak ada sama sekali.
 - Kasus histerektomi untuk bulan ini tidak ada
 - Kasus KET pada bulan ini sama dengan bulan sebelumnya

Rencana dan Tindak Lanjut:

- Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit untuk melakukan promosi dan mengenalkan dokter-dokter obgyn yang ada di prima husada sukorejo
- Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya kehamilan di trimester 1, 2 dan 3 kehamilan.
- Mengadakan kelas ibu hamil dan memberi materi dan edukasi terkait kehamilan dan persalinan

2. Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN NOVEMBER 2024	BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2024
1	Jumlah pasien neonatal			
	d. Level 1	85	80	95
	e. Level II A	9	10	13
	f. Level II B	0	0	0
2	Bayi Lahir Hidup			
	c. ≥ 2500 gram	86	69	86
	d. ≤ 2500 gram	8	21	22
3	Kematian neonatal			
	c. Kelahiran Mati	0	2	0
	d. Mati Neonatal < 7 Hari	0	0	1
4	Sebab Kematian Neonatal			
	a. Asphyxia	0	0	0
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	0	0	0
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	0	0	0
	f. ISPA	0	0	0

	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

GRAFIK 2



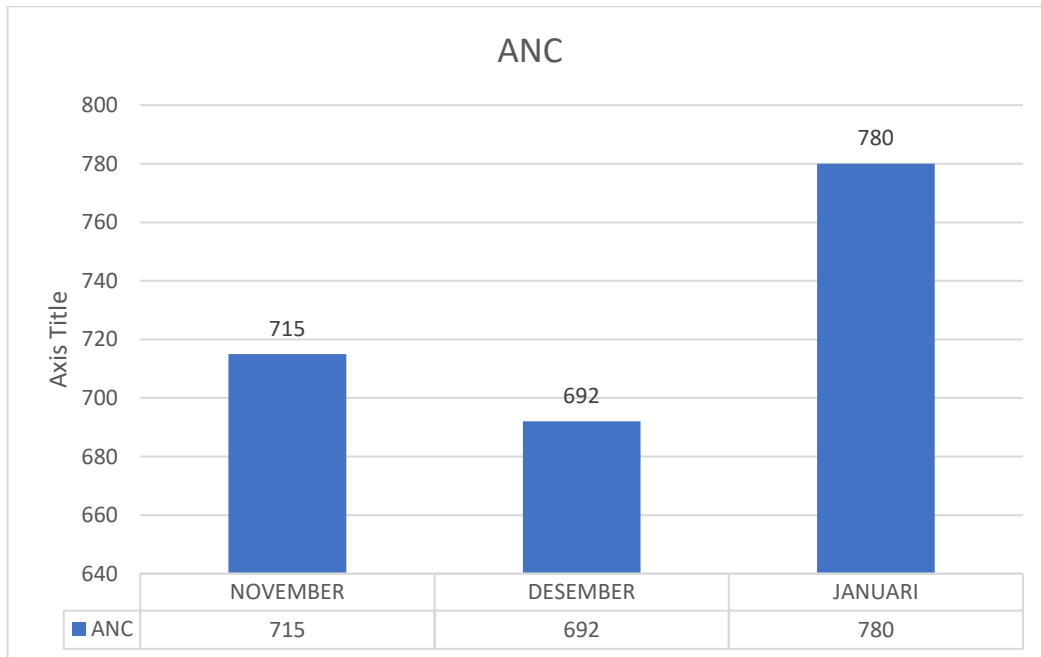
Evaluasi

1. Untuk perawatan bayi level 1 bulan ini naik dari bulan sebelumnya karena jumlah persalinan bulan ini juga mengalami kenaikan juga
2. Perawatan bayi level II A naik dari bulan sebelumnya dan bayi hanya membutuhkan incubator saja. Hal ini dikarenakan rata-rata bayi sehat dan Sebagian besar rawat gabung.
3. Perawatan bayi level II B tidak ada
4. Terdapat kenaikan jumlah bayi dengan BB lebih dari 2500 karena banyak bayi yang lahir dengan keadaan yang sehat
5. Untuk bulan ini jumlah bayi lahir hidup dengan berat badan ≤ 2500 gram jumlahnya naik dari bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus partus prematurus imminens (PPI) pada ibu hamil dan ada dengan gemeli 2 pasien.
6. Untuk kelahiran mati bulan ini tidak ada kasus
7. Untuk kematian neonatal < 7 hari pada bulan ini ada 1 kasus dengan pasien tiba-tiba datang ke IGD dengan kehamilan gemelli dan keadaan janin sudah fetal distress, jadi yang 1 meninggal dan yg satunya hidup.
8. Bayi yang meninggal dengan sebab lain untuk bulan ini tidak ada.

Rencana dan Tindak Lanjut

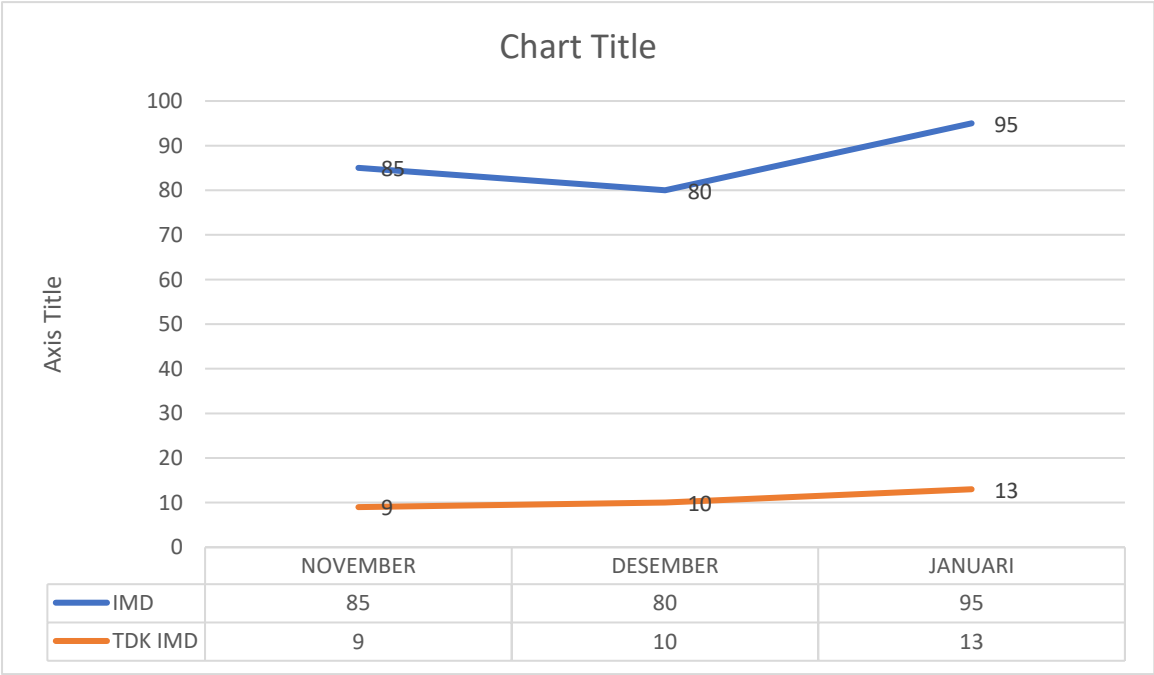
1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi dan persiapan persalinan agar tidak terjadi infeksi neonatus karena ketuban mekonial.

No	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1	ANC	715	692	780



NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1	IMD	85	80	95
2	Tidak IMD	9	10	13

GRAFIK 4
JUMLAH PELAYANAN INISIASI MENYUSU DINI (IMD) DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
BULAN JANUARI 2025



Evaluasi

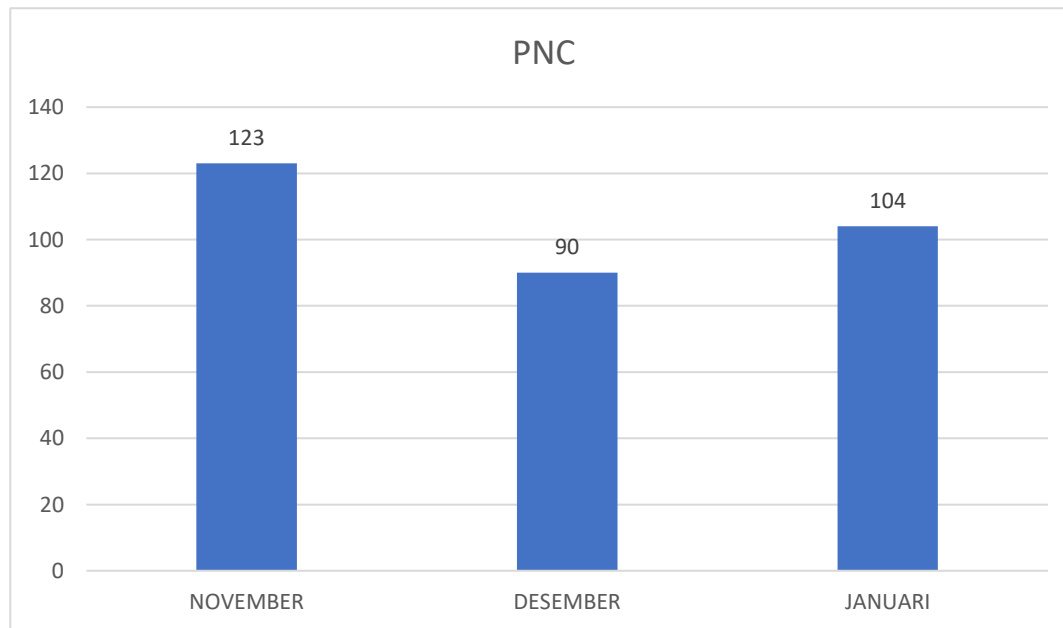
1. Dalam pelayanan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) untuk bulan ini naik dari bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan naiknya jumlah kelahiran bayi sehat di rumah sakit prima husada Sukorejo yang memungkinkan untuk dilakukan IMD.
2. Untuk tidakan IMD bulan ini naik sedikit dengan bulan kemarin. Hal ini dikarenakan bayi tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD atau bayi sakit.

Rencana dan Tindak Lanjut

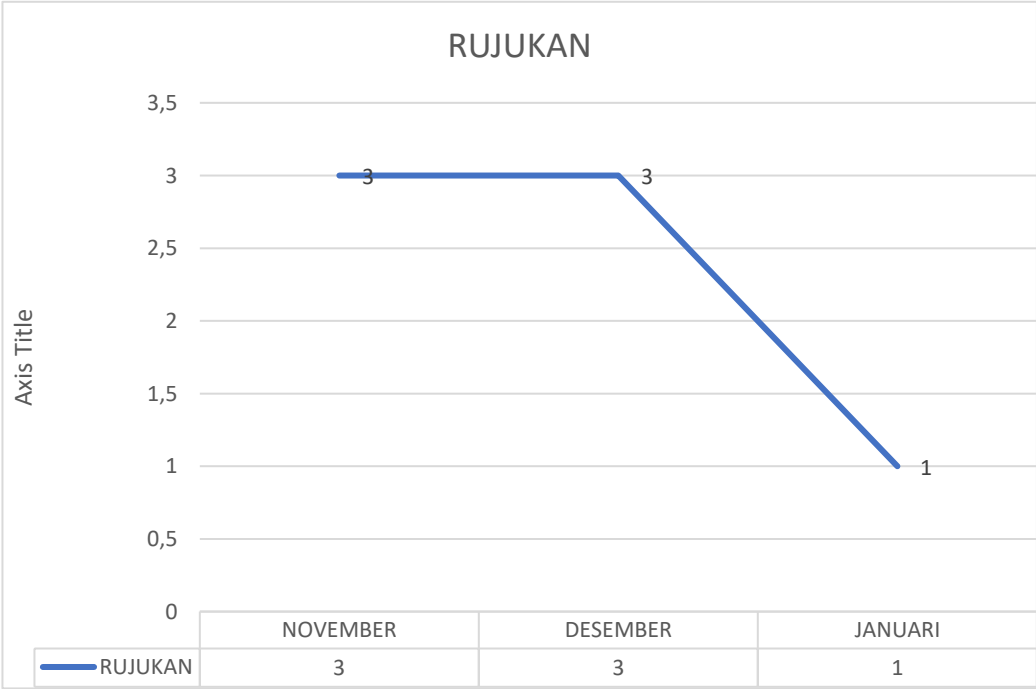
Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusu dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat atautkah tidak.

5. Pelayanan Post Natal Care (PNC)

No	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN NOVEMBER 2024	BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025
1	PNC	90	90	104



No	Pelayanan	JUMLAH			TUJUAN RUJUK
		NOVEMBER	DESEMBER	JANUARI	
1	Rujukan eksternal	3	0	1	RSUD Sidoarjo
TOTAL		4	3	0	

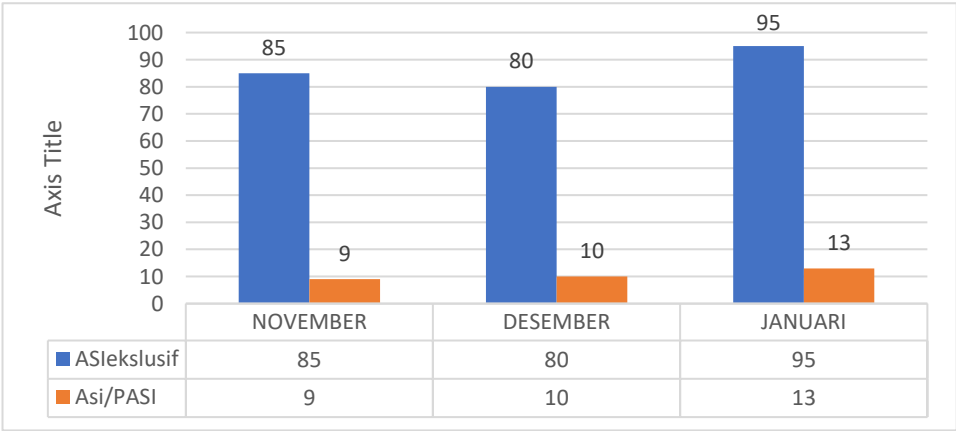


No	Pemberian ASI	JUMLAH PASIEN		
		BULAN NOVEMBER 2024	BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025
1	Asieksklusif	85	80	95
2	Asi /PASI	9	10	13

GRAFIK 7

PELAYANAN PEMBERIAN ASI EKSLUSIF DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

BULAN JANUARI 2025



Evaluasi

1. Terdapat peningkatan pada pelayanan pemberian ASI Eksklusif pada bulan Januari 2025, Hal ini dikarenakan jumlah persalinan pada bulan ini naik
2. Asi/pasi pada bulan ini naik dari bulan sebelumnya. Karena jumlah bayi sakit meningkat dan harus perawatan di ruang perinatologi terlebih dahulu dan sebagian juga disebabkan karena asi ibu masih belum keluar

Rencana dan Tindak Lanjut

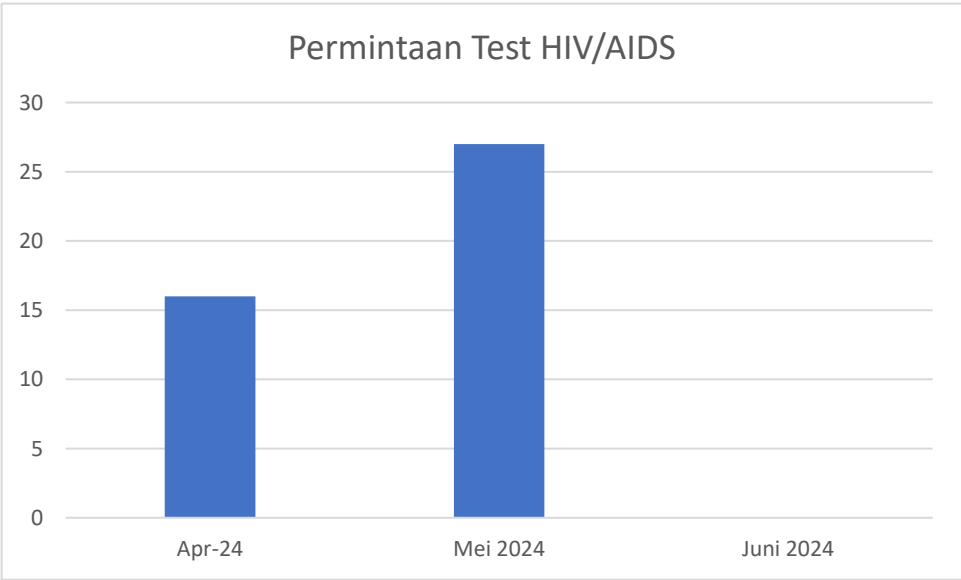
Dilakukan Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumahsakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI ekslusi

3.6.4.2 HIV

1. Jumlah permintaan Tes HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		Juli	Agustus	September
1	Permintaan Test HIV/AIDS	16	27	0

GRAFIK 1
 JUMLAH PERMINTAAN TEST HIV DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
 BULAN MEI 2024



Analisis Jumlah Permintaan Test HIV/AIDS:

Pada bulan April 2024 terdapat 16 permintaan testing HIV/AIDS. Pada bulan Mei 2024 terdapat 27 permintaan testing HIV/AIDS.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien.
- Melakukan edukasi kepada pasien hamil untuk pemeriksaan ANC.
- Melakukan edukasi kepada pasien dengan populasi kunci seperti WPS, waria, LSL dan penasun.
- Melakukan edukasi untuk tes HIV/AIDS pada pasien TB, pasien hepatitis, wargabinaan pemasyarakatan (WBP), pasien IMS, pasangan tetap ataupun tidak tetap ODHA.
- Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pasien TB yang status HIV nya tidak diketahui
- Melakukan edukasi dan sosialisasi terduga TB yang status HIV nya tidak diketahui.

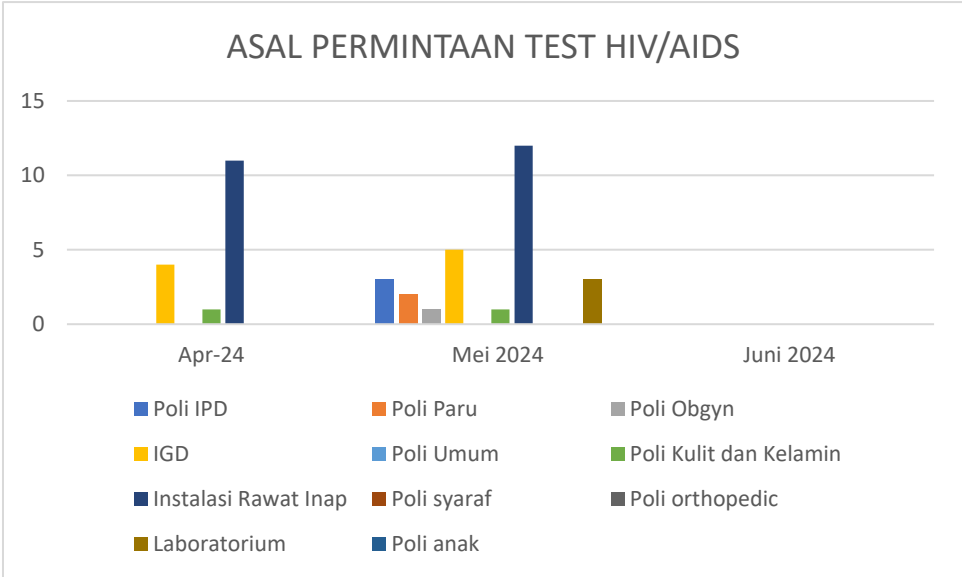
2. ASAL PERMINTAAN TES HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		Juli	Agustus	September
1	Poli IPD	0	3	0
2	Poli Paru	0	2	0

3	Poli Obgyn	0	1	0
4	IGD	4	5	0
5	Poli Umum	0	0	0
6	Poli Kulit dan Kelamin	1	1	0
7	Instalasi Rawat Inap	11	12	0
8	Poli syaraf	0	0	0
9	Poli orthopedic	0	0	0
10	Laboratorium	0	3	0
11	Poli anak	0	0	0

GRAFIK 2

JUMLAH ASAL PERMINTAAN TEST HIV/AIDS



Analisis Asal Permintaan Tes HIV/AIDS
 Kenaikan permintaan test HIV/AIDS terdapat di IGD pada bulan Mei 2024.

Rencana dan Tindak Lanjut:

- Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien.
- Melakukan edukasi kepada pasien hamil untuk pemeriksaan ANC.
- Melakukan edukasi kepada pasien dengan populasi kunci seperti WPS, waria, LSL dan penasun.
- Melakukan edukasi untuk tes HIV/AIDS pada pasien TB, pasien hepatitis, wargabinaan pemasyarakatan (WBP), pasien IMS, pasangan tetap ataupun tidak tetap ODHA.

3.7 Permasalahan Rumah Sakit Rumah Sakit

1. Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

No	Permasalahan	Analisa	
1	Maish ditemukan operasi HARUM Pen Kurang safty	P	- Memberikan informasi kepadl unit pelayanan iko Memberikan sosialisasi kepada semua staf IKO untuk mengingatkan jika ada terjadi percikan listrik di Harum pen - Melakukan koordinasi dengan kabit penunjang dan gudang farmasi
		D	- Memberikan informasi kepadl unit pelayanan iko Memberikan sosialisasi kepada semua staf IKO untuk mengingatkan jika ada terjadi percikan listrik di Harum pen - Melakukan koordinasi dengan kabit gugang farmasi
		S	monitoring dan evaluasi
		A	- Informasi kepada semua unit pelayanan unit iko jika terjadi percikan listrik segera hentikan dan ganti counter baru - sosialisasi kepada staf IKO untuk mentaati SOP yang berlaku - Melakukan koordinasi dengan kabit dan gudang

2. Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

No	Permasalahan	Analisa	
1	Ketidakpatuhan staf IGD dalam handover dimana masih ditemukan pasien dan RM di tranfer namun tidak segera melakukan handover dengan kurun waktu lebih dari 30 menit	P	- Mengingatkan staf agar melakukan handover tepat waktu pada - Melakukan koordinasi dengan karu untuk sosialisasi ulang ketepatan waktu handover kepada semua staf - Melakukan koordinasi dengan kabit kep dan pelayanan
		D	- Informasi kepada staf terkait untuk handover tepat waktu - Koordinasi dengan karu untuk sosialisai ulang ketepatan waktu handover kepada semua staf - Koordinasi dengan kabit kep dan pelayanan
		S	Monitoring dan evaluasi
		A	- Informasi kepada staf terkait untuk handover tepat waktu - Koordinasi dengan karu untuk sosialisai ulang ketepatan waktu handover kepada semua staf - Koordinasi dengan kabit kep dan pelayanan
2	Pengisian ERM yang tidak lengkap sehingga menjal PR yang berhungan dengan klaim mengakibatkan buka billing pada saat mendekati klaim dan mengakibatkan pembuatan kronoligo oleh staff tersebut.	P	- Mengingatkan kepada staff untuk disiplin pengisian ERM - Koordinasi ke karu apabila belum paham terkait ERM (staff baru)
		D	- Informasi kepada staff terkait pengisian erm yang lengkap - Sosialisai terkait pengisian ERM kepada anak baru
		S	Monitoring dan evaluasi

		A	Informasi kepada staff terkait pengisian ERM
3	Ketidaktepatan dokter IGD dalam proses konsul ke DPJP yang tidak membalas sehingga menunggu balasan DPJP yang mengakibatkan delay jawaban konsulan	P	Mengingatkan kepada staff untuk konsul ke DPJP sesuai dengan SPO
		D	Rivew ulang kepada staff dan dokter IGD dengan adanya SPO Baru
		S	Monitoring dan evaluasi
		A	Informasi terkait SPO lebih di pahami

3. Permasalahan Maternitas

No	Permasalahan	Analisa	
1	Ketersediaan BE sesuai dengan kegawatan maternal belum sesuai	P	1. Melakukan pendataan obat-obat emergency maternal apa saja yang sering di butuhkan 2. Melakukan koordinasi dengan farmasi untuk menambahkan obat kegawatan maternal pada BE 3. Melakukan Koordinasi dengan kbid pelayanan dan penunjang
		D	1. Pendataan obat-obat emergency pada kasus maternal yang sering di butuhkan 2. Koordinasi dengan farmasi untuk menambahkan obat kegawatan maternal pada BE 3. Koordinasi dengan kbid pelayanan dan penunjang
		S	Monitoring dan evaluasi
		A	1. Pendataan obat-obat emergency pada kasus maternal yang sering di butuhkan 2. Koordinasi dengan farmasi untuk menambahkan obat kegawatan maternal pada BE 3. Koordinasi dengan kbid pelayanan dan penunjang
2	Bidan baru masih tidak boleh jaga malam karena SIP tidak kunjung jadi, sedang pengurusan SIP sekarang sulit	P	1. Melakukan koordinasi dengan SDM 2. Melakukan Koordinasi dengan SDM terkait satu sehat SDM 3. Melakukan koordinasi dengan kbid yanmed
		D	1. Kordinasi dengan SDM 2. Koordinasi dengan SDM terkait satu sehat SDM 3. Koordinasi dengan kbid

4. Permasalahan Neonatologi

No	Masalah	Tindak Lanjut	
1.	Belum terpenuhi alat suction di ruang ponek IGD	P	1. Melakukan koordinasi dengan Karu IGD dan Kbid Pelayanan terkait ketersediaan alat suction 2. Melakukan FU berkala terkait ketersediaan alat suction
		D	1. Koordinasi dengan Karu IGD dan Kbid Pelayanan untuk kesediaan alat suction 2. FU berkala terkait ketersediaan alat suction
		S	Monitoring evaluasi
		A	1. Melakukan koordinasi dengan Karu IGD dan Kbid Pelayanan terkait ketersediaan alat suction 2. Melakukan FU berkala terkait ketersediaan alat suction

5. Permasalahan NICU

No	Permasalahan	Analisa	
1	Belum terpenuhi alat suction di ruang ponok IGD sehingga jika ada persalinan di IGD masih memakai punya NICU	P	1. Melakukan koordinasi dengan Karu IGD dan Kabid Pelayanan terkait ketersediaan alat suction 2. Melakukan FU berkala terkait ketersediaan alat suction
		D	1. Koordinasi dengan Karu IGD dan Kabid Pelayanan untuk kesediaan alat suction 2. FU berkala terkait ketersediaan alat suction
		S	Monitoring evaluasi
		A	1. Melakukan koordinasi dengan Karu IGD dan Kabid Pelayanan terkait ketersediaan alat suction 2. Melakukan FU berkala terkait ketersediaan alat suction

5. Permasalahan ICU

No	Permasalahan	Analisa	
1	Ketidakpatuhan DPJP untuk membacakan hasil ECG sehingga mempengaruhi proses klaim	P	1. Melakukan pendataan berapa DPJP yang tidak patuh akan aturan pembacaan ECG 2. Mengingatkan DPJP untuk membacakan hasil ECG pada saat visite pertamakali 3. Melakukan koordinasi dengan dr ruangan apabila sampai pasien KRS belum ada bacaan ECG, agar dr ruangan yang membacakan hasil ECG 4. Melakukan koordinasi dengan kabid yanmed untuk mengevaluasi DPJP terkait
		D	1. Pendataan oleh Karu berapa DPJP yang tidak patuh akan aturan pembacaan ECG 2. Komunikasi dengan DPJP untuk membacakan hasil ECG pada saat visite pertamakali 3. Koordinasi dengan dr ruangan apabila sampai pasien KRS belum ada bacaan ECG, agar dr ruangan yang membacakan hasil ECG 4. Koordinasi dengan kabid yanmed untuk mengevaluasi DPJP terkait
		S	Monitoring evaluasi
		A	1. Pendataan oleh Karu berapa DPJP yang tidak patuh akan aturan pembacaan ECG 2. Komunikasi dengan DPJP untuk membacakan hasil ECG pada saat visite pertamakali 3. Koordinasi dengan dr ruangan apabila sampai pasien KRS belum

			ada bacaan ECG, agar dr ruangan yang membacakan hasil ECG 4. Koordinasi dengan kbid yanmed untuk mengevaluasi DPJP terkait
2	Ketersediaan tempat skoret untuk petugas perawat yang tindakan di ruang icu iso TB sehingga skoret tergantung dan bekas masker tidak ada tempatnya	P	Melakukan Pendataan terkait penggunaan skoret yang digunakan oleh perawat setiap ke pasien dan penggunaan masker
		D	Koordinasi dengan karu dan tim PPI untuk terkait penyimpanan skoret dan masker sehingga tertata rapi
		S	Monitoring Evaluasi
		A	Koordinasi dengan PPI terkait penambahan nakas atau almari kecil untuk penyimpanan skoret
3.	Ruang tunggu keluarga pasien ICU masih didepan ruang IRNA 3A	P	1. Melakukan koordinasi dengan kbid pelayanan mengenai ruang tunggu keluarga pasien ICU 2. Menyediakan ruang tunggu khusus untuk keluarga pasien ICU
		D	1. Koordinasi dengan kbid pelayanan mengenai ruang tunggu keluarga pasien ICU 2. Adanya ruang tunggu khusus untuk keluarga pasien ICU
		S	Monitoring evaluasi
		A	1. Koordinasi dengan kbid pelayanan mengenai ruang tunggu keluarga pasien ICU 2. Adanya ruang tunggu khusus untuk keluarga pasien ICU

6. Permasalahan Rawat Inap

No	Unit	Permasalahan	Analisa
1	2A	Ketidaktersediaan kulkas penyimpanan obat di unit mengakibatkan adanya penitipan obat di kulkas farmasi, dimana kebanyakan obat lupa untuk diambil dan di retur sehingga hal ini dapat mengakibatkan selisih.	P 1. Melakukan pendataan berapa obat yang tidak terambil pada kulkas farmasi. 2. Melakukan pendataan berapa banyak obat yang memerlukan penyimpanan di kulkas. 3. Melakukan koordinasi dengan direksi untuk pemenuhan kulkas di unit. 4. Melakukan edukasi kepada semua staf unit Irna 2 agar menggunakan kulkas sesuai peruntukannya (penyimpanan obat)



			D	1. Pendataan berapa obat yang tidak terambil pada kulkas farmasi. 2. Pendataan berapa banyak obat yang memerlukan penyimpanan di kulkas. 3. Koordinasi dengan direksi untuk pemenuhan kulkas di unit. 4. Edukasi kepada semua staf unit Irna 2 agar menggunakan kulkas sesuai peruntukannya (penyimpanan obat)
			S	Monitoring evaluasi
			A	1. Pendataan berapa obat yang tidak terambil pada kulkas farmasi. 2. Pendataan berapa banyak obat yang memerlukan penyimpanan di kulkas. 3. Koordinasi dengan direksi untuk pemenuhan kulkas di unit. 4. Edukasi kepada semua staf unit Irna 2 agar menggunakan kulkas sesuai peruntukannya (penyimpanan obat)
2	2B	Ketidakpatuhan staf dalam penginputan Tindakan mengakibatkan tingginya kasus open billing.	P	1. Melakukan sosialisasi ulang pada semua staf terkait kepatuhan penginputan di SIMRS. 2. Melakukan double cek mulai dari pendamping visite, PPJA dan di final cek oleh PJ krs setiap sif nya. 3. Melakukan evaluasi kinerja pada staf terkait. 4. Melakukan koordinasi dengan kabid pelayanan dan keperawatan terkait open billing.
			D	1. Sosialisasi ulang pada semua staf terkait kepatuhan penginputan di SIMRS. 2. Lakukan double cek mulai dari pendamping visite, PPJA dan di final cek oleh PJ Krs setiap sif nya. 3. Evaluasi kinerja pada staf yang terlibat kasus open billing. 4. Koordinasi dengan kabid pelayanan dan keperawatan terkait open billing.
			S	Monitoring dan evaluasi
			A	1. Sosialisasi ulang pada semua staf terkait kepatuhan penginputan di SIMRS.



				- Lakukan double cek mulai dari pendamping visite, PPJA dan di final cek oleh PJ Krs setiap sif nya. - Evaluasi kinerja pada staf yang terlibat kasus open billing. - Koordinasi dengan kabid pelayanan dan keperawatan terkait open billing.
3	3A	Kurangnya kepedulian dari unit terhadap perawatan playground.	P	- Melakukan pendataan kelengkapan playground - Melakukan koordinasi dengan staf unit 3a terkait penemuan kerusakan atau kehilangan dari kelengkapan playground - Melakukan komunikasi dengan unit dengan unit CS terkait pembersihan - Melakukan koordinasi dengan direksi terkait kesusakan, kehilangan, dan perawatan playground
			D	- Pendataan kelengkapan playground - Koordinasi dengan staf unit 3a terkait penemuan kerusakan atau kehilangan - Komunikasi dengan unit CS terkait pembersihan - Koordinasi dengan direksi terkait kerusakan, kehilangan, dan perawatan playground
			S	Monitoring dan evaluasi
			A	- Pendataan kelengkapan playground - Koordinasi dengan staf unit 3a terkait penemuan kerusakan atau kehilangan - Komunikasi dengan CS terkait pembersihan - Koordinasi dengan direksi terkait kerusakan, kehilangan dan perawatan playground.
3	3B	Pembagian job desk oleh katim belum berjalan maximal.	P	- Melakukan koordinasi dengan Katim dalam pembagian tugas setiap shift. - Melakukan koordinasi dengan Katim untuk pembagian PPJA sesuai dengan ruangan pasien. - Melakukan evaluasi pelaksanaan MAKP metode Tim. - Melakukan koordinasi dengan kabid pelayanan dan keperawatan.
			D	- Koordinasi dengan Katim dalam pembagian tugas setiap shift. - Koordinasi dengan Katim untuk pembagian PPJA

				sesuai dengan ruang an pasien. 3. Evaluasi pelaksanaan MAKP metode Tim di unit. 4. Koordinasi dengan kabid pelayanan dan keperawatan.
			S	Monitoring dan evaluasi
			A	1. Koordinasi dengan Katim dalam pembagian tugas setiap shift. 2. Koordinasi dengan Katim untuk pembagian PPJA sesuai dengan ruang an pasien. 3. Evaluasi pelaksanaan MAKP metode Tim di unit. Koordinasi dengan kabid pelayanan dan keperawatan.

1. Permasalahan Rawat Jalan

No	Permasalahan	Analisa
1	Belum tersedianya alat pembuka gips mengakibatkan kesulitan Tindakan di poli orthopedi.	P 1. Melakukan pendataan intensitas Tindakan pembukaan gips setiap bulan nya di poli orthopedi. 2. Melakukan pembuatan SP alat pembuka gips. 3. Melakukan koordinasi dengan kabid pelayanan terkait pengajuan alat tersebut. D 1. Pendataan intensitas Tindakan pembukaan gips setiap bulan. 2. Pembuatan SP alat pembuka gips. 3. Koordinasi dengan kabid pelayanan terkait pengajuan alat. S Monitoring evaluasi A Konfirmasi ke pada pihak pengadaan ulang
2	Pasien dr camelia sp Pd komplain di karenakan belum di panggil (sudah di TL ternyata pasien terlambat datang, dr camelia memanggil melewati beberapa pasien)	P 1. Melakukan KIE ke pasien/keluarga jika waktunya Kontrol datang tepat waktu. 2. Melakukan koordinasi dengan asisten untuk memanggil ulang pasien2 yag belum datang tapi sudah ada di billing sesuai nomer antrian. D 1. KIE ke pasien/keluarga jika waktunya Kontrol datang tepat waktu. 2. Koordinasi dengan asisten untuk memanggil ulang pasien2 yang belum datang tapi sudah ada di billing sesuai nomer antrian. S Monitoring evaluasi A 1. Melakukan KIE ke pasien/keluarga jika waktunya Kontrol datang tepat waktu. 2. Melakukan koordinasi dengan asisten untuk memanggil ulang pasien2 yag belum datang tapi sudah ada di billing sesuai nomer antrian.

2. Permasalahan Farmasi

No	Kegiatan Pokok	Analisa	Tindak Lanjut
1	STOK OPNAME	DEPO FARMASI 1) Terdapat selisih karena salah input pada so bulan desember 2024 : - Hydroxychloroquin tab – yarindo (F00373) salah input ke Hydroxychloroquin tab (F04500) - Zidovudine/Lamivudine terinput dobel di master barang Lamivudine tab 150 mg (F00427) dan zidovudine / Lamivudine (F00848) 2) F01529 KASA STERIL 16X 16 CM – NASACO, belum ada rak depo 3) Selisih stok opname a. F00035 AMPLODIPIN TAB 10 MG HJ terdapat selisih lebih 1003 dikarenakan kurang telitnya perhitungan buffer. b. F00087 BISOPROLOL TAB 5MG Terdapat selisih lebih 508 c. F00163 CEFTRIAXONE INJ 1 G – BERNOFARM Terdapat selisih lebih 105 tab d. F01426 Handscoon Non Steril M Terdapat selisih kurang 163 pcs e. F02350 MASKER TALI – ONEMED Terdapat selisih kurang 269 pcs f. F01986 Sput 10 CC – GIDCARE Terdapat selisih 264 pcs g. F01991 Sput 3 CC terdapat selisih lebih 169 pcs h. F01990 Sput 3 CC terdapat selisih lebih 394 pcs i. F00013 ADALAT OROS TAB 30 MG terdapat selisih lebih 209 tab F00529 NITROKAF RETARD FORTE CAPS 5 MG – Terdapat selisih lebih 126 tab	1. Pada saat proses verifikasi akhir stock opname harus dilakukan double crosscheck oleh petugas farmasi agar tidak terjadi dobel input master barang 2. Koordinasi dengan Pengadaan PT untuk penambahan rak Depo Farmasi pada master barang 3. Penataan barang dan buffer saat perhitungan stok opname harus lebih teliti dan rapi dalam pelabelan obat 4. Penulisan kartu stock sudah berjalan akan tetapi belum maksimal masih belum bisa dijadikan sebagai data pembanding Analisa stock opname
		GUDANG FARMASI 1. Terdapat sediaan ED dekat F00333 Gabaxa Inf 200 MG/ML ED 30/03/2025 sebanyak 7 Vial 2. Kartu Stock berjalan 3. Tidak ada selisih stok, sudah dilakukan random cek pada beberapa sediaan dan alkes > cocok dan sesuai dengan kartu stok	1. Sudah proses retur ke distributor (nota retur terlampir)

		DEPO IGD/IKO B. Master Barang Asam mefenamat HJ sudah dinon aktifkan tetapi fisik barang terdapat 10 tablet. C. Terdapat banyak selisih lebih pada Alkes Handscoon & Nurse Cap (dikarenakan template pada paket SC tidak sesuai dengan list fisik paket). D. Terdapat selisih kurang masker tali sejumlah 1024 pcs & Masker karet 165 pcs (dikarenakan fisik diberikan kepada perawat tetapi ditemplate pakatnya berbeda / belum terupdate).	1. Indikasi retur barang unit, sebelum pergantian obat gudang farmasi wajib mengecek sisa stok obat agar dihabiskan terlebih dahulu 2. Sudah dilakukan perbaikan template paket SC di SIMRS
2	Klaim Obat kronis	Pengajuan klaim obat apotek online bulan Januari 2025 sudah siap diproses menunggu konfirmasi dari Verifikator.	Berkordinasi dengan unit Verifikator dalam proses pengajuan klaim obat kronis (tanggal pengajuan).
4	Program BPJS	Total ITERISASI pada akhir bulan Januari 2025 didapatkan hasil sejumlah 263 pasien dari jumlah target per bulan dan telah memenuhi target iterisasi 100 pasien/bulan.	Lebih ditingkatkan ketelitian dari petugas input farmasi untuk melakukan centang iterisasi pada apotek online.
5	Obat Pasien Rawat Jalan Tertinggal	1. Obat pulang tidak di ambil pasien dilakukan retur sesuai fitur SIMRS maksimal tanggal 20 di bulan berjalan. 2. Jumlah obat tertinggal masih terdapat penurunan dari bulan sebelumnya	1. Dilakukan retur obat yang tidak diambil pasien ke gudang farmasi 2. Menghubungi pasien untuk mengambil obat ke farmasi 2x dan menawarkan jasa kirim Beetu
6	Pengembangan Kompetensi	Peningkatan Kompetensi (Seminar/Workshop) salah satu staff pada bulan Januari mengikuti pelatihan jurnalistik oleh Radar Malang	Mencari referensi (Seminar/Workshop) terkait kefarmasian untuk pengembangan kompetensi.
7	Promosi Kegiatan Rumah Sakit	Kegiatan PKRS sosialisasi kelompok masih belum sesuai target pada bulan ini edukasi kelompok hanya dilakukan 3x dari target 8x/bulan.	Melakukan penjadwalan ulang dengan disesuaikan jumlah staff yang berjaga.
8	Rapat Bulanan Unit	Rapat Bulanan Dilakukan di depo Farmasi telah dilakukan pada tanggal 15 Januari 2025	Umandok sudah dilaporkan kepada Seketariat, Kabid dan Direktur.
9	Waktu tggu farmasi	antrian waktu tunggu farmasi yang memanjang pada bulan sebelumnya yaitu hal ini dikarenakan pada SIM RS tidak dilakukan klik selesai saat selesai melayani resep, namun sebelumnya petugas melakukan klik ambil obat Dimana membuat waktu tunggu pelayanan farmasi menjadi memanjang	Dilakukan pengklikan obat selesai pada sim RS dan akan dilakukan evaluasi pada bulan serikutnya



1.9 Kinerja Produktifitas Profil SDM

1.9.1 Ketenagaan

Distribusi SDM

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
1	Direktur	S2 Kesehatan	1	1	0	0	1	0	0	1
2	Kepala Bidang Pelayanan Medis	S2 Kesehatan	1	1	0	0	1	0	0	1
3	Kepala Bidang Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	0	1	0	0	1
4	Kepala Bidang Penunjang Medis	S1 Kesehatan	1	1	0	0	1	0	0	1
5	PLT Kepala Bidang Umum & Keuangan	S1 Kesehatan	1	1	0	0	1	0	0	1
6	Staf Medis	Dokter Umum IGD	9	9	0	9	0	1	1	70
		Dokter Umum MCU	7	6	0	6	0	0	1	
		Dokter Gigi	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Emergency	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Anak	4	4	0	3	1	0	0	
		Dokter Spesialis Penyakit Dalam	6	6	0	6	0	0	0	
		Dokter Spesialis Obsetri dan Ginekologi	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah	4	4	0	4	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah Anak	1	0	1	0	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah Syaraf	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah Plastik	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis Neurologi	4	4	0	4	0	1	0	
		Dokter Spesialis	2	2	0	2	0	0	0	



No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
		Paru								
		Dokter Spesialis Mata	3	3	0	2	1	0	0	
		Dokter Spesialis Kulit Kelamin	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis THT	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Urologi	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Konservasi Gigi	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Gigi Anak	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Radiologi	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Anestesiologi	3	3	0	3	0	0	0	
7	IRNA II A	D3 Keperawatan	26	14	0	2	9	0	0	26
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		12	0	10	2	0	0	
8	IRNA II B	D3 Keperawatan	27	13	0	13	0	0	0	25
		D4 Keperawatan		1	0	1	0	0	0	
		Profesi Ners		11	0	8	3	0	0	
9	IRNA III A	D3 Keperawatan	22	13	0	4	9	0	0	21
		D4		0	0	0	0	0	0	

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
		Keperawatan								
		Profesi Ners		8	0	5	3	0	0	
10	IRNA III B	D3 Keperawatan	18	2	0	1	1	0	1	17
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		15	0	12	3	0	0	
11	Neonatologi	D3 Keperawatan	4	2	0	1	1	0	0	4
		S1 Kebidanan		0	0	0	0	0	0	
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		2	0	2	0	0	0	
12	Maternitas	D3 Kebidanan	14	3	0	0	3	0	0	14
		D4 Kebidanan		9	0	2	7	0	0	
		S1 Kebidanan		2	0	0	2	0	0	
13	ICU	D3 Keperawatan	12	4	0	1	3	0	0	12
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		8	0	2	6	0	0	
14	NICU	D3 Keperawatan	9	5	0	1	4	0	0	9
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		4	0	0	4	0	0	
15	IGD	D3 Keperawatan	28	9	0	3	6	0	0	26
		D3 Kebidanan		3	0	1	2	0	0	
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		D4 Kebidanan		2	0	1	1	0	0	
		Profesi Ners		12	1	9	3	0	0	
		S1 Kebidanan		0	0	0	0	0	0	
16	IKO	D3 Keperawatan	13	10	0	6	4	0	0	13
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		3	2	1	2	0	0	
17	IRJA	D3 Keperawatan	27	14	0	2	12	0	0	25
		D3 Kebidanan		1	0	0	1	0	0	
		D4 Keperawatan		1	0	1	0	0	0	
		D4 Kebidanan		1	0	0	1	0	0	
		S1 Kebidanan		1	1	0	1	0	0	
		Profesi Ners		7	0	5	2	1	0	
18	Rehab Medik	D3 Fisioterapi	5	1	0	1	0	0	0	5

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
		D4/S1 Fisioterapi		4	0	4	0	0	0	
19	HD	D3 Keperawatan	5	2	0	0	2	0	0	5
		S1 Profesi Ners		3	0	1	2	0	0	
20	Perawat MCU & Klinik Perusahaan	D3 Keperawatan	9	7	0	6	1	0	0	9
		S1 Profesi Ners		2	0	2	0	0	0	
		S2 Psikolog	1	1	0	1	0	0	0	1
21	Farmasi	SMA/ SMK Farmasi	3	3	0	2	1	0	0	46
		S1 Admin Farmasi	2	2	0	1	1	0	0	
		D3 Farmasi	24	23	0	17	5	2	2	
		D3 Analis Farmasi	1	1	0	1	0	0	0	
		S1 Farmasi	4	4	0	4	0	0	0	
		Apoteker	12	12	0	5	7	0	0	
22	Rekam Medis	D3 RMIK	10	9	0	6	3	0	0	10
		D4 RMIK		1	2	0	1	0	0	
23	Pendaftaran	SMA/SMK	18	1	0	0	3	2	0	19
		D1		1	0	1	0	0	0	
		D3		7	0	3	4	0	0	
		D4		2	0	1	1	0	0	
		S1		7	0	4	3	0	0	
24	Laboratorium	D3 Analis Kesehatan	12	10	0	2	8	0	0	12
		D4 Analis Kesehatan		2	0	1	1	0	0	
25	Radiologi	SMA/SMK	8	0	0	0	0	0	0	7
		D3 Radiologi		7	1	5	2	0	0	
26	CSSD	SMA/SMK	4	3	0	1	2	0	0	4
		D3 Keperawatan		1	0	1	0	0	0	
		S1 Keperawatan		0	0	0	1	0	0	
27	Laundry	SMA/SMK	6	5	0	2	3	0	0	6
		D1		1	0	1	0	0	0	
28	Ahli Gizi	D3 Gizi	5	3	0	3	0	0	0	6
		D4 Gizi		2	0	0	2	0	0	
		S1 Gizi		1	0	0	1	0	0	
29	Dapur & Pantry	SMA/SMK	15	15	0	6	9	0	0	15
30	Keuangan & Akuntansi	SMA/SMK	10	0	0	0	0	0	0	10
		D1		1	0	0	1	0	0	



No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
		D3		0	0	0	0	0	0	
		S1		9	0	2	7	0	0	
31	SDM & Diklat	S1 Psikologi	2	1	0	1	0	0	0	2
		S1 Manajemen		0	0	0	0	0	0	
		S1 Kesehatan		1	0	0	1	0	0	
		S1 Lainnya		0	0	0	0	0	0	
32	Asuransi Center	SMA/SMK	13	0	0	0	0	0	0	13
		D3 RMIK		7	0	5	2	0	0	
		D3 Asuransi Kesehatan		0	0	0	0	0	0	
		D4 RMIK		1	0	0	1	0	0	
		D4 Asuransi Kesehatn		1	0	0	1	0	0	
		S1 Kesehatan / Lainnya		4	0	1	3	0	0	
33	Humas Marketing	S2 Manajemen Kesehatan	1	0	0	0	0	0	1	0
		S1 Marketing		0	0	0	0	0	0	
		D3 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		S1 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
34	Sekretariat	S1	1	1	0	0	1	0	0	1
35	Security	SMA/SMK	11	11	0	4	7	0	0	11
36	Parkir	SMA/SMK	12	11	0	11	0	0	0	12
		S1 Lainnya		1	0	1	0	0	0	
37	Driver	SMA/SMK	7	7	0	0	7	0	0	7
38	Cleaning Service	SMA/SMK	42	40	0	13	28	1	0	42
		D3		1	0	0	1	0	0	
39	Tukang Kebun PHL	SMA/SMK	3	1	0	0	1	0	0	3
		SMP		2	0	2	0	0	0	
		SD		0	0	0	0	0	0	
40	IPSRs	SMA/SMK	4	4	0	3	1	0	0	6
		D3 ATEM	2	2	0	2	0	0	0	
		Admin IPSRS	0	0	0	0	0	0	0	
41	Gudang Umum	S1	1	1	0	0	1	0	0	1
42	IT & SIMRS	D4 Teknologi Informasi	3	0	0	0	0	0	0	3
		S1 Teknologi Informatika		2	0	2	0	0	0	
		S1 Lainnya		1	0	0	1	0	0	
43	PKRS	DIV Promosi Kesehatan	1	1	0	1	0	0	0	1
44	Mutu	S1 Kesehatan	1	1	0	1	0	0	0	1



No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
		Masyarakat								
45	PPI	S1 Profesi Keperawatan	1	1	0	0	1			
46	K3RS	S1 Kesehatan Masyarakat	1	1	0	0	1	0	0	1
47	MOD/MPP	D3 Keperawatan	5	2	0	0	2	0	0	5
		D3 Kebidanan		1	0	0	1	0	0	
		D4 Kebidanan		1	0	0	1	0	0	
		Profesi Ners		1	0	0	1	0	0	
		S1 Kebidanan		0	0	0	0	0	0	
TOTAL			541	527	14	292	235	8	6	527

Keterangan : Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Bulan Juni 2025 terdapat jumlah staf sebanyak 527 orang dari total kebutuhan sejumlah 541 orang. Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah kekurangan staf sejumlah 14 orang dengan jumlah staf resign sejumlah 6 orang dari 1 dokter Umum IGD, 1 Dokter Umum klinik Perusahaan, 1 orang perawat, 1 orang staf humas & marketing dan 2 orang staf TTK. Selain 6 orang staf yang resign pada Bulan Juni 2025, terdapat 2 tenaga medis baru yaitu 1 orang dokter spesialis anak dan 1 orang dokter umum IGD, 2 staf pendaftaran mutasi dari RS Prima Husada Malang, 1 staf cleaning service mutasi dari RS Prima Husada Malang, 1 orang staf perawat dan 2 orang staf TTK.

Update SIP dan NED 6 Bulan

No.	Nama	Profesi	Nomor SIP	Tanggal Berlaku SIP	Tgl Masa Berlaku
Proses					
1	Avivatul Khoiroh, S.Farm., Apt	Apoteker	NR35142506000054	02 Juni 2025	06 Maret 2029
2	Sinta Dewi Novitasari, Amd. Farm	TTK	NR35142506000053	02 Juni 2025	09 November 2030
3	Nurfitriyani, A.Md.Farm	TTK	NR35142506004273	10 Juni 2025	07 Juni 2030
4	dr. Nurdiana Rahmadani	Dokter Umum	MR35142506013266	26 Juni 2025	23 Juni 2030
Masa Berlaku Kurang dari 6 Bulan					
1	dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp.OT.	Dokter Spesialis Ortopedi	46/SIP-DS/20/424.072/2020	09 April 2020	09 Oktober 2025
2	dr. Ariananto Prabowo, Sp. OT	Dokter Spesialis Ortopedi	46/SIP-DS/39/424.072/2020	30 Juni 2020	08 November 2025
3	dr. Rudi Priyo Utomo, Sp. OG	Dokter Spesialis Obgyn	46/SIP-DS/11/424.072/2021	19 Februari 2021	09 Desember 2025
4	Fiski Purantoro, Sp.OT	Dokter Spesialis Ortopedi	46/SIP-DS/75/424.072/2022	3 Juni 2022	12 Desember 2025
5	dr. Ferry Limantara, Sp.EM	Dokter Spesialis Emergency	46/SIP-DS/27/424.072/2021	13 April 2021	14 Januari 2026
6	Yekti Mumpuni, Sp.KJ.	Dokter Spesialis Jiwa	46/SIP-DS/59/424.072/2020	10 November 2020	13 Januari 2026



No.	Nama	Profesi	Nomor SIP	Tanggal Berlaku SIP	Masa Berlaku
7	Zjakiatul Wahyuning Rima, Amd. Kep	Perawat	446/SIP/346/424.072/2020	7 Desember 2020	8 September 2025
8	Alief Banat Amanda, S.Tr.Keb	Bidan	446/SIK-B/030/424.072/2021	25 Maret 2021	8 September 2025
9	Muhammad Bagus Khafidti, Amd Kep	Perawat	03/023/SIP-P/II/424.086/2022	28 Januari 2022	Oktober 2025
10	Lillo Palupi Armaidah, A.Md.Kep	Perawat	446/SIK-P/103/424.072/2021	15 Februari 2021	Oktober 2025
11	Robikatul Adawiyah, A.Md.Keb	Bidan	03/018/SIP-B/II/424.086/2023	17 Januari 2023	Oktober 2025
12	Gilda Fathia Azizi, A.Md.Kep	Perawat	3/690/SIP-P/XII/424.086/2023	2 Desember 2023	02 November 2025
13	Syarif Hidayatullah, A.Md.Kep	Perawat	446/SIK-P/100/424.072/2021	15 Februari 2021	21 November 2025
14	Amilia Dwi Lismawati, A.Md.Farm	TTK	503/013/SIP-TTK/X/424.086/2021	19 Oktober 2021	24 Desember 2025

1.9.2 Pendidikan dan Pelatihan

Pada Bulan Juni Tahun 2025 terdapat 2 diklat yang terlaksana, dengan rincian 2 diklat internal dan 2 diklat eksternal.

Tabel Hasil Pelaksanaan Peningkatan SDM (Diklat) Karyawan di RSPH Sukorejo Bulan Juni Tahun 2025

Diklat Internal

NO	Tema DIKLAT /WS/SE M/WB	Sasaran	JUMLAH PESERTA			Tanggal	Pre tes	Post Tes	Evaluasi Penyelenggaraan diklat (cek list ada nilai standard)	Efektifitas Media	Efektifitas Metode	Sertifikat		Hasil evaluasi dalam kinerja sehari-hari (laporan karu)
			Und	Hadir	Abse							sdh	blm	
	Rawat Luka	Seluruh Perawat dan Bidan	196	94	102	21 Juni 2025			Pesentasi pelaksanaan diklat tersebut sejumlah 47.96%	Praktik	Praktik		√	
	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	Seluruh Staf	463	340	340	23-25 Juni 2025			Pesentasi pelaksanaan diklat tersebut sejumlah 73,43%	Lecture & Praktikum	Presentasi		√	

Diklat Eksternal

No.	Nama Diklat	Tempat	Tanggal Pelaksanaan	Peserta
	Pelatihan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU)	Luring	14 April 2025 – 22 Juli 2025	Roikhatul Jannah, S.Kep., Ns



	Refreshment Training Perawat Hemodialisa di RSUB	Luring	Juni – 17 Juli 2025	Allamul Angga Gilang Nishvu R, S. Kep.,Ns Wijaya Risky Ramadhan, A.Md.Kep Muhammad Galih Adiwibowo, S.Kep.,Ns Linda Saputri., Amd Kep Shenfi Ken Rilla, S.Kep., Ns
--	--	--------	---------------------	---

1.10 Kemajuan Piutang

NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG					JUMLAH PIUTANG
		a	b	c	(a-b-c= d)	e	f	g	(e-f-g=h)	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	Total
	PERIODE JUNI 2025 :															
1	Asuransi	445.038.468	223.584.048	1.713.183	219.741.237	356.262.824	50.593.338	1.448.962	304.220.524	523.961.761	497.632.770	32.713.852	20.868.852	3.343.084	1.081.281	555.639.840
2	Perusahaan	464.031.063	220.158.273	7.161.043	236.711.746	455.553.555	103.264.107	3.732.999	348.556.449	585.268.195	483.186.269	40.084.849	7.816.661	9.484.847	12.278.086	552.850.713
3	Mandiri Inhealth	121.573.787	14.416.745	194.776	107.351.818	20.621.189	-	-	20.621.189	127.973.007	77.235.427	42.368.807	-	-	8.362.934	127.967.168
4	Jasa Raharja	258.868.780	226.165.178	95.160	32.798.762	307.668.739	143.154.191	2	164.514.546	197.313.308	195.344.563	2.029.429	-	-	684.559	198.058.551
5	Kantin	27.245.800	6.024.350	-	21.221.450	2.730.450	-	-	2.730.450	23.951.900	15.036.550	728.650	2.098.000	6.088.700	-	23.951.900
6	BPJS Ketenagakerjaan	1.027.625.359	673.528.030	730	354.098.059	556.119.162	-	-	556.119.162	910.217.221	556.119.162	488.964	332.560.508	1.622.813	19.425.775	910.217.221
									Total Saldo	2.368.685.392	1.824.554.742	118.414.551	363.344.021	20.539.444	41.832.634	2.368.685.392

Piutang Pelayanan Juni 2025 (Belum JT)	1.396.762.320
Piutang Berjalan per 30 Juni 2025	971.923.072
Total	2.368.685.392
Pembayaran per 30 Juni 2025	987.360.230
Saldo Akhir	1.381.325.162

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

RS Prima Husada Sukorejo yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarananya. Letak Geografis yang strategis dekat dengan banyak Perusahaan mengharuskan RS Prima Husada Sukorejo berinovasi memberikan pelayanan yang prima dan diminati kalangan sekitar.

Pemanfaatan Gedung semaksimal mungkin ditujukan untuk dapat memberikan pelayanan yang nyaman untuk Masyarakat daerah Pasuruan. Pemenuhan layanan-layanan Kesehatan juga dijadikan daya Tarik dalam mencapai pasar. Pengembangan layanan penunjang dimaksimalkan untuk menambah daya Tarik rumah sakit.

Penambahan pelayanan juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM yang ada. Melakukan update kebijakan sesuai standart dan peraturan yang terbaru serta pengupayaan berupa refresh pelatihan berkala menjadi agenda rumah sakit. Ketersediaan pemenuhan jabatan diharap akan berdampak positif dalam peningkatan kegiatan supervise berjenjang.

4.2 SARAN

- 4.2.1.1 Meningkatkan pelayanan yang prima kepada stakeholder rumah sakit
- 4.2.1.2 Meningkatkan kepatuhan DPJP terkait peraturan terbaru rumah sakit khususnya yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan
- 4.2.1.3 Meningkatkan dan menambah layanan rumah sakit
- 4.2.1.4 Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Sukorejo

BAB V PENUTUP

Demikian laporan Bulan Juni ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Sukorejo, 10 Juli 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS